

RETTS Version 2025-C

Innehållsförteckning - Kontaktorsaker i nummerordning

Kontaktorsak	ESS	Kontaktorsak	ESS
Förmaksflimmer	1	Stroke, misstanke om	12
Onormal hjärtrytm	1	Dubbelseende - båda ögonen (Binokulär Diplopi)	12
Näsblödning/epistaxis	3	Ledvärk utan trauma	13
Postoperativ tonsillblödning	3	Ryggsmärta utan trauma	14
Blodig upphostning/hemoptys	3	Smärta nacke utan trauma	14
Andningsbesvär/dyspné/andnöd	4	Smärta i bröstryggen utan trauma	14
Hyperventilation	4	Smärta i extremitet	15
Bröstmärta/bröstkorgssmärta	5	Svullnad i extremitet	15
Bröstmärta vid andning	5	Underbensödem	15
Buksmärta	6	Extremitetsbesvär	15
Flanksmärta	6	Smärta vid vattenkastning	16
Magsmärta	6	Blod i urin/hematuri	16
Smärta/svullnad buk	6	Urinretention	16
Smärta/svullnad ljumske	6	Urinvägsproblem	16
Mag-tarmproblem	6	KAD-relaterade problem	16
Blodig kräkning/hematemes	7	Besvär i penis/urinrör	17
Blodig avföring/melena	7	Skrotal svullnad	17
Gastrointestinal blödning	7	Skrotal smärta	17
Symtom från anus och rektum/hemorroider	7	Huvudvärk	19
Rektal böld	7	Neuralgi/nervsmärta	19
Kräkning	8	Medvetandeförlust	20
Diarré	8	Svimning/syncopé	20
Illamående	8	Gynekologiska besvär	21
Epilepsi, känd	9	Postpartum <30 dagar	21
Kramper	9	Högt blodtryck samt gravid	21
Yrsel, balanssvårigheter	11	Underlivsbesvär	21
Facialis pares	12	Vaginal blödning	21
Neurologiskt bortfall/TIA	12	Graviditet	21

RETTS Version 2025-C

Innehållsförteckning - Kontaktorsaker i nummerordning

Kontaktorsak	ESS	Kontaktorsak	ESS
Ascites	29	Hypotermi	35
Gulsot/ikterus	29	Kemisk skada	35
Skada huvud/ansikte/näsa	30	Hypertermi/Värmeslag	35
Tandskada	30	Drunkning/drunkningstillbud	36
Hängning/strykning	30	Dykarsjuka/ dekompressionssjukdom, misstanke om	36
Käkskada	30	Skada öga	37
Skada nacke/hals	30	Ögonskada	37
Skada buk	31	Trauma	38
Skada thorax/rygg	31	Förgiftning/intoxikation	40
Skada könsorgan	31	Toxiska effekter av djur	41
Hematom/svullnad/blåmärke	32	Bett och stick av djur	41
Skrubbsår	32	Stickkada med smittorisk	41
Skärsår	32	Bett av människa	41
Sårskada	32	Sexuellt våld	42
Skada arm/handled	33	Fysisk misshandel	42
Skada axel/nyckelben	33	Allergi	43
Skada hand/finger	33	Exantem/hudutslag/blåmärke	43
Skada knä/underben	34	Läkemedelsreaktion	43
Skada höft/lårben/bäcken	34	Klåda	43
Skada fot/tå	34	Halsont, förkylning	44
Elolycka	35	Blåsor i munnen	44
Köldskada	35	Hosta	44
Brännskada	35	Öronproblem	45
Strålskada	35	Öronvärk	45
Inhalationsskada	35	Främmande kropp i näsa	46
Blixtnedslag	35	Främmande kropp i esofagus eller i magtarmkanalen	46
Frätskada	35	Främmande kropp i öra	46
Toxisk effekt av kolmonoxid	35	Främmande kropp i luftväg	46

RETTS Version 2025-C

Innehållsförteckning - Kontaktorsaker i nummerordning

Kontaktorsak	ESS	Kontaktorsak	ESS
Främmande kropp	46	Operationskomplikation	72
Feber	47	Depressiv episod	80
Lokal infektion i hud inkl. böld/lymfadenit	47	Mani	81
Infektion	47	Hypomani	81
Tandvärk/tandinfektion	47	Ångest	82
Resistent svullnad/knöl på halsen	47	Panikångestsyndrom	82
Sepsis - misstanke om	47	Sömnstörning	83
Högt blodsocker/hyperglykemi	49	Psykotiska symtom	84
Diabetes, känd	49	Missbruk/beroende	85
Lågt blodsocker/hypoglykemi	50	Tremor vid missbruk	85
Addisons sjukdom	51	Självskadebeteende	86
Binjurebarkssvikt, känd	51	Ätstörning	87
Kortisolsvikt	51	Krisreaktion	88
Fallbenägenhet	53	Reaktion på svår stress	88
Ospecifika symtom	53	Demens	89
Högt blodtryck/hypertoni	53	Desorienterad	89
Sjukdomskänsla trötthet	53	Organiska psykiska störningar	89
Intyg	53	Ej akut psykiatrisk problematik	90
PEG-relaterade problem	53	Organisk katatoni	91
Hälsoundersökning	53	Farlighetsbedömning	98
Infektion öga	57	Beteendestörning av utagerande slag	98
Ögonproblem	57	Suicidriskbedömning	99
Ögoninfektion	57	Onormal hjärtrytm	101
Dubbelseende - enskilt öga (Monokulär diplopi)	57	Blodig upphostning/hemoptys	103
Cirkulationsstillestånd	65	Postoperativ tonsillblödning	103
Rekommenderade basprover i RETTS	70	Näsblödning/epistaxis	103
Provsvarsalgoritm i RETTS	70	Andningsbesvär/dyspné/andnöd	104
Gipsproblem	71	Hyperventilation	104

RETTS Version 2025-C

Innehållsförteckning - Kontaktorsaker i nummerordning

Kontaktorsak	ESS	Kontaktorsak	ESS
Bröstmärta vid andning	104	Smärta i extremitet	115
Andningsuppehåll/apné	104	Svullnad i extremitet	115
Bröstmärta/bröstkorgssmärta	105	Extremitetsbesvär	115
Buksmärta	106	Blod i urin/hematuri	116
Flanksmärta	106	Smärta vid vattenkastning	116
Smärta/svullnad buk	106	Urinretention	116
Smärta/svullnad ljumske	106	Urinvägsproblem	116
Mag-tarmproblem	106	KAD-relaterade problem	116
Magsmärta	106	Skrotal smärta	117
Blodig avföring/melena	107	Skrotal svullnad	117
Symtom från anus och rektum/hemorroider	107	Besvär i penis/urinrör	117
Diarré/lös avföring	107	Huvudvärk	119
Blodig kräkning/hematemes	108	Svimning/syncopé	120
Kräkning	108	Medvetandeförlust	120
Illamående	108	Gynekologiska besvär	121
Kramper	109	Vaginal blödning	121
Epilepsi, känd	109	Postpartum < 30 dagar	121
Frånvaroattack	109	Underlivsbesvär	121
Ryckningar hos spädbarn	109	Graviditet	121
Yrsel, balanssvårigheter	111	Gulsot/ikterus	129
Facialis pares	112	Skada huvud/ansikte/näsa	130
Neurologiskt bortfall/symtom	112	Skada nacke/hals	130
Ledvärk utan trauma	113	Hängning/strykning	130
Hälta utan trauma	113	Tandskada	130
Smärta nacke utan trauma	114	Käkskada	130
Ryggsmärta utan trauma	114	Skada buk	131
Smärta i brösttryggen utan trauma	114	Skada könsorgan	131
Ödem	115	Skada thorax/rygg	131

RETTS Version 2025-C

Innehållsförteckning - Kontaktorsaker i nummerordning

Kontaktorsak	ESS	Kontaktorsak	ESS
Skrubbsår	132	Stickskada med smittorisk	141
Skärsår	132	Toxiska effekter av djur	141
Hematom/svullnad/blåmärke	132	Bett av människa	141
Sårskada	132	Fysisk misshandel/misstanke om	142
Skada arm/handled	133	Sexuellt övergrepp/misstanke om	142
Skada axel/nyckelben	133	Allergi	143
Skada hand/finger	133	Läkemedelsreaktion	143
Skada höft/lårben/bäcken	134	Exantem/hudutslag/blåmärke	143
Skada knä/underben	134	Klåda	143
Skada fot/tå	134	Hosta	144
Inhalationsskada	135	Förkylning/halsont	144
Köldskada	135	Blåsor i munnen	144
Elolycka	135	Öronvärk	145
Blixtnedslag	135	Öronproblem	145
Strålskada	135	Främmande kropp i näsa	146
Brännskada	135	Främmande kropp i luftväg	146
Frätskada	135	Främmande kropp i öra	146
Toxisk effekt av kolmonoxid	135	Främmande kropp i esofagus eller i magtarmkanalen	146
Hypotermi	135	Främmande kropp	146
Kemisk skada	135	Lokal infektion i hud (inkl böld/lymfadenit)	147
Hypertermi/Värmeslag	135	Tandvärk/tandinfektion	147
Dykarsjuka/dekompressionssjukdom, misstanke om	136	Resistent svullnad/knöl på halsen	147
Drunkning/drunkningstillbud	136	Anemi	148
Skada öga	137	Blodsjukdomar	148
Ögonskada	137	Högt blodsocker/hyperglykemi	149
Trauma	138	Lågt blodsocker/hypoglykemi	150
Förgiftning/intoxikation	140	Addisons sjukdom. TILLÄGGS-ALGORITM, barn skall även triageras utifrån sökorsak	151
Bett och stick av djur	141	Binjurebarkssvikt, känd. TILLÄGGS-ALGORITM, barn skall även triageras utifrån sökorsak	151

RETTS Version 2025-C

Innehållsförteckning - Kontaktorsaker i nummerordning

Kontaktorsak	ESS	Kontaktorsak	ESS
Kortisolbrist. TILLÄGGS-ALGORITM, barn skall även triageras utifrån sökorsak	151	Krisreaktion	188
Otillräckligt vätskeintag	153	Reaktion på svår stress	188
Otillräcklig viktutveckling	153	Psykisk ohälsa	189
Ospecifika symtom	153	Ej akut psykiatrisk problematik	190
Gråtande barn	153	Organisk katatoni	191
Oroliga föräldrar	153	Beteendestörning av utagerande slag	198
Hälsoundersökning	153	Farlighetsbedömning	198
Oklar sjukdom	153	Suicidriskbedömning	199
Otillräckligt näringsintag	153	Självskadebeteende	199
PEG-relaterade problem	153	Andningsstillestånd	VP
Feber med oklart fokus	154		
Metabola sjukdomar. TILLÄGGSALGORITM, barn skall även triageras utifrån sökorsak	155		
Diabetes, känd. TILLÄGGSALGORITM, barn skall även triageras utifrån sökorsak	155		
Infektion öga	157		
Ögonproblem	157		
Ögoninfektion	157		
Cirkulationsstillestånd	165		
Gipsproblem	171		
Operationskomplikation	172		
Depressiv episod	180		
Nedstämdhet	180		
Mani	181		
Hypomani	181		
Ångest	182		
Sömnstörning	183		
Psykotiska symtom	184		
Missbruk/beroende	185		
Ätstörning	187		

- Förmaksflimmer I48.9
- Onormal hjärtrytm R00.8

Förberedande åtgärder

- EKG

Röda symtom

- AV-Block III
- Ventrikeltakykardi

Orange symtom

- Arytmi - med medvetandeförlust
- Arytmi - med nydebuterat benödem/dyspné/cyanos
- Arytmi – samtidigt blek och kallsvettig/kladdig/illamående
- AV-Block II
- Förmaksflimmer - med bröstsmärta som pat ej känner igen
- Nydebuterad arytmi - med bröstsmärta/påtaglig obehagskänsla

Gula symtom

- Hjärtfel – känt sedan tidigare
- Hjärtopererad, inklusive PCI - inom senaste 3 månaderna
- Nydebuterat eller recidiverande förmaksflimmer
- Nyupptäckt VES i bigemini eller trigemeni

Gröna symtom

- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

- | | |
|---|---|
| ➔ Hjärtrutin (TSH+T4 vid nyupptäckt förmaksflimmer) | ➔ PVK (gärna höger arm) |
| ➔ Blodgruppering | ➔ EKG-uppkoppling |
| ➔ Blodgas | ➔ Plasmalyte |
| ➔ PVK (gärna höger arm) | ➔ Hjärtrutin (TSH+T4 vid nyupptäckt förmaksflimmer) |
| ➔ EKG-uppkoppling | ➔ Blodgruppering |
| ➔ Plasmalyte | ➔ PVK (gärna höger arm) |
| ➔ Hjärtrutin (TSH+T4 vid nyupptäckt förmaksflimmer) | ➔ EKG-uppkoppling |
| ➔ Blodgruppering | ➔ Hjärtrutin |
| ➔ Blodgas | |

Fasta

- Dyspné, se även ESS 4
- Samtidig bröstsmärta se även ESS 5

RETTS faktaruta

Guide till alternativa ESSer;

Om patienten ej har någon objektiv, EKG verifierbar arytmi och samtidigt andra symtom, se istället under de andra symtomen ex

Vid dyspné, se även ESS 4

Vid bröstsmärta, se även ESS 5

Onormal hjärtrytm är ett symtom som kan vara orsakat av allvarliga arytmier som endast fångas intermittent men kan också vara av helt ofarlig karaktär men där patienten upplever extraslag. Extraslag kan ge symtom men vid undersökningstillfället kan extraslag saknas. VES = Ventrikulära extraslag.

Vid akut hjärtsvikt kan symtom som bensvullnad/ödem, cyanos, rassel, ronki och dämpande andningsljud förekomma vid lungaskultation samt uttalad dyspné.

"Arytmi - med nydebuterat benödem/dyspné/cyanos" avser symtomen på hjärtsvikt (debut inom 48 timmar) i samband med en känd redan existerande arytmi, eller hjärtsvikt inducerad av arytmi.

Plötslig medvetandeförlust utan föregående symtom och utan misstanke om bakomliggande krampsjukdom kan behöva en annan och mer skyndsam handläggning. Samtidigt är det ibland svårt att skilja medvetandeförlust vid arytmier från psykosomatiska orsakade symtom. Försök att anamnestiskt skilja på medvetandeförlust med prodromalsymtom (förkänningar), från medvetandeförluster som kommer plötsligt, utan förvarning och där patienten vaknar upp på golvet. Notera alltid tid för debut och följ lokal rutin för vidare klinisk handläggning.

- Blodig upphostning/hemoptys R04.2
- Näsblödning/epistaxis R04.0
- Postoperativ tonsillblödning R04.1

Förberedande åtgärder

- Hb g/L - om möjligt

Röda symtom

- Hb <70 g/L eller initialt/lägst SBT <90 mmHg
- Pågående blödning från näsa/mun - stor okontrollerad

Orange symtom

- Hb <90 g/L
- Koagulationshämmande läkemedel eller blödningsbenägenhet samt pågående blödning
- Svalgkirurgi senaste 14 dagarna

Gula symtom

- Avstannad blödning samt koagulationshämmande läkemedel eller blödningsbenägenhet
- Övriga med pågående näsblödning

Gröna symtom

- Övriga med avstannad näsblödning
- Övriga med hemoptys
- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| ➡ Polop prover | ➡ Blodgruppering |
| ➡ Blodgruppering | ➡ Bastest |
| ➡ Bastest | ➡ PVK |
| ➡ Blodgas | ➡ Plasmalyte |
| ➡ PVK (överbäg 2) | ➡ Vid hemoptys, överbäg prover |
| ➡ Plasmalyte | ➡ Vid hemoptys, överbäg prover |
| ➡ Polop prover | |

- Stora blödningar från mun utan känd svalgkirurgi, överbäg ESS 7

RETTS faktaruta

Blodupphostning/hemoptys skall alltid tas på allvar eftersom man vid upprepade tillfällen av hemoptys måste utesluta bakomliggande sjukdom. Vid vissa lungödem och vid lungemboli /lunginfarkt kan hemoptys förekomma men är relativt ovanligt och utgör inget kardinalsymtom. Hemoptys kan förekomma också vid koagulationshämmande behandling och vanlig benign hosta. Det är extra viktigt att man hos patienter med synlig blödning kontrollerar om det föreligger behandling med koagulationshämmare eller blödningsbenägenhet.

Med blödningsbenägenhet avses känd koagulationsdefekt. (se Manual RETTS benämning Koagulationshämmare vs trombocythämmare) <https://www.rettselearning.com/elearning/> (RETTS e-learning / Resurser / RETTS Manualer)

Hemoglobin (Hb) gränserna är satta som vägledning och har ingen vetenskaplig grund utan baseras på hur akut transfusionsbehov patienten kan tänkas ha. Vitalparametrarna kan ge utslag vid riktigt låga Hb. Vid postoperativ tonsillblödning, som ofta är av intermittent typ, kan stora och livshotande tillstånd uppstå akut. Ofta är det hotad luftväg som komplicerar tillståndet. Dödsfall har rapporterats. En postoperativ tonsillblödning kan därför ALDRIG prioriteras lägre än Orange.

När Hb mätare saknas prehospitalt rapporteras att bedömningen ej är slutförd och behöver kompletteras.

Blödning definieras:

Liten blödning Mer saliv än blod

Medelstor blödning Mer blod än saliv

Stor blödning Blod rinner från näsa och/eller mun

Ortostatism

Nyttillkommen ortostatism/svimmingskänsla från liggande till stående kan tillsammans med förhöjd AF och PF ge indikation på att patienten är hypovolem. Överbäg att först kontrollera liggande blodtryck och därefter stående blodtryck.

- Andningsbesvär/dyspné/andnöd R06.0
- Hyperventilation R06.4

Förberedande åtgärder

- EKG

Röda symtom

- Dyspné samt blek/kallsvettig/medvetandeförlust
- Initialt / lägst SBT <90 mmHg
- ST-höjning
- Symtom och kliniska tecken som uppfyller nationella kriterier för sepsisalarm

Orange symtom

- Anamnes på medvetandeförlust
- Feber >38,5°C och frossa senaste 12 timmarna
- Dyspné med nytillkommet vänster eller högergrenblock
- Hjärtopererad, inklusive PCI senaste 3 månaderna
- Nytillkomna ischemitecken på EKG
- Pågående eller inom dygnet övergående dyspné med ischemitecken på EKG
- Synlig halsvenstas

Gula symtom

- Benödem samt dyspné
- Obstruktivitet
- Tidigare känd kronisk hjärt-lungsjukdom

Gröna symtom

- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

- | | |
|------------------------|-------------------|
| ➔ Hjärtrutin + D-dimer | ➔ Blodgruppering |
| ➔ Blodgruppering | ➔ Blodgas |
| ➔ Blodgas | ➔ Grov PVK |
| ➔ PVK (överbäg 2) | ➔ EKG-uppkoppling |
| ➔ EKG-uppkoppling | ➔ Hjärtrutin |
| ➔ Plasmalyte | ➔ Hjärtrutin |
| ➔ Hjärtrutin + D-dimer | |

- Bröstsmärta, se istället ESS 5
- Misstanke om allvarlig infektion, se även ESS 47
- Samtidig hjärklappning, se ESS 1

RETTS faktaruta

Guide till alternativa ESSer

Vid samtidig konstaterad infektion/feber se istället ESS 47

Vid samtidig EKG verifierbar arytm se istället ESS 1

Vid plötsligt debuterad/påtaglig bröstsmärta se istället ESS 5

Vid enbart bilaterala ödem se istället ESS 15

Dyspné/andnöd är ett av de vanligaste symtomen hos patienter som söker eller kontaktar akutsjukvården. Många av de sökande kan ha en tidigare känd hjärt-lungsjukdom. Alla tillstånd har inte en bakomliggande organisk orsak till dyspnén. Vid dyspné spelar därför kombinationen VP och ESS en viktig roll i handläggningen. Viktigt att komma ihåg är att patienter med kroniska lungsjukdomar ofta faller ut på vitalparametrar medan lungfriska kan ha helt normala vitalparametrar och ändå ha en allvarlig bakomliggande sjukdom. Vid lungemboli kan vissa patienter vara förvånansvärt opåverkade i vila. Ofta är akut lungemboli kombinerat med viss takykardi men behöver inte vara särskilt uttalad, i vissa fall kan nydebuterat förmaksflimmer vara associerat till lungemboli.

Vissa hematologiska sjukdomar ger också ökad risk för tromboembolism, liksom vid graviditet, nyligen förlösta och hormonbehandlade patienter.

WELLS kriterierna är de som kan användas för att bedöma patienter med misstänkt lungemboli. Tidigare djup ventrombos och/eller lungemboli är riskfaktorer för lungemboli.

Vid samtidig bröstsmärta och/eller medvetandeförlust skall symtomet dyspné alltid betraktas som mer allvarligt än utan dessa symtom.

Infektion:

Symtom som kan indikera allvarlig infektion och kan leda till sepsis:

- Feber/skakfrossa/hypotermi
- Konfusion/vakenhetssänkning/motorisk oro
- Uttalad allmänpåverkan/allmän svaghet
- Andnöd/andfåddhet/takypné/dyspné
- Kräkning/diarré
- Smärta (ex buk)

Feber är vanligt men det är även vanligt att patienterna inte har feber eller är hypoterma. Framförallt i sköra patientgrupper. Desto kraftigare frossa desto större risk att det rör sig om feber

Alla patienter med sepsis har inte feber och tänk på att patienten kan ha tagit febernedsättande, som påverkar mätningen

OBS! Lägre temperatur vid ankomst är korrelerad till högre sjukhusdödlighet.

- Bröstsmärta/bröstskorgssmärta R07.4
- Bröstsmärta vid andning R07.1

Förberedande åtgärder

- EKG

Röda symtom

- Pågående central bröstsmärta/tryck över bröstet med kardiell smärtkaraktär (se faktaruta) samt blek och kallsvettig/kladdig /illamående
- ST-höjning på EKG (STEMI)

Orange symtom

- Pågående central bröstsmärta/tryck över bröstet med kardiell smärtkaraktär (se faktaruta)
- Pågående bröstsmärta/tryck över bröstet med nyttillkommet vå /hö sidigt grenblock, eller AV block
- Pågående eller inom dygnet övergående bröstsmärta med aktuella ischemitecken på EKG
- Bröstsmärta/tryck över bröstet med medvetandeförlust det senaste dygnet
- Hjärtopererad, inklusive PCI senaste 3 månaderna
- Övergående bröstsmärta samt blek och kallsvettig/kladdig det senaste dygnet

Gula symtom

- Övriga med pågående/övergående bröstsmärta

Gröna symtom

Blåa symtom

Lokala processåtgärder

➡ Hjärtrutin	➡ Hjärtrutin
➡ Blodgruppering	➡ Blodgruppering
➡ Bastest	➡ Grov PVK
➡ Blodgas	➡ EKG-uppkoppling
➡ PVK (överbäg 2)	➡ Syrgas om saturation <95%
➡ EKG-uppkoppling	➡ Hjärtrutin
➡ Plasmalyte	➡ Syrgas om saturation <95%
➡ Syrgas om saturation <95%	➡ Hjärtrutin

- Dyspné utan bröstsmärta, se även ESS 4
- Onormal hjärtrytm, se även ESS 1
- Smärta i brösttrygg, överbäg ESS 14
- Trauma, se istället ESS 38

RETTS faktaruta

Guide till alternativa ESS er:

Vid primära symtomet "dyspné/andnöd" utan påtaglig bröstsmärta, se istället ESS 4.

Vid lättare bröstsmärta/obehag i bröstet och samtidig nydebuterat EKG, ej sinusrytm se istället ESS 1.

Vid smärta i brösttrygg med tydlig rörelsekorrelation hos ung och frisk patient, överbäg att använda ESS 14.

Gravid patient fr.o.m. v. 20+0, se istället ESS 205.

Kardiell genes:

Bröstsmärta av kardiell genes, syftar på att smärtan har ett ursprung i hjärtmuskeln.

Kardiell smärtkaraktär:

Bröstsmärta av kardiell genes har vanligtvis en kardiell smärtkaraktär som upplevs molande, kramande, tryckande (förekommer skärande) men det finns också andra mer diffusa symtom.

Olika typer av kardiell smärtkaraktär kan bero på olika orsaker, såsom ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt, arytmier eller perimyokardit. (Ref; Internetmedicin).

Det är vanligt att symtomen debuterar i samband med fysisk ansträngning* eller psykisk anspänning.

Symtomen kan även uppträda i vila.

Röd triagerad patient (Omedelbart livshotande tillstånd):

Här vill vi fånga upp (STEMI) patienter som upplever tydlig kardiell smärtkaraktär MED vegetativa symtom (t.ex, kallsvettning, illamående, ångest, andfåddhet, matthet). Ofta förekommer också smärtutstrålning i hals, armar eller rygg.

Vanliga symtom på STEMI är kardiell smärtkaraktär som:

- patienten tydligt känner igen från tidigare hjärtinfarkt(er), samt vegetativa symtom.
- förvärras vid fysisk ansträngning* (skall alltid tolkas som kardiogen), samt vegetativa symtom.

Orange triagerad patient (Potentiellt livshotande tillstånd):

Kardiell smärtkaraktär UTAN vegetativa symtom som:

- patienten tydligt känner igen från tidigare hjärtinfarkt(er).
- förvärras vid fysisk ansträngning* (skall alltid tolkas som kardiell)
- upplevs i samband med rörelser i överkroppen (skall inte tolkas som ansträngningsutlöst)
- inte kan provoceras fram

(*Med fysisk ansträngning menas kroppslig aktivitet som ökar pulsen)

Gul triagerad patient (Ej aktuellt livshotande tillstånd):

Här vill vi fånga upp övriga tillstånd med bröstsmärta som generellt inte behöver tolkas som kardiogen men som behöver påses av läkare.

Vanliga symtom är:

- bröstsmärta som KAN provoceras fram genom att - trycka på patientens bröstorg, patienten vrider bröstorg eller att patienten tar djupa andetag mm.
- smärta på en liten punkt, sekundlånga stick eller hugg, eller smärtor i exempelvis höger sida bröst.

Övrigt:

Bröstsmärta är den vanligaste orsaken till att patienter söker kontakt med akutsjukvården.

RETTS ESS 5 visualiserar medicinsk risknivå (Röd till Grön) utifrån de vanligaste förekommande symtomen på bröstsmärta av kardiell genes och icke kardiell genes. Det förekommer alltid patienter med diffusare symtom som måste beaktas.

Det är viktigt att val av triage-nivå vid varje undersökning och bedömning, baseras på både VP och rätt ESS samt utifrån vårdarens/användarens kliniska blick.

Smärta som är lätt provocerbar med palpation av bröstmuskler eller är rörelserelaterad, är inte alltid kardiellt betingad men även de här patienterna bör beaktas, intill ischemiska förändringar är utredda.

Frågor att ställa vid anamnestagning:

När började bröstsmärtan, var den andningskorrelerad, kom den vid ansträngning, kyla?

Har tidigare bröstsmärta akut ändrat karaktär?

Har bröstsmärtan varit associerad med blekhet, kallsvettning, kladdig hud samt illamående patient?

Finns gamla EKG som jämförelse?

Finns det riskfaktorer för ischemisk hjärtsjukdom som tidigare kardiovaskulär sjukdom (även Claudicatio intermittens, stroke, TIA), hypertoni, rökning, diabetes, hyperlipidemi, ärftlighet?

Förekomst av en eller flera riskfaktorer ökar sannolikheten för att akut koronart syndrom kan föreligga och stärker indikationen för utredning vid akut bröstsmärta.

Ett normalt EKG utesluter inte akut koronart syndrom. Ett patologiskt EKG bekräftar inte akut koronart syndrom. Kontrollera att patologiskt EKG är rätt kopplat.

- Buksmärt R10.4
- Flanksmärta R10.4
- Magsmärta R10.4
- Mag-tarmproblem A09
- Smärta/svullnad buk K40.0
- Smärta/svullnad lumske K40.9

Förberedande åtgärder

- EKG - Om buksmärt över navelplan och över 35 år eller kardiovaskulära riskfaktorer
- Överväg symtom som inger infektionsmisstanke (se faktaruta) - se även ESS 47

Röda symtom

- Initialt / lägst SBT <90 mmHg
- Plötslig smärtdébut med samtidig medvetandeförlust
- Pågående smärta med plötslig debut samt blek/kallsvettig
- Symtom och kliniska tecken som uppfyller nationella kriterier för sepsisalarm

Orange symtom

- Feber >38,5°C och frossa senaste 12 timmarna
- Ileus - misstanke om
- Immunosupprimerad patient
- Pågående måttlig/svår smärta hos patient med känt bukaortaaneurysm
- Pågående måttlig/svår smärta hos patient med peritonealdialys eller pyelostomi
- Resistens i lumske/buk - ej reponibel - ihållande svårt smärtsam
- Smärta och medvetandeförlust senaste 4 timmarna

Gula symtom

- Övriga med ihållande buksmärt

Gröna symtom

- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

- Acites/ikterus, se istället ESS 29
- Förgiftning/intoxikation - misstanke om, se även ESS 40
- Gravid patient fr.o.m. v. 20+0, se även ESS 21
- Högt sittande buksmärt, överväg ESS 5
- Kräkning/diarré, se istället ESS 8
- Känd diabetes, se även ESS 49
- Misstanke om Allvarlig infektion, se även ESS 47
- Skada buk, se istället ESS 31
- Skrotal smärta, se istället ESS 17

RETTS faktaruta

Buksmärt allmänt:

Buksmärt är den vanligaste kontaktorsaken som brukar kategoriseras som "kirurgi" inom akutvårdkedjan och finns vid många buktillstånd, diarré, kräkningar, infektion, metabola sjukdomar, kardiovaskulära tillstånd.

Bakomliggande orsaker kan variera, och vissa tillstånd kräver omedelbart omhändertagande dock mer sällan akut kirurgisk åtgärd. Debuten och förekomst av andra samtidiga symtom som kräkning, hematuri, feber, frossa, diarré kan påverka handläggning och prioritering.

Riskfaktorer vid buksmärt:

Kända riskfaktorer som kan utgöra ett stöd i bedömningen och prioriteringen av patienter med buksmärt, är exempel:

- tidigare bukkirurgi
- kända gastrointestinala sjukdomar
- buktrauma
- känt aortaaneurysm
- peritonealdialys (PD-patient) och pyelostomikateter.

Observera att akut buksmärt kan vara av kardiell eller av metabol genes, som vid laktatacidos(sepsis) eller ketoacidosis (diabetes).

Ileus:

Vid ileus är passagen/motoriken i mag-tarm-kanalen av olika skäl upphävd/påverkad. Orsaken kan vara paralytisk, mekanisk, obstruktion eller att tarmen har vridit sig eller invaginerat sig. Tidigare bukkirurgi är en riskfaktor, t.ex. gastric bypass (GBP) eller annan tarmkirurgi.

Misstänk ileus vid symtom/tecken:

- Buksmärt (ofta krampartad vid mekanisk ileus)
- Uppspänd buk
- Illamående och kräkningar
- Avsaknad av avföring och gasavgång
- Eventuell försämring av allmäntillståndet (vid avancerat tillstånd)

Intervallsmärta är en typ av buksmärt som kommer och går i vågor, vanligtvis relaterad till obstruktion eller hinder i tarmen. Den förekommer vid ileus men också vid andra tillstånd, t ex: gallsten, njursten, invagination av tarmen och kolik.

Ileusstatus är ett konstaterat medicinskt tillstånd ofta med smärta, ibland svår och intermittent smärta med ett muskelsvar (defens) vid palpation av buken.

Infektion:

Lokala processåtgärder

- | | |
|---|---|
| ➔ Bukrutin + Troponin | ➔ PVK |
| ➔ Blododling vid feber >38,5 och frossa | ➔ Plasmalyte (om kräkning) |
| ➔ Blodgruppering | ➔ Bukrutin + Blododling vid feber >38,5 och frossa + Blodgruppering + PVK + Plasmalyte (om kräkning) + Bladderscan (vid stor buk) + Urinsticka + U-HcG på fertil kvinna |
| ➔ Bastest | ➔ Bukrutin |
| ➔ Blodgas | ➔ Blododling vid feber >38,5 och frossa |
| ➔ PVK x2 | ➔ Blodgruppering |
| ➔ EKG | ➔ PVK |
| ➔ Plasmalyte | ➔ Plasmalyte (om kräkning) |
| ➔ Bukrutin | ➔ Bukrutin + Blodgruppering + Bladderscan (vid stor buk) + Urinsticka + U-HcG på fertil kvinna |
| ➔ Blododling vid feber >38,5 och frossa | ➔ Bukrutin |
| ➔ Blodgruppering | ➔ Blodgruppering |

På alla patienter som söker för buksmärta:

Ta urinprov på alla patienter som söker för buksmärta samt lägg till U-HcG på fertil kvinna.

Bladderscan vid stor buk.

Informera om fasta.

Symtom som kan indikera allvarlig infektion och kan leda till sepsis:

- Feber/skakfrossa/hypotermi
- Konfusion/vakenhetssänkning/motorisk oro
- Uttalad allmänpåverkan/allmän svaghet
- Andnöd/andfåddhet/takypné/dyspné
- Kräkning/diarré
- Smärta (ex buk)

Feber är vanligt men det är även vanligt att patienterna inte har feber eller är hypoterma. Framförallt i sköra patientgrupper.

Desto kraftigare frossa desto större risk att det rör sig om feber

Alla patienter med sepsis har inte feber och tänk på att patienten kan ha tagit febernedsättande, som påverkar mätningen. OBS! Lägre temperatur vid ankomst är korrelerad till högre sjukhusdödlighet.

Fråga efter utlandsvistelse i närtid.

LÅGT SITTANDE BUKSMÄRTA HOS FLICKA/KVINNA

Vid lågt sittande buksmärta hos fertila kvinnor skall man alltid misstänka graviditet eller postpartum komplikation.

Graviditetstest rekommenderas. Vid graviditet över v 20+0 skall blodtrycket inte vara $\geq 160/110$ mmHg. Om så är fallet rekommenderas kontakt med obstetriker direkt.

Gravid patient, se även ESS 21 (Barn-ESS 121). OBS Blodtryck samt medvetandegrad.

Ovarialtorsion:

Symtom som förekommer hos flickor/kvinnor är buksmärta med plötslig intensiv smärtdebut, lågt sittande med konstant smärtpunkt som ej avtar. Ej att förväxla med menstruationssmärta. Ovarialtorsion leder till syrebrist i vävnaden (ischemi) och har genom sitt läge i buken en annan symtomatologi och förlopp som är svårare att både misstänka, bekräfta eller avfärda på ett säkert sätt. Vid låg buk/ryggsmärta skall alltid möjligheten till bakomliggande ovarialtorsion övervägas och uteslutas.

Smärta graderas enligt lokalt verktyg för smärtskattning (oftast VAS-skalan). Smärtvärdering skall användas på samma patient och inte jämföras mellan patienter.

Ingen smärta: 0

Lätt smärta: 1-3

Måttlig smärta: 4-7

Svår smärta: 8-10

- Blodig avföring/melena K92.1
- Blodig kräkning/hematemes K92.0
- Gastrointestinal blödning K92
- Rektal böld L02.3
- Symtom från anus och rektum/hemorroider K62.9

Förberedande åtgärder

- Hb g/L vid misstanke om blödning - om möjligt

Röda symtom

- Initialt / lägst SBT < 90 mmHg
- Pågående blödning - misstanke om/synlig - samt Hb < 70 g/L
- Pågående stor blodkräkning eller stor rektal blödning
- Symtom och kliniska tecken som uppfyller nationella kriterier för sepsisalarm

Orange symtom

- Anamnes på esofagusvaricer
- Anamnes på stor blodkräkning eller stor rektal blödning
- Feber > 38,5°C och frossa senaste 12 timmarna
- Koagulationshämmande läkemedel eller blödningsbenägenhet samt pågående blödning
- Pågående blödning och Hb < 90 g/L
- Svalgkirurgi senaste 14 dagarna med blödning från näsa/mun

Gula symtom

- Enstaka blödningsrekar rektalt eller oralt
- Misstanke om/verifierad rektal abscess samt urinretention
- Svart avföring eller blod i avföringen

Gröna symtom

- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

- | | |
|-------------------|------------------|
| ➔ Bukrutin | ➔ Bastest |
| ➔ Blodgas | ➔ PVK |
| ➔ Blodgruppering | ➔ Plasmalyte |
| ➔ Bastest | ➔ Bukrutin |
| ➔ PVK (överbäg 2) | ➔ Blodgruppering |
| ➔ Plasmalyte | ➔ Bastest |
| ➔ Bukrutin | ➔ PVK |
| ➔ Blodgruppering | ➔ Plasmalyte |

EKG (inför inläggning/operation)

- Misstanke om allvarlig infektion, se även ESS 47
- Vaginal blödning, se istället ESS 21

RETTS faktaruta

Hematemes beror oftast på blödning i ventrikel, esofagus eller övre delen av tunntarmen. Mörk/svart avföring/diarré betyder ofta blödning som pågått en tid, medan rött blod i avföringen ofta är färsk. Stora mängder blod indikerar större färsk blödning, medan små blodmängder i avföringen indikerar distal mindre blödning. Det är därför extra viktigt att man hos patienter med gastrointestinal blödning särskilt efterfrågar om patienten har ökad blödningsbenägenhet.

När kapillär blod Hb mätare saknas prehospitalt rapporteras att bedömningen ej är slutförd och behöver kompletteras.

Nyttillkommen ortostatism/svimmingskänsla från liggande till stående kan tillsammans med förhöjd AF/PF indikera att patienten är hypovolem. Överväg att först kontrollera liggande blodtryck och direkt därefter kontrollera stående blodtryck.

Symtom som kan indikera allvarlig infektion och kan leda till sepsis:

- Feber/skakfrossa/hypotermi
- Konfusion/vakenhetssänkning/motorisk oro
- Uttalad allmänpåverkan/allmän svaghet
- Andnöd/andfåddhet/takypné/dyspné
- Kräkning/diarré
- Smärta (ex buk)

Feber är vanligt men det är även vanligt att patienterna inte har feber eller är hypoterma. Framförallt i sköra patientgrupper. Desto kraftigare frossa desto större risk att det rör sig om feber

Alla patienter med sepsis har inte feber och tänk på att patienten kan ha tagit febernedsättande, som påverkar mätningen

OBS! Lägre temperatur vid ankomst är korrelerad till högre sjukhusdödlighet.

- Illamående R11.9A
- Kräkning R11.9B
- Diarré K59.1

Röda symtom

- Initialt / lägst SBT <90 mmHg
- Symtom och kliniska tecken som uppfyller nationella kriterier för sepsisalarm

Orange symtom

- Feber >38,5°C och frossa senaste 12 timmarna
- Ileus - misstanke om
- Immunosupprimerad patient
- Upprepade medvetandeförluster

Gula symtom

- >2 kräkningar sista 4 timmarna
- En medvetandeförlust
- Upprepade kräkningar/diarréer hos i övrigt skör eller multisjuk patient
- Upprepade kräkningar och shuntbehandlad hydrocefalus

Gröna symtom

- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

➡ Bukrutin	➡ EKG
➡ Blododling vid feber >38,5 och frossa	➡ Plasmalyte
➡ Blodgas	➡ Bukrutin
➡ PVK x2	➡ Blododling vid feber >38,5 och frossa
➡ EKG	➡ Blodgas
➡ Plasmalyte	➡ PVK
➡ Bukrutin	➡ EKG
➡ Blododling vid feber >38,5 och frossa	➡ Plasmalyte
➡ Blodgas	➡ Överväg blodgas + CRP
➡ PVK	

Urinprov samt lägg till U-HcG på fertil kvinna.
Bladderscan vid stor buk.

- Gravid patient, se även ESS 21
- Kräkning/feber/frossa/diarré samt Addisons/indikation på binjurebarkssvikt/kortisolbrist se istället ESS 51
- Känd diabetes, se även ESS 49
- Misstanke om allvarlig infektion, se även ESS 47
- Samtidig buksmärta, se istället ESS 6
- Samtidig huvudvärk, se istället ESS 19

RETTS faktaruta

Infektion:

Symtom som kan indikera allvarlig infektion och kan leda till sepsis:

- Feber/skakfrossa/hypotermi
- Konfusion/vakenhetssänkning/motorisk oro
- Uttalad allmänpåverkan/allmän svaghet
- Andnöd/andfåddhet/takypné/dyspné
- Kräkning/diarré
- Smärta (ex buk)

Feber är vanligt men det är även vanligt att patienterna inte har feber eller är hypoterma. Framförallt i sköra patientgrupper. Desto kraftigare frossa desto större risk att det rör sig om feber

Alla patienter med sepsis har inte feber och tänk på att patienten kan ha tagit febernedsättande, som påverkar mätningen

OBS! Lägre temperatur vid ankomst är korrelerad till högre sjukhusdödlighet.

Fråga efter utlandsvistelse i närtid.

Gastroenterit:

Är vanlig och ibland säsongsb beroende. Viktigt att följa lokala hygienrutiner och andra smittspridningsförhindrade rutiner.

Begreppet "skör och multisjuk" är normalt inte definierat men känns ofta igen och bedöms av vårdpersonalen enligt befintlig kunskaper och rutiner.

- Kramper R56.9
- Epilepsi, känd G40.9

Röda symtom

- Blodtryck $\geq 180/120$ samt gravid

Orange symtom

- Blodtryck $\geq 160/110$ samt gravid
- Koagulationshämmande läkemedel eller blödningsbenägenhet
- Krampanfall i abstinensfas
- Krampanfall utan tidigare känd epilepsi - misstänkt aktuellt
- Upprepade krampanfall - aktuella

Gula symtom

- Krampanfall och tidigare känd epilepsi

Gröna symtom**Blåa symtom****Lokala processåtgärder**

- | | |
|--|--|
| ➔ CVS-rutin + Intoxrutin
(vid misstänkt
alkoholmissbruk) | ➔ PVK |
| ➔ Blodgruppering | ➔ EKG |
| ➔ Blodgas | ➔ Plasmalyte |
| ➔ PVK | ➔ CVS-rutin + Intoxrutin
(vid misstänkt
alkoholmissbruk) |
| ➔ EKG | ➔ Blodgruppering |
| ➔ Plasmalyte | ➔ Blodgas |
| ➔ CVS-rutin + Intoxrutin
(vid misstänkt
alkoholmissbruk) | ➔ PVK |
| ➔ Blodgruppering | ➔ EKG |
| ➔ Blodgas | ➔ Plasmalyte |

U-HcG på fertil kvinna

- Besvär efter intoxikation, se även ESS 40
- Besvär efter trauma, se istället ESS 30
- Gravid patient, se även ESS 21
- Kortvariga ryckningar efter medvetandeförlust, överväg ESS 20

RETTS faktaruta

Patient som haft aktuella (senaste dygnet) upprepade krampanfall har en ökad risk att få ytterligare ett krampanfall. Debut av epilepsi i vuxen ålder är ovanligt. Bakomliggande annan orsak till kramper bör misstänkas. Skalltrauma? Missbruk? Graviditet - misstänkt preeklampsi.

Hypertoni - högt blodtryck - kan debutera under graviditeten (efter v 20) och kallas då graviditetshypertoni. Kvinnan kan också vara diagnostiserad innan hon blir gravid och har då en essentiell hypertoni. Hos gravida skall blodtrycket observeras och monitoreras.

Krampanfall hos patient med koagulationshämmande mediciner eller blödningsbenägenhet har ökad risk att kramperna kan bero på intrakraniell blödning.

- Yrsel, balanssvårigheter R42.0

Röda symtom

Orange symtom

- Akut debut av konstant yrsel samt svårt att gå/stå/sitta utan levande stöd relaterat till yrseln
- Koagulationshämmande läkemedel eller blödningsbenägenhet samt konstant yrsel
- Medvetandeförlust i samband med debut
- Plötsligt påkommen huvudvärk
- Spontan nystagmus - vertikal, torsionell eller riktningsväxlande nystagmus med blickriktningen

Gula symtom

- Lägesyrsel/Karusellyrsel vid lägesförändring av huvudet - ostadig gå/stå
- Samtidiga upprepade kräkningar
- Skalltrauma senaste månaden
- Tidigare stroke

Gröna symtom

- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

- | | |
|-------------------|----------------------------------|
| ➔ CVS-rutin | ➔ EKG-uppkoppling |
| ➔ Blodgruppering | ➔ CVS-rutin |
| ➔ PVK | ➔ EKG |
| ➔ EKG-uppkoppling | ➔ Överväg ortostatiskt blodtryck |
| ➔ CVS-rutin | ➔ EKG |
| ➔ Blodgruppering | ➔ Överväg ortostatiskt blodtryck |
| ➔ PVK | |

Kapillärt Hb och glukos

- Aktuellt skalltrauma, se istället ESS 30
- Gravid patient, se även ESS 21
- Neurologiska bortfall, se istället ESS 12
- Onormal hjärtrytm, se istället ESS 1
- Samtidig huvudvärk, se även ESS 19
- Syncopé, se även ESS 20

RETTS faktaruta

Fråga efter skalltrauma.

Yrsel är ett vanligt symtom hos både yngre och äldre patienter. Äldre kan dock få svårt att klara sin ADL vid plötslig yrsel eller variation i kronisk yrsel. En vanlig orsak till plötslig yrsel är godartad lägesbetingad yrsel som förvärras av huvudrörelse och lägesförändring av kroppen.

Vid lägesbetingad benign yrsel är den ofta av rotatorisk karaktär. Med akut debut menas plötsligt påkommen yrsel inom några få timmars tidsintervall från ankomst.

Vid yrsel hos äldre är det viktigt att man bedömer risken för fall och har patienten under uppsikt/tillsyn under vårdtiden.

Vid yrsel kan man även misstänka lillhjärnsinfarkt om det föreligger tecken till sk Wallenbergs syndrom/PICA: cirkulationsstörning/stroke i a cerebellaris inf post (eller a vertebralis) vilket ger yrsel, nystagmus, koordinationsrubblning av ena sidans extremiteter (hemiataxi), sväljningssvårighet, heshet, känselnedsättning i ansikte och motsatt sida på kroppen.

Spontan nystagmus:

Normalt impulstest eller vertikal spontan nystagmus vid akut vestibulärt syndrom talar mot vestibularisneuronit och ger misstanke om cerebellär infarkt. Likaså om ögonen gör vertikala refixationer vid "cover test" (= be pat. fixera undersökarens finger och täck för alternerande ena ögat på pat. Om denne då gör vertikala refixationer när ena ögat avtäckts kan detta vara symtom på hjärnstamsstroke).

Nyttillkommen ortostatism/svinningskänsla från liggande till stående kan tillsammans med förhöjd AF och PF ge indikation på att patienten är hypovolem. Överväg att först kontrollera liggande blodtryck och därefter stående blodtryck.

Vid uttalad svinningskänsla bör även arytm uteslutas.

- Dubbelseende - båda ögonen (Binokulär Diplopi) H53.2
- Facialispares G51.9
- Neurologiskt bortfall/TIA G45.9
- Stroke, misstanke om I64.9

Röda symtom

- Symtom som uppfyller kriterier för strockelarm/vaskulär intervention

Orange symtom

- DBT >120 mmHg
- Akut debuterat dubbelseende - båda ögonen (Binokulär Diplopi)
- Hydrocephalus/shunt
- Koagulationshämmande läkemedel eller blödningsbenägenhet
- Kräkningar/illamående/yrsel
- Patient med intermittenta bortfall inom 7 dygn
- Samtidig huvudvärk - måttlig/svår eller plötsligt debuterande
- Spontan para/tetraplegi

Gula symtom

- Övriga med kvarvarande eller övergående fokala bortfall

Gröna symtom

- Perifer facialispares utan andra symtom
- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

- | | |
|---|-----------------|
| ➔ Om Rädda hjärnan-larm | ➔ PVK |
| > Initiera larmkedja, sätt grov PVK och därefter till röntgen | ➔ NaCl-infusion |
| ➔ CVS-rutin | ➔ CVS-rutin |
| ➔ Blodgruppering | ➔ PVK |
| ➔ Bastest | ➔ NaCl-infusion |
| ➔ PVK | ➔ CVS-rutin |
| ➔ NaCl-infusion | ➔ PVK |
| ➔ CVS-rutin | ➔ NaCl-infusion |
| ➔ Blodgruppering | |

Kapillärt P-glucos

EKG

Bladderscan vid misstänkt stroke

- Skalltrauma, se istället ESS 30
- Trauma mot rygg, se istället ESS 31
- Yrsel, balanssvårigheter, se även ESS 11

RETTS faktaruta

Stroke är en av de vanligaste frågeställningar hos patienter med neurologiska symtom som söker på akutmottagningen. Viktigt är tidig CT i diagnostiken. Vid stroke finns ofta ett antal viktiga faktorer att ta hänsyn till vid prioritering, diagnostik och behandling. Det är särskilt viktigt att hitta patienten tidigt i förloppet vid misstanke om hjärninfarkt men också finna de patienter som eventuellt kan ha en blödning. Isolerade symtom som plötslig synrubbing kan vara tecken på stroke.

Perifer facialispares, har svårt att stänga ögat
Central facialispares, kan stänga ögat.

Binokulär diplopi (dubbelseende när båda ögonen är öppna): Uppstår när ögonen inte samarbetar korrekt. Orsaker kan vara:

- Skelning: Ögonen pekar inte åt samma håll.
- Muskelsvaghet: Problem med ögonmusklerna, t.ex. vid sjukdomar som myastenia gravis.
- Nervskador: Kan uppstå vid sjukdomar som multipel skleros eller efter en stroke.
- Trauma: Skador på ögonhålan eller nerverna.

Var observant på att symtom som "dubbelseende" (Binokulär diplopi) som drabbar båda ögonen samtidigt, kan vara tecken på stroke.

Plötslig förlust av rörelse/känselförmåga:

Vid spontan para/tetraplegi bör underliggande malignitet beaktas, då metastaserad sjukdom kan trycka på ryggmärgen och ge neurologiska bortfall. Ryggmärgskompression är en allvarlig komplikation hos cancerpatienter (tex prostata och bröstcancer). Tidig diagnos och behandling förbättrar livskvalitet och funktionella resultat.

Strockelarm aktiveras enligt lokal algoritm/PM vilket innebär att strockelarm kan utlösas oavsett medicinsk prioritet enligt RETTS. Strockelarm är kopplat till behandlingsstrategi och lokala åtgärder. Finns det indikation och möjlighet för intervention? Lokala rutiner finns både pre-hospitalt och hospitalt.

Vid övergående fokalneurologiska bortfallssymtom finns en ökad risk för reinfarcering. Patienten bör observeras och behandlas enligt nationella riktlinjer för vård vid stroke.

Infektion:

Patienter som tidigare haft stroke, kan i samband med infektion uppvisa strockeliknande symtom på grund av infektionen. Patienten skall dock alltid hanteras som strockemisstanke i första hand. Finns misstanke och tecken på infektion bör även den här orsaken beaktas så att tidig provtagning och behandling inleds. Symtom som kan indikera allvarlig infektion och kan leda till sepsis:

- Feber/skakfrossa/hypotermi

- Konfusion/vakenhetssänkning/motorisk oro
- Uttalad allmänpåverkan/allmän svaghet
- Andnöd/andfåddhet/takypné/dyspné
- Kräkning/diarré
- Smärta (ex buk)

Feber är vanligt men det är även vanligt att patienterna inte har feber eller är hypoterma. Framförallt i sköra patientgrupper. Desto kraftigare frossa desto större risk att det rör sig om feber

Alla patienter med sepsis har inte feber och tänk på att patienten kan ha tagit febernedsättande, som påverkar mätningen

OBS! Lägre temperatur vid ankomst är korrelerad till högre sjukhusdödlighet.

- Ledvärk utan trauma M25.5

Röda symtom

- Initialt / lägst SBT <90 mmHg
- Symtom och kliniska tecken som uppfyller nationella kriterier för sepsisalarm

Orange symtom

- Feber >38,5°C och frossa senaste 12 timmarna
- Immunosupprimerad patient
- Lokal infektion med svår smärta

Gula symtom

- Inopererat material/protes i värkande led
- Nydebuterad svår smärta
- Omöjligt att flektera/extendera
- Rodnad, svullen och öm led

Gröna symtom

- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

Rutinpaket + urat



Blododling



PVK



Rutinpaket + urat



Blododling



PVK

Kapillärt CRP

- Extremitetssymtom utan ledengagemang, se istället ESS 15
- Misstanke om allvarlig infektion, se även ESS 47
- Skada ben/fot, se istället ESS 34
- Skada hand/arm, se istället ESS 33

RETTS faktaruta

ESS 13 används för engagemang i eller ovan fot/handled. Den viktigaste åtgärden vid handläggning av patienter med ledvärk är kartläggningen av utbredningen, en eller flera leder, symtomdebut och duration.

Förekomst av feber/frossa samt lokal rodnad, eller allmänpåverkan.

Har patienten tidigare kirurgi mot leden eller inopererad protes?

Vid septisk artrit är det oftast stora leder inblandade och oftast en led.

Fråga om trauma i anamnesen.

Infektion:

Symtom som kan indikera allvarlig infektion och kan leda till sepsis:

- Feber/skakfrossa/hypotermi
- Konfusion/vakenhetssänkning/motorisk oro
- Uttalad allmänpåverkan/allmän svaghet
- Andnöd/andfåddhet/takypné/dyspné
- Kräkning/diarré
- Smärta (ex buk)

Feber är vanligt men det är även vanligt att patienterna inte har feber eller är hypoterma. Framförallt i sköra patientgrupper. Desto kraftigare frossa desto större risk att det rör sig om feber

Alla patienter med sepsis har inte feber och tänk på att patienten kan ha tagit febernedsättande, som påverkar mätningen

OBS! Lägre temperatur vid ankomst är korrelerad till högre sjukhusdödlighet.

- Ryggsmärta utan trauma M54.9
- Smärta i brösttryggen utan trauma M54.6
- Smärta nacke utan trauma M54.2

Röda symtom

- Thorakal plötsligt smärta samt blek/kallsvettig
- Thorakal plötslig smärta med medvetandeförlust

Orange symtom

- Feber >38,5°C och frossa senaste 12 timmarna
- Meningism/nackstelhet
- Nacksmärta med plötslig debut
- Nyttillkommen fekal-/urininkontinens
- Ridbyxeanestesi
- Thorakal plötslig smärta men ej blek/kallsvettig
- Urinretention

Gula symtom

- Koagulationshämmande läkemedel eller blödningsbenägenhet
- Smärta nacke med domningar/stickningar/smärta i arm
- Smärta rygg med domningar/stickningar/smärta i ben

Gröna symtom

- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

- | | |
|------------------|--------------------------|
| ➔ Hjärtrutin | ➔ Hjärtrutin eller Polop |
| ➔ Blodgruppering | ➔ Blodgruppering |
| ➔ Bastest | ➔ Bastest |
| ➔ PVK | ➔ PVK |
| ➔ EKG | ➔ EKG |

Urinsticka samt U-HcG på fertil kvinna
Bladderscan

- Buk eller flanksmärta, se istället ESS 6
- Kardiell genes - misstanke om, se istället ESS 5
- Misstanke om allvarlig infektion, se även ESS 47
- Smärta i nacke efter trauma, se istället ESS 30
- Smärta i rygg efter trauma, se istället ESS 31
- Samtidigt neurologiskt bortfall, överväg ESS 12

RETTS faktaruta

Vanligaste orsaken till akut ryggvärk är muskulära besvär utan annan organisk orsak. Därför är det viktigt att tidigt sortera ut de patienter som inte behöver kompletterande utredning utan rådgivning om smärtbehandling. De som har ett uppenbart akut insjuknande skall utredas och handläggas på annat sätt.

Ovarialtorsion:

Symtom som förekommer hos flickor/kvinnor är buksmärta med plötslig intensiv smärtdebut, lågt sittande med konstant smärtpunkt som ej avtar. Ej att förväxla med menstruationssmärta. Ovarialtorsion leder till syrebrist i vävnaden (ischemi) och har genom sitt läge i buken en symptomatologi och förlopp som är svårare att både misstänka, bekräfta eller avfärda på ett säkert sätt. Vid låg buk/ryggsmärta skall alltid möjligheten till bakomliggande ovarialtorsion övervägas och uteslutas. (ESS 6)

Vid upprepade och långvariga besvär i kombination med relativt opåverkad patient som saknar symtom och tecken enligt ESS 14, kan man ofta använda en annan vårdnivå än akutmottagningen.

Ridbyxeanestesi är känselnedsättning på lårens insidor, könsorgan och säte; specifikt vid skada på korsryggens nervrötter.

Urinretention är oförmåga att kasta urin.

Smärta med oklar genes skall genomgå kompletterande diagnostik. Vaskulär genes bör uteslutas.

Riskfaktorer för aortaaneurysm:

Rökning, hypertoni och ärftlighet.

Riskfaktorer för akut aortadissektion:

Marfans syndrom, aortasjukdom i släkten, känd aortaklaffsjukdom, nyligen inträffad aortamanipulation eller bröstaortaaneurysm.

- Extremitetsbesvär M79.6
- Smärta i extremitet M79.6
- Svullnad i extremitet R22.4
- Underbensödem R60.0

Förberedande åtgärder

- EKG - vid misstanke om kardiell genes

Röda symtom

- Initialt / lägst SBT <90 mmHg
- Symtom och kliniska tecken som uppfyller nationella kriterier för sepsisalarm

Orange symtom

- Feber >38,5°C och frossa senaste 12 timmarna
- Hematom med svullnad i ljumske - snabbt växande
- Plötslig debut med svår smärta
- Påverkat distalstatus (Obs cirkulation)

Gula symtom

- Ensidig smärta/konsistensökning/svullnad
- Hematom med svullnad i handled - snabbt växande
- Inopererat material/protes
- Koagulationshämmande läkemedel eller blödningsbenägenhet
- Nydiagnostiserad DVT

Gröna symtom

- Bilateral underbensödem utan samtidig dyspné
- Återkommande eller i karaktär oförändrat lymfödem
- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

- | | |
|--|--|
| ➡ Trombosrutin (Om bilateral svullnad lägg till Troponin + Pro-BNP) | ➡ PVK |
| ➡ Vid feber >38,5: Rundodling och Myoglobin | ➡ Kapillärt CRP |
| ➡ PVK | ➡ EKG |
| ➡ Kapillärt CRP | ➡ Trombosrutin (Om bilateral svullnad, lägg till Troponin + Pro-BNP) |
| ➡ EKG | ➡ PVK |
| ➡ Trombosrutin (Om bilateral svullnad, lägg till Troponin + Pro-BNP) | ➡ Kapillärt CRP |
| ➡ Vid feber >38,5: Rundodling och Myoglobin | ➡ EKG |

Om patienten har en nyligt konstaterad DVT och inte står på AK-behandling, lägg till propaket: Inför antikoagulantia

- Ledbesvär, se istället ESS 13
- Misstanke om allvarlig infektion, se även ESS 47
- Samtidig dyspné, se istället ESS 4
- Samtidig skada arm, se istället ESS 33
- Samtidig skada ben, se istället ESS 34

RETTS faktaruta

Akut smärta, molande värk eller strålande smärta arm/armar kan vara av kardiell genes (sk, referred pain). De här och liknande symtom i övre extremitet kan ibland upplevas diffusa och missvisande då de kan uppträda enskilt, spontant eller i samband med eller efter fysisk ansträngning utan andra påvisade kardinalsymtom för kardiell ischemi.

Hos patienter med känt eller okänt förmaksflimmer kan kardiella embolier occludera extremitetskärl. Akut påkommen kall extremitet föranleder alltid kontakt med kärlkirurg (detta måste ske utan fördröjning, extremiteten är hotad).

Vissa hematologiska sjukdomar (exempel: sickelcellsanemi) ger också ökad risk för tromboembolism (blodpropp), liksom vid graviditet, nyligen förlösta och hormonbehandlade patienter. Vid sickelcellsanemi, tänk på vätska och smärtstillande.

Vid samtidig frossa och svår värk, skall nekrotiserande fasciit misstänkas och då är patienten alltid orange tills diagnosen har uteslutits. Dessa tillstånd är förenade med hög mortalitet (akutsjukvård direkt!). Vid misstanke blododla patienten så fort möjlighet ges.

Infektion:

Symtom som kan indikera allvarlig infektion och kan leda till sepsis:

- Feber/skakfrossa/hypotermi
- Konfusion/vakenhetssänkning/motorisk oro
- Uttalad allmänpåverkan/allmän svaghet
- Andnöd/andfäddhet/takypné/dyspné
- Kräkning/diarré
- Smärta (ex buk)

Feber är vanligt men det är även vanligt att patienterna inte har feber eller är hypoterma. Framförallt i sköra patientgrupper. Desto kraftigare frossa desto större risk att det rör sig om feber

Alla patienter med sepsis har inte feber och tänk på att patienten kan ha tagit febernedsättande, som påverkar mätningen OBS! Lägre temperatur vid ankomst är korrelerad till högre sjukhusdödlighet.

DVT kan misstänkas om svullnaden/konsistensökningen är ensidig och eller patienten upplever ömhet/smärta.

Wells kriterier (Wells score) är ett poängbaserat diagnostikstöd för att prediktera sannolikhet för DVT och ger ytterligare stöd.

- Blod i urin/hematuri R31.9
- KAD-relaterade problem Y84.6
- Smärta vid vattenkastning R30
- Urinretention R33.9
- Urinvägsproblem N39.0

Förberedande åtgärder

- Hb g/L vid hematuri - om möjligt

Röda symtom

- Hematuri samt Hb <70 g/L eller initialt / lägst SBT <90 mmHg
- Symtom och kliniska tecken som uppfyller nationella kriterier för sepsislarm

Orange symtom

- Feber >38,5°C och frossa senaste 12 timmarna
- Hematuri samt Hb <90 g/L
- Makroskopisk hematuri samt koagulationshämmande läkemedel eller blödningsbenägenhet

Gula symtom

- Akut buksmärta samt urinproblem
- Makroskopisk hematuri
- Percutana urinkateterkomplikationer
- Urinretention samt blek/kallsvettig

Gröna symtom

- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

- | | |
|--|---|
| ➔ Rutinpaket | ➔ Om infektionstecken och feber >38,5: Rundodling |
| ➔ PVK | ➔ Om blödning: Blodgruppering och Bastest |
| ➔ Om infektionstecken och feber >38,5: Provpaket | ➔ Kapillärt HB + CRP |
| Stort trauma/chock /hjärtstopp och rundodling | ➔ Om bladderscan visar >700ml, ta rutinpaket |
| ➔ Om blödning: Blodgruppering och Bastest | ➔ Kapillärt HB + CRP |
| ➔ Rutinpaket | ➔ Om bladderscan visar >700ml, ta rutinpaket |
| ➔ PVK | |

Bladderscan

Vid >700ml urin sätt KAD. Vid <700ml urin, tappa med tappningskateter
Urinsticka

- Buksmärta, överväg ESS 6
- Misstanke om allvarlig infektion, se även ESS 47

RETTS faktaruta

De bakomliggande faktorerna vid vattenkastningssmärta är många. Fråga efter tidigare symtom av liknande karaktär. Makroskopisk hematuri kan ha olika akuticitet men skall alltid föranleda ställningstagande till utredning som i de flesta fall kan ske polikliniskt.

Vid miktionsveda bör också könssjukdom beaktas

Percutan urinkateter innebär ökad infektionsrisk för patienten och vid komplikationer skall dessa patienter hanteras enligt lokal rutin.

Infektion:

Symtom som kan indikera allvarlig infektion och kan leda till sepsis:

- Feber/skakfrossa/hypotermi
- Konfusion/vakenhetssänkning/motorisk oro
- Uttalad allmänpåverkan/allmän svaghet
- Andnöd/andfåddhet/takypné/dyspné
- Kräkning/diarré
- Smärta (ex buk)

Feber är vanligt men det är även vanligt att patienterna inte har feber eller är hypoterma. Framförallt i sköra patientgrupper. Desto kraftigare frossa desto större risk att det rör sig om feber

Alla patienter med sepsis har inte feber och tänk på att patienten kan ha tagit febernedsättande, som påverkar mätningen

OBS! Lägre temperatur vid ankomst är korrelerad till högre sjukhusdödlighet.

- Skrotal smärta N50.8
- Skrotal svullnad N50.8D
- Besvär i penis/urinrör N50.9

Röda symtom**Orange symtom**

- Smärta skrotum - intermittent måttlig till kraftig < 48 timmar
- Smärtande resistens i skrotum - ej reponibelt
- Priapism/paraphimosis
- Pågående smärta skrotum - måttlig till kraftig med plötslig debut < 12 timmar

Gula symtom

- Övrig smärta

Gröna symtom

- Pungbräck, utan smärta - misstanke om nydebuterat
- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

- | | |
|------------------|------------------|
| ➔ Polop | ➔ Polop |
| ➔ Blodgruppering | ➔ Blodgruppering |
| ➔ Bastest | ➔ Bastest |
| ➔ PVK | ➔ PVK |

Urinprov

OBS! Vid provtagning av klamydia och gonorré i urin, tänk på att inte använda vanliga urinodlingsrör utan "Realtime multicollect P-cap", provet blir annars ej bedömbart. Se provtagningsanvisningar på Linda.

- Gynekologiska besvär, se istället ESS 21
- Skada/trauma, se istället ESS 31

RETTS faktaruta

Orsaken till skrotal smärta kan vara epididymit som förekommer i alla åldrar men ovanligt före puberteten. Testistorsion drabbar oftast pojkar och yngre män och karaktäriseras av plötslig eller intermittent insättande ensidig, skrotal smärta med svullnad. Omedelbar urologkontakt är viktig/obligatorisk vid misstanke om testistorsion. Hos äldre män kan smärtan vara orsakad av pungbräck.

- Huvudvärk R51.9
- Neuralgi/nervsmärta M79.2

Röda symtom

- SBT ≥ 180 samt gravid
- DBT ≥ 120 samt gravid
- Initialt / lägst SBT <90 mmHg
- Symtom och kliniska tecken som uppfyller nationella kriterier för sepsisalarm

Orange symtom

- Anamnes på medvetandeförlust
- Feber $>38,5^{\circ}\text{C}$ och frossa senast 12 timmarna
- Inopererad shunt
- Koagulationshämmande läkemedel eller blödningsbenägenhet
- Kraftigt huvud-/nack-/halsvärk med plötslig debut de senaste 24 timmarna
- Meningism/Nackstelhet
- Plötslig yrsel med samtidig huvudvärk
- SBT ≥ 160 samt gravid
- DBT ≥ 110 samt gravid

Gula symtom

- SBT >240 mmHg (upprepade mätningar)
- DBT >140 mmHg (upprepade mätningar)

Gröna symtom

- Övrig huvudvärk
- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

- | | |
|--|--|
| ➔ CVS-rutin | ➔ Rundodling vid meningism/nackstelhet eller feber $>38,5$ |
| ➔ Rundodling vid meningism/nackstelhet eller feber $>38,5$ | ➔ Blodgruppering |
| ➔ Blodgruppering | ➔ Bastest |
| ➔ Bastest | ➔ PVK |
| ➔ PVK | ➔ EKG |
| ➔ EKG | ➔ Bladderscan |
| ➔ Bladderscan | ➔ U-HcG på fertil kvinna |
| ➔ U-HcG på fertil kvinna | ➔ CVS-rutin |
| ➔ CVS-rutin | ➔ EKG |

- Gravid patient, se även ESS 21
- Misstanke om allvarlig infektion, se även ESS 47
- Nacksmärta utan trauma, se istället ESS 14
- Neurologiskt bortfall/TIA, se istället ESS 12
- Trauma mot huvud/nacke, se istället ESS 30

RETTS faktaruta

Åskknallshuvudvärk är ett kardinalsymtom vid subarachnoidalblödning och kan vara en mindre sk varningsblödning och skall tas på största allvar. Åskknallshuvudvärk innebär att huvudvärken kommer plötsligt. Hos dessa patienter skall alltid subarachnoidalblödning misstänkas och uteslutas.

Meningism definieras som patienten med huvudvärk, allmänpåverkad och med en reflektorisk nackstelhet vid passiv (undersökaren böjer huvudet framåt) flexion i nacken.

Symtom som kan indikera allvarlig infektion och kan leda till sepsis:

- Feber/skakfrossa/hypotermi
- Konfusion/vakenhetssänkning/motorisk oro
- Uttalad allmänpåverkan/allmän svaghet
- Andnöd/andfåddhet/takypné/dyspné
- Kräkning/diarré
- Smärta (ex buk)

Feber är vanligt men det är även vanligt att patienterna inte har feber eller är hypoterma. Framförallt i sköra patientgrupper. Desto kraftigare frossa desto större risk att det rör sig om feber

Alla patienter med sepsis har inte feber och tänk på att patienten kan ha tagit febernedsättande, som påverkar mätningen

OBS! Lägre temperatur vid ankomst är korrelerad till högre sjukhusdödlighet.

Högt blodtryck är inget akut tillstånd men skall hanteras enligt lokal rutin.

Hypertoni -högt blodtryck- hos gravid är dock ett observandum och kan vara ett tecken på preeklampsi. Hypertoni kan debutera under graviditeten (efter v 20+0) och kallas då graviditetshypertoni. Kvinnan kan också vara diagnostiserad innan hon blir gravid och har då en essentiell hypertoni. Hos gravida skall blodtrycket observeras och monitoreras. Hos gravida skall blodtrycket inte överstiga 160/110 mmHg, kan vara tecken på preeklampsi.

- Medvetandeförlust R40.2
- Svimning/syncope R55.9

Röda symtom**Orange symtom**

- Blek/kallsvettig
- Medvetandeförlust vid fysisk ansträngning
- Upprepade medvetandeförluster

Gula symtom

- En medvetandeförlust

Gröna symtom

- Svimningskänsla utan faktisk medvetandeförlust

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| ➔ CVS-rutin | ➔ EKG-uppkoppling |
| ➔ Blodgas | ➔ Bladderscan |
| ➔ Blodgruppering | ➔ CVS-rutin |
| ➔ PVK | ➔ PVK |
| ➔ EKG-uppkoppling | ➔ P-glucos |
| ➔ Bladderscan | ➔ EKG |
| ➔ CVS-rutin | ➔ Ortostatiskt blodtryck |
| ➔ Blodgas | ➔ P-glucos |
| ➔ Blodgruppering | ➔ EKG |
| ➔ PVK | ➔ Ortostatiskt |

U-HcG på fertil kvinna

- Gravid patient, se även ESS 21
- Misstanke om kardiell genes, se ESS 1
- Samtidig bröstsmärta, se istället ESS 5
- Yrsel, se ESS 11

RETTS faktaruta

Guide till alternativa söksaker;

Denna ESS skall enbart användas vid isolerad medvetandeförlust. Vid andra samtidiga symtom se istället aktuell ESS.

Nyttillkommen ortostatism/svimningskänsla från liggande till stående:

Överväg att först kontrollera liggande blodtryck och direkt därefter kontrollera stående blodtryck.

Fråga efter trauma i anamnesen.

Definition medvetandeförlust: svimning eller syncope, dvs där medvetandeförlust uppges av patienten eller anhörig/bystander.

Svimning är ett mycket vanligt symtom och kan bedömas enbart med anamnes och ett kliniskt status för att avgöra om det finns en bakomliggande sjukdom. Plötslig medvetandeförlust utan föregående symtom och utan misstanke om krampsjukdom kan behöva högre prioritet. Samtidigt är det ibland svårt att skilja medvetandeförlust med arytmier från psykosomatiska symtom.

Försök att anamnestiskt skilja på medvetandeförlust, dvs de med prodromalsymtom (förkänningar) och de där patienten plötsligt faller ihop och vaknar upp på golvet.

Patienter som haft förkänning vid svimning och kommer ihåg allt före och efter har oftast endast benign svimning.

- Graviditet Z32.1
- Gynekologiska besvär N92.6
- Högt blodtryck samt gravid
- Postpartum <30 dagar Z39.0
- Underlivsbesvär N94.9
- Vaginal blödning N93.9

Förberedande åtgärder

- Hb g/L - om möjligt

Röda symtom

- Gravid med pågående mycket stor vaginal blödning
- Hb <70 g/L
- Initialt / lägst SBT <90 mmHg (gravid - Initialt / lägst SBT <80 mmHg)
- Symtom och kliniska tecken som uppfyller nationella kriterier för sepsisalarm
- Pågående förlossning
- Pågående smärta med plötslig smärtdebut samt blek/kallsvettig
- SBT ≥180 samt gravid
- DBT ≥120 samt gravid

Orange symtom

- Aktuell krampfall hos gravid patient
- Buksmärta av intervallkaraktär
- Feber >38,5°C och frossa senaste 12 timmarna
- Hb <90 g/L
- Immunosupprimerad patient
- Koagulationshämmande läkemedel eller blödningsbenägenhet samt pågående blödning
- Vaginal blödning - mycket stor
- Postpartum och anamnes på feber
- SBT ≥160 samt gravid
- DBT ≥110 samt gravid

Gula symtom

- Hb < 100 g/L
- Stor vaginal blödning
- Övriga med ihållande buksmärta

Gröna symtom

- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

- Buksmärta, se även ESS 6
- Misstanke om allvarlig infektion, se även ESS 47

RETTS faktaruta

Denna algoritm/ESS skiljer sig från Buksmärta ESS 6 i det att den skall fånga problem från retroperitoneala organ hos kvinnor. 10-15% av alla kliniska graviditeter slutar i missfall. Tänk på att ett missfall kan upplevas olika och det är viktigt att patienten får stöd och uppföljning om hon önskar, även om ett okomplicerat missfall inte får en hög prioritet/har en hög medicinsk risk.

Hypertoni -högt blodtryck- hos gravid är ett observandum och kan vara ett tecken på preeklampsi. Hypertoni kan debutera under graviditeten (efter v 20+0) och kallas då graviditetshypertoni. Kvinnan kan också vara diagnostiserad innan hon blir gravid och har då en essentiell hypertoni. Hos gravida skall blodtrycket observeras och monitoreras.

Av kvinnor som får graviditetshypertoni före graviditetsvecka 37 kommer cirka 40 % att utveckla preeklampsi. Riskfaktorer för att utveckla preeklampsi är ålder > 40 år, diabetes, högt BMI, hereditet, tidigare preeklampsi, njursjukdom. preeklampsi (PE) innebär hypertoni i kombination med signifikant proteinuri och är alltid en allvarlig komplikation under graviditet. Tillståndet kan debutera innan, under och inom en vecka efter förlossning. Kliniska symtom är huvudvärk, epigastriesmärta, smärta under hö arcus och synpåverkan. Hyperreflexi och fotklonus ses i allvarliga fall. Symtomen kan initialt vara diskreta men tillståndet kan snabbt utvecklas till svår preeklampsi och eklampsi. eklampsi innebär generella kramper och medvetandeförlust. För att förebygga eklampsi ges Magnesium som bolusdos och efterföljande infusion.

Ovarialtorsion:

Symtom som förekommer hos flickor/kvinnor är buksmärta med plötslig intensiv smärtdebut, lågt sittande med konstant smärtpunkt som ej avtar. Ej att förväxla med menstruationssmärta. Ovarialtorsion leder till syrebrist i vävnaden (ischemi) och har genom sitt läge i buken en annan symtomatologi och förlopp som är svårare att både misstänka, bekräfta eller avfärda på ett säkert sätt. Vid låg buk/ryggsmärta skall alltid möjligheten till bakomliggande ovarialtorsion övervägas och uteslutas.

Icke fertil = oförmåga att bli gravid. Här menar vi t.e.x en patient som är hysterektomerad (kan blöda från underlivet vid patologi), säkra preventivmedel (spiral som sitter kvar), steriliserad eller med säkerhet genomgått menopaus.

Följ lokala anvisningar kring hänvisning till förlossning eller gynnottagning.

Blödning definieras:

- Mycket stor vaginal blödning; blödning eller koagler genom en normal binda på mindre än 30 min (utan tecken på att avta)
- Stor vaginal blödning; kraftigare än en riklig mens med eller utan koagler. Blöder genom en normal binda mellan 30 min och 2 timmar

Lokala processåtgärder

➔ Bukrutin	➔ Bukrutin
➔ Blodgas	➔ Blodgas
➔ Blodgruppering	➔ Blodgruppering
➔ Bastest	➔ Blododling vid feber och postpartum
➔ Blododling vid feber och postpartum	➔ PVK
➔ PVK x2	➔ Plasmalyte
➔ Plasmalyte	➔ Bladderscan
➔ Bladderscan	

Urinsticka samt U-HcG på fertil kvinna
Kapillärt CRP

- Riklig vaginal blödning: blöder genom en normal binda mellan 2 till 6 timmar
- Måttlig vaginal blödning: mindre blödning som blöder genom en normal binda på mer än 6 timmar (större blödning än tunna strimmor av blod)
- Sparsam vaginal blödning: tunna strimmor av blod/trosskydd

Infektion:

Symtom som kan indikera allvarlig infektion och kan leda till sepsis:

- Feber/skakfrossa/hypotermi
- Konfusion/vakenhetssänkning/motorisk oro
- Uttalad allmänpåverkan/allmän svaghet
- Andnöd/andfåddhet/takypné/dyspné
- Kräkning/diarré
- Smärta (ex buk)

Feber är vanligt men det är även vanligt att patienterna inte har feber eller är hypoterma. Framförallt i sköra patientgrupper. Desto kraftigare frossa desto större risk att det rör sig om feber

Alla patienter med sepsis har inte feber och tänk på att patienten kan ha tagit febernedsättande, som påverkar mätningen

OBS! Lägre temperatur vid ankomst är korrelerad till högre sjukhusdödlighet.

- Gulsot/ikterus R17.9
- Ascites R18.9

Röda symtom

- Initialt / lägst SBT <90 mmHg
- Symtom och kliniska tecken som uppfyller nationella kriterier för sepsisalarm

Orange symtom

- Feber >38,5°C och frossa senaste 12 timmarna

Gula symtom

- Ascites/ökat bukomfång med eller utan ikterus
- Ikterus och feber

Gröna symtom

- Ikterus utan andra symtom

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

- | | |
|---|---|
| ➡ Bukrutin | ➡ Blododling vid feber >38,5 och frossa |
| ➡ Blododling vid feber >38,5 och frossa | ➡ PVK |
| ➡ PVK | ➡ Bukrutin |
| ➡ Bukrutin | ➡ Bukrutin |
- Bladderscan

- Misstanke om allvarlig infektion, se även ESS 47
- Samtidig buksmärta, se istället ESS 6

RETTS faktaruta

Gulsot är relativt ovanligt hos tidigare friska vuxna. Gulsoten kan dock även bero på allvarliga sjukdomar som hemolys, gallvägsmissbildning, sepsis eller annan infektion.

Gulsot kan ses vid leversjukdom, störningar i gallflödet och vid ökat sönderfall av röda blodkroppar (hemolys).

Infektion:

Symtom som kan indikera allvarlig infektion och kan leda till sepsis:

- Feber/skakfrossa/hypotermi
- Konfusion/vakenhetssänkning/motorisk oro
- Uttalad allmänpåverkan/allmän svaghet
- Andnöd/andfåddhet/takypné/dyspné
- Kräkning/diarré
- Smärta (ex buk)

Feber är vanligt men det är även vanligt att patienterna inte har feber eller är hypoterma. Framförallt i sköra patientgrupper. Desto kraftigare frossa desto större risk att det rör sig om feber

Alla patienter med sepsis har inte feber och tänk på att patienten kan ha tagit febernedsättande, som påverkar mätningen

OBS! Lägre temperatur vid ankomst är korrelerad till högre sjukhusdödlighet.

- Hängning/strykning Y20
- Käkskada S02.2
- Skada huvud/ansikte/näsa S09.9
- Skada nacke/hals S11.9
- Tandskada K03.8

Förberedande åtgärder

- Uteslut traumalarmskriterier ESS 38

Röda symtom

- Ansikts/halsskada med hotad luftväg (se ESS 38)
- Misstänkt ryggmärgsskada (se ESS 38)
- Penetrerande våld mot hals, huvud (se ESS 38)
- Öppen skallskada/impressionsfraktur (se ESS 38)
- Hängningsförsök- symtom efter
- Neurologiska bortfall
- Pulserande blödning i/på halsen
- Pulserande blödning på huvudet som ej är kontrollerbar med kompression
- Strykningsförsök- symtom efter

Orange symtom

- Berusad/intoxikerad
- Blödning/vätska från hörselgång
- Fraktur skalle/ansiktsskelett/nacke exkl näsa - misstanke om
- Koagulationshämmande läkemedel eller blödningsbenägenhet
- Luxation käkled - misstanke om
- Pulserande blödning - kontrollerbar med risk för reblödning
- Påverkat mentalt status

Gula symtom

- ≥ 2 kräkningar
- Hematom/blåaktig svullnad på ytteröra
- Hörselnedsättning - nyttillkommen i samband med skada
- Medvetslöshet/amnesi - i samband med skada
- Misshandel
- Fraktur näsa - utan misstanke om andra skador
- Shunt inopererad
- Sårskada - djup/sutureringskrävande
- Över 65 år med behandling av ASA eller andra trombocythämmare

Gröna symtom

- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

- Förgiftning, se även ESS 40
- Traumalarmskriterier, se ESS 38
- Ögonskada, se även ESS 37

RETTS faktaruta

Patienter som fyllt 65 år, som behandlas med trombocythämmare, skall till vårdinrättning för bedömning av behovet av en CT.

Vid skada mot huvud/hals är det viktigt att fråga efter om patienten äter koagulationshämmande läkemedel vilket kan ge ökad blödningsbenägenhet.
(Läs mer om ökad blödningsbenägenhet i "RETTS - Riktlinjer för bedömning av antitrombotiska läkemedel och blödningsbenägenhet".

Pulserande blödning:
Misstänkt arteriell blödning i regionen.

Skador i/på ansikte kan ibland vara kombinerat med ögonskada och ansiktsfraktur.
Misstanke om sådan ger automatiskt högre prioritet till läkare (lägst orange).

Frakturer på skallen:

En skallfraktur räknas som infekterad (förorenad) om det finns en öppning genom den överliggande huden, samt när frakturen omfattar bihålorna eller mellanörat.

Öppna eller slutna frakturer på kraniet kan delas in i:

1) Linjära frakturer - längsgående frakturer på sidan av huvudet (vanligast förekommande) med risk för bristningar och sprickor i blodkärlen, den vanligaste orsaken till epiduralblödning.

2) Stämpelfraktur (impressionsfraktur) - skallen är intryckt - krossfraktur med multipla benfragment

3) Skallbasfraktur - "botten" av skallen.

Skallbasfrakturer kan skada blodkärlen, dessa medför också ofta skador på hjärnnerver och kan leda till hjärnhinneinflammation.

Symtom som kan vara förenat med skallbasfraktur:

- Blödning/vätska från hörselgång, på grund av trauma mot huvud.

- (Förväxla ej med vätska från hörselgången relaterat till skada mot inneröra i anamnes) - se även ESS 45 Öronproblem.

- Hematom bakom örat (Battles tecken).

- Hematom kring ögonen (Brillenhematom) kan vara förenat med skallbasfraktur.

- Hörselbortfall kan tyda på fraktur i hörselbenen, blod i mellanörat eller skada på hörselnerven.

- Bortfall av luktsinne och syn kan bero på skada på luktnerven och synnerven.

- Dubbelseende och nedsatt syn kan bero på skador på hjärnnerverna som går till ögonmusklerna, eller en fraktur på skelettet i ögonbotten.

- Felställt bett/svårt att gapa.

Fraktur nacke:

Misstanke om fraktur på nackkotpelare med neurologisk

Lokala processåtgärder

- | | |
|---|----------------------|
| ➔ Överväg traumalarm | ➔ Överväg traumalarm |
| ➔ Provpaket: Stort trauma /chock/hjärtstopp | ➔ Liten traumarutin |
| ➔ Blodgas | ➔ Blodgas |
| ➔ Blodgruppering | ➔ Blodgruppering |
| ➔ Bastest | ➔ PVK |
| ➔ PVK x2 | ➔ EKG-uppkoppling |
| ➔ EKG-uppkoppling | |

Commotioobs vid medvetslöshet/amnesi i samband med skada, kontrollera medvetandegrad, pupiller, puls och blodtryck varje 30min under 6 timmar (efter ankomst till akutmott)

påverkan ger medicinsk risknivå Röd.

Misstanke om fraktur på nackkotpelare utan neurologisk påverkan ger medicinsk risknivå Orange.

Skelettskada näsa:

Näsbensfraktur utan tecken på andra skador (isolerad) ger medicinsk risknivå Gul.

Luxation av käkled:

Kan förekomma efter trauma men också spontant i samband med käkrörelse. Käkluxation måste tas på allvar eftersom det i närheten finns både kärl och nerver som kan skadas. Konsultera vid behov ÖNH- konsult eller tandläkare.

Kraftig svullnad i huvud/halsregionen kan vara förenat med ökad risk för att andningsvägarna kan påverkas och kan medföra sväljningssvårigheter.

Motoriskt orolig patient skall vara ett observandum.

Med Berusad/intoxikerad menas när patienten har intagit alkohol /droger i sådan mängd där det är svårt att värdera den primära orsaken till patientens avvikande beteende.

Vid misstänkt commotio/hjärnskakning se lokala processåtgärder.

- Skada buk S39.9
- Skada könsorgan S30.2
- Skada thorax/rygg S29.9

Förberedande åtgärder

- Uteslut traumalarmskriterier ESS 38

Röda symtom

- Instabil/deformerad bröstorg (se ESS 38)
- Misstänkt ryggmärgsskada (se ESS 38)
- Penetrerande våld mot bål (se ESS 38)
- Andningskorrelerad thorakal smärta samt blek/kallsvettig
- Avsaknad av ensidiga andningsljud - nyttillkommen vid skada
- Halsvenstas
- Neurologiska bortfall
- Subcutana emfysem - skadetillfälle mindre än 2 timmar

Orange symtom

- Blödning rektal/vaginal - debut efter skada
- Buksmärta/bukomfång - tilltagande
- Fraktur på rygg utan neurologiskt bortfall (se faktaruta) - misstanke om
- Koagulationshämmande läkemedel eller blödningsbenägenhet samt pågående blödning
- Skada scrotum med kraftig smärta/ödem
- Subcutana emfysem
- Urinstämna/kraftig hematuri

Gula symtom

- Fraktur på bröstorg (se faktaruta) - misstanke om
- Misshandel
- Skada underliv samt mindre yttre svullnad/blödning
- Sårskada - djup/sutureringskrävande
- Trauma mot buk

Gröna symtom

- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

- | | |
|---|---|
| ➡ Överväg traumalarm | ➡ Överväg traumalarm |
| ➡ Provpaket. Stort trauma /chock/hjärtstopp | ➡ Provpaket. Stort trauma /chock/hjärtstopp eller liten traumarutin |
| ➡ Blodgas | ➡ Blodgas |
| ➡ Blodgruppering | ➡ Blodgruppering |
| ➡ Bastest | ➡ Bastest |
| ➡ PVK x2 | ➡ PVK |
| ➡ EKG-uppkoppling | ➡ EKG |

Urinsticka

Bladderscan vid misstanke om urinstämna

- Traumalarmskriterier, se ESS 38

RETTS faktaruta

Denna typ av skada föranleder alltid ett ställningstagande om särskild traumalarmsalgoritm skall användas, se ESS 38

Misstänk ryggfraktur vid:

- Måttlig/kraftig smärta centralt över kolumna vid palpation
- Axielt våld (våld ovanifrån mot huvud som komprimerat kolumna)
- Oförmåga eller ovilja att röra huvud
- Överväg vid pat >65 år även vid subtilare fynd

Misstänk fraktur bröstorg vid:

- Kraftig smärta över bröstorgen efter trauma

- Hematom/svullnad/blåmärke T14.0
- Skrubbsår T14.0B
- Skärsår T14.1
- Sårskada T14.1

Förberedande åtgärder

- Se ALLTID ÄVEN skadekort ESS 30-31 samt ESS 33-37
- Uteslut Traumalarmskriterier ESS 38

Röda symtom

- Skärskada - ymnig/pulserande blödning - ej kontrollerbar

Orange symtom

- Koagulationshämmande läkemedel eller blödningsbenägenhet samt pågående blödning

Gula symtom

- Skärskada på extremitet - ytlig med omfattande sår längd - ej pulserande (se även ESS 86)
- Sårskada på extremitet med lokala infektionssymtom (se även ESS 47)

Gröna symtom

- Hematom/bula/lindrig sårskada på huvudet - lätt/avstannad blödning
- Hematom/bula/sårskada i ansiktet - ymnig blödning - komprimerbar/kontrollerad
- Skadad nagel
- Sticka i finger/hand/fot - djupt sittande som kräver sjukvårdsinsats
- Skrubbsår på extremitet - smutsigt/kapillärblödning som kräver bedömning och rengöring

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av sjukvård

Lokala processåtgärder

- | | |
|--|--------------------------------------|
| ➡ Överväg traumalarm | ➡ Liten traumarutin |
| ➡ Provpaket: Stort trauma /chock/hjärtstopp | ➡ Blodgas |
| ➡ Blodgas | ➡ Blodgruppering |
| ➡ Blodgruppering | ➡ Bastest |
| ➡ Bastest | ➡ Kapillärt Hb |
| ➡ Överväg tourniquet vid ej kontrollerbar blödning på extremitet | ➡ Kapillärt CRP vid infektionstecken |

- Brännskada, se istället ESS 35
- Självskadebeteende, se även ESS 86
- Skada huvud, se även ESS 30
- Skada buk, könsorgan, thorax/rygg, se istället ESS 31
- Traumalarmskriterier, se ESS 38
- Övrig sekundärinfektion, se även ESS 47

RETTS faktaruta

ESS 32 är ett nytt kort för sårskador i olika omfattning. Kortets syfte är att komplettera övriga skadekort med överlappning på vissa symtom/kriterier.

ESS 32 ersätter inte de skador som kan hanteras i skadekort ESS 30-31 och 33-38. Vårdaren behöver därför ALLTID först bedöma om skadans art istället kan triageras utifrån skadekort ESS 30-31 och 33-37 och Traumakort ESS 38.

Sårskador i mindre omfattning kräver inte alltid akutsjukvård och behandlas ofta lokalt med sterilisering och omplåstring på annan sjukvårdsinrättning och ibland prehospitalt. Lite större lokala sårskador avseende på längd eller djup kan kräva tejpnig, limning eller suturering och i de fallen behöver patienten därför komma till sjukvårdsinrättning som kan hantera detta.

Nekrotiserande faciit:

Tänk på att även små sår kan utvecklas till allvarlig infektion. Mindre sårskador med lokala infektionstecken såsom var-ansamling kan behöva tömmas, rengöras och omplåstras. En bedömning av risken för infektionsspridning skall alltid göras utifrån ESS 47.

- Skada axel/nyckelben S49.9
- Skada arm/handled S69.9
- Skada hand/finger S66.3

Förberedande åtgärder

- Uteslut traumalarmskriterier ESS 38

Röda symtom

- ≥ 2 frakturer på långa rörben (se ESS 38)
- Amputation ovan handled (se ESS 38)
- Penetrerande våld mot övre extremiteter ovan armbåge (se ESS 38)
- Stor yttre blödning (se ESS 38)
- Fraktur/luxation samt pulslös perifert om skada

Orange symtom

- Amputation - nedom handled exkl fingertopp
- Distalstatus - sensoriskt/motoriskt total bortfall
- Fraktur/luxation - öppen/felställning - exkl. fingrar, felställda nyckelben
- Koagulationshämmande läkemedel eller blödningsbenägenhet samt pågående blödning
- Smärta och tecken på kompartmentsyndrom

Gula symtom

- Amputation/delvis amputerad fingertopp
- Blödning - kontrollerbar
- Distalstatus - sensoriskt/motoriskt lätt nedsatt
- Fraktur i armbågsled/långa rörben/axelled - sluten/ej felställd - misstanke om
- Fraktur/luxation i fingrar - felställning/öppen
- Misshandel
- Sårskada - djup/sutureringskrävande

Gröna symtom

- Inget av ovanstående
- Fraktur/luxation övrigt - misstänkta/konstaterade

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

- | | |
|---|---|
| ➡ Överväg traumalarm | ➡ Överväg tourniquet vid amputationsskada |
| ➡ Provpaket: Stort trauma /chock/hjärtstopp | ➡ Liten traumarutin |
| ➡ Blodgas | ➡ Kapillärt Hb |
| ➡ Blodgruppering | ➡ Blodgruppering |
| ➡ Bastest | ➡ Bastest |
| ➡ PVK | ➡ PVK |

Kapillärt Hb

- Smärta/svullnad i extremitet utan trauma, se istället ESS 15
- Sekundärinfektion i/nära led, se även ESS 13
- Traumalarmskriterier, se ESS 38
- Övrig sekundärinfektion, se även ESS 47

RETTS faktaruta

≥ 2 frakturer på långa rörben hanteras i ESS 38

Nedsatt distalstatus är om pulsar och eller känsel är påverkade bortom skadan.

Kompartmentsyndrom uppstår när en muskel i armen svullnar så mycket att trycket påverkar muskel, blodflöde och nerver. Det kan även uppstå om ett gips är för trångt och trycket på vävnaden därigenom blir för högt. Måste behandlas skyndsamt för att undvika bestående skador.

Alla frakturer utan felställning/öppen fraktur faller in under misstänkt fraktur och blir således gröna.

- Skada fot/tå S99.9
- Skada höft/lårben/bäcken S79.9
- Skada knä/underben S89.9

Förberedande åtgärder

- Uteslut traumalarmskriterier ESS 38

Röda symtom

- ≥ 2 frakturer på långa rörben (se ESS 38)
- Amputation ovan fot (ESS 38)
- Penetrerande våld mot nedre extremiteter ovan knä (se ESS 38)
- Stor yttre blödning (se ESS 38)
- Svår smärta i bäckenet/misstänkt bäckenfraktur (se ESS 38)
- Fraktur/luxation samt pulslös perifert om skada
- Fraktur ovan knä - öppen

Orange symtom

- Amputation - nedom fotled samt stortå, exkl övriga tår
- Distalstatus - sensoriskt/motoriskt total bortfall
- Fraktur - öppen/felställd - knä/nedom knä till ovan tår
- Fraktur ovan knä, exkl bäcken - slutet/ej felställd - misstanke om
- Luxation ovan tår
- Koagulationshämmande läkemedel eller blödningsbenägenhet samt pågående blödning
- Smärta och tecken på kompartmentsyndrom

Gula symtom

- Amputation/delvis amputerad tå, exkl stortå
- Blödning - kontrollerbar
- Distalstatus - sensoriskt/motoriskt lätt nedsatt
- Fraktur i tår - öppen
- Fraktur knä/nedom knä, exkl tår - slutet/ej felställd - misstanke om
- Misshandel
- Sårskada - djup/sutureringskrävande

Gröna symtom

- Fraktur/luxation övrigt - misstänkta/konstaterade
- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

- | | |
|---|---|
| ➡ Överväg traumalarm | ➡ Överväg tourniquet vid amputationsskada |
| ➡ Provpaket: Stort trauma /chock/hjärtstopp | ➡ Liten traumarutin |
| ➡ Blodgas | ➡ Kapillärt Hb |
| ➡ Blodgruppering | ➡ Blodgruppering |
| ➡ Bastest | ➡ Bastest |
| ➡ PVK | ➡ PVK |

Högläge vid misstänkt fotledsfraktur

- Smärta i extremitet utan trauma, se istället ESS 15
- Sekundärinfektion i/nära led, se även ESS 13
- Traumalarmskriterier, se ESS 38
- Övrig sekundärinfektion, se även ESS 47

RETTS faktaruta

≥ 2 frakturer på långa rörben hanteras i ESS 38.

Långa rörben;

Humerus (överarm)

Femur (lårben)

Samtidig fraktur på både tibia och fibula (underbensbenen)

Tillse att patienten blir rengjord i och omkring sårområdet direkt efter första bedömning efter primärkontakt.

Kompartmentsyndrom uppstår när en muskel i benet svullnar så mycket att trycket påverkar muskler, blodflöde och nerver. Det kan även uppstå om ett gips är för trång och trycket på vävnaden därigenom blir för högt. Måste behandlas skyndsamt för att undvika bestående skador.

Tillståndet ger symtom som svår smärta, nedsatt muskelkraft, nedsatt känsel, nedsatt färg och temperatur samt smärta vid passiv rörelse. Observera att normala pulsationer inte utesluter kompartmentsyndrom!

Nedsatt distalstatus föreligger om pulsar och eller känsel är påverkade nedanför (bortom) skadan.

Instabilt bäcken;

Misstänke; Instabilt bäcken kan misstänkas hos yngre patienter vid högenergitrauma, för äldre patienter räcker ibland ett fall från samma plan dvs lågenergitrauma. De sistnämnda ger dock sällan upphov till instabila bäckenringskador.

Symtom och tecken; Lokal smärta och deformitet, förkortad utåtroterad extremitet. Öppen blödning eller blod från urinrör, vagina eller rektum. Nedsatt cirkulation, känselstörning och/eller motorisk nedsättning.

Undersökning; Man bör inte stabilitetspröva bäckenet, eftersom det kliniska värdet av denna undersökning är tveksamt; undersökningen i sig kan också medföra okontrollerad blödning.

- Blixtnedslag T75.0
- Brännskada T30.0
- Elolycka T75.4
- Frätskada T30.4
- Hypertermi/Värmeslag T67.0
- Hypotermi T68
- Inhalationsskada T59
- Kemisk skada T65
- Köldskada T35.7
- Strålskada T66.9
- Toxisk effekt av kolmonoxid T58.9

Förberedande åtgärder

- Uteslut traumalarmskriterier ESS 38

Röda symtom

- Akut strålskada
- Brännskada/frätskada $\geq 18\%$ (se ESS 38)
- Brännskada/frätskada ansikte/hals med hot om ofri luftväg
- Circumferent fullhudsbrännskada
- Elolycka högsppänning
- Hypertermi i samband med yttre påverkan till överhettning/gravt värmeslag med temp över 40,5 °C
- Hypotermi i samband med nedkylning med temp under 32 °C
- Inhalation av brandrök med sot runt mun/i svalg (se ESS 38)
- Kem/frätskador av potentiellt livshotande ämne på hud eller per os (se ESS 38)
- Svullnad i ansikte/tunga

Orange symtom

- Brännskada/frätskada/köldskada 5% - 18%
- Hosta efter rökinalation
- Hypertermi i samband med yttre påverkan till överhettning /värmeutmattning med temp upp till 40,5 °C
- Lindrig hypotermi i samband med nedkylning med temp 32-34,9 °C
- Lokal köldskada i svalg med - kraftig sväljsmärta/svårt att svälja saliv - efter inhalation av gaser/kemikalier
- Medvetandeförlust i anamnesen
- Övriga circumferenta brännskador

Gula symtom

- Begränsad brännskada/frätskada/köldskada <5%
- Blixtnedslag i patientens omedelbara närhet
- Lokal köldskada

Gröna symtom

- Övrig elolycka
- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

- Traumalarmskriterier, se ESS 38

RETTS faktaruta

Högsppänning:

Med högsppänning menas här allt >1000 V t.ex. kontaktledning för tåg, högsppänningsledningar eller blixtnedslag.

Patienter som utsatts för vanlig hushållsel (230V) kan behöva uppföljning kring senkomplikation (nervskador etc). Att patienten suttit fast i strömkällan ökar risken för muskelskador - var lyhörd kring kvarvarande smärtor i delar som exponerats.

Symtomgivande strömgenomgång i hjärtat ger besvär omedelbart, antingen genom att det elektriska systemets slås ut (div arytmier/asystoli), eller genom brännskada i hjärtmuskeln.

Detta sker inte med latens eller utan signifikanta symtom.

Oavsett volt och nuvarande symtom kan patienten behöva uppföljning kring senkomplikation (micronervskador etc), generellt planerat via primärvården.

Hypertermi:

Ett medicinsk tillstånd där kärnkroppstemperaturen stegras och blir onormalt hög och kan ge upphov till:

Värmevram, värmevynkopé och värmevslag.

Som sökorsak skall Hypertermi användas vid hög kärnkroppstemp som orsakats av att patienten till exempel har utsatts för yttre påverkan av extrem värme (bastu, bil, annan varm miljö) eller dehydrering samt andra medicinska orsaker på grund av sviktande temperaturreglering. Använd EJ denna sökorsak vid feber!

Vid feber med misstanke om infektion eller inflammation - se istället ESS 47

Värmevslag indelas i:

- Värmeutmattning p g a förlust av vatten och elektrolyter orsakad av värme men utan kraftig stegring av kroppskärntemperaturen (eng. "heat exhaustion") upp till 40,5 °C.
- Gravt värmevslag: Akut livshotande tillstånd med centralnervös påverkan och skador på multipla organsystem till följd av en kroppstemperatur över 40,5 °C (eng. "heat stroke")

Hypotermi:

Innebär att kroppens kärntemperatur är < 35°C. Nedkylning, eller hypotermi, kan delas in i olika stadier;

- Lindrig hypotermi – Uppskattad kärntemperatur 35°C- 32°C.

Alert eller begynnande slöhet. Huttar. Takykardi. Svårigheter att ta hand om sig själv.

- Måttlig hypotermi – Uppskattad kärntemperatur 32°C - 28°C. Sänkt medvetandenivå, eventuellt hallucinationer. Bradykardi.

Huttande avtar.

- Grav hypotermi – Uppskattad kärntemperatur <28°C .

Medvetslös. Huttar inte. Långsam och svag puls som kan vara svår eller omöjlig att känna. Arytmier och evt. hjärtstopp.

Brännskador och Inhalationsskador:

Vid brännskador och rökinalation är det viktigt att kontrollera COHb i blodet. O2-saturation hos dessa patienter kan visa ett normalt värde trots att patienten har syrebrist. Symtom i samband med rökinalation som anses allvarliga kan vara CNS

Lokala processåtgärder

- | | |
|---|--|
| ➔ Överväg traumalarm | ➔ Liten traumarutin + Myoglobin |
| ➔ Provpaket: Stort trauma /chock/hjärtstopp | ➔ Blodgas |
| ➔ Blodgas | ➔ Blodgruppering |
| ➔ Blodgruppering | ➔ Bastest |
| ➔ Bastest | ➔ PVK |
| ➔ PVK | ➔ Syrgas 15L reservoarmask |
| ➔ EKG-uppkoppling | ➔ Vid rökskada och anamnes på CNS-symtom tas Blodgas |
| ➔ Syrgas 15L reservoarmask | ➔ Vid rökskada och anamnes på CNS-symtom tas Blodgas |
| ➔ Överväg traumalarm | |

Urinsticka vid elolycka

symtom (tidigare medvetandeförlust) eller svår hosta, dyspné. COHb i blodet bör kontrolleras om det varit en brand inomhus där patienten har vistas.

Brännskada:

Brännskador från öppen eld ger djupare skador och behöver en snabbare handläggning.

Brännskadade patienter är oftast dehydrerade vilket kan ge cirkulationspåverkan.

Det som skall räknas in i utbredningen är ytliga och djupa dermala + fullhudsskador (tidigare grad 2 & 3).

Endast rodnad (ytlig brännskada) räknas inte till utbredningen. Circumferent fullhudsbrännskada innebär omkretsen på ben, arm, torso eller dyl.

För en mer exakt uträkning rekommenderas att använda patientens handflata eller detaljerade tabeller.

Handflatan+ fingrar motsvarar ca 1 % av kroppsytan hos både barn och vuxna.

Inhalationsskada vid användning av lustgaser mm.

Luftflödet vid Inhalation av lustgas direkt från gräddsifon kan vara väldigt kallt och orsaka lokala köldskador i munhåla och svalg. Köldskadorna kan ge upphov till svullnad runt larynx och potentiellt hota luftvägen. Symtom som kraftig smärta vid sväljning efter inhalation av lustgas bör därför alltid omhändertas brådskande för undersökning av larynx även om patienten inkommer flera timmar efter inhalationen.

Kemolycka:

Vid kemolyckor beakta risken för kontamination av personal och utrustning. Beslut om sanering sker prehospitalt.

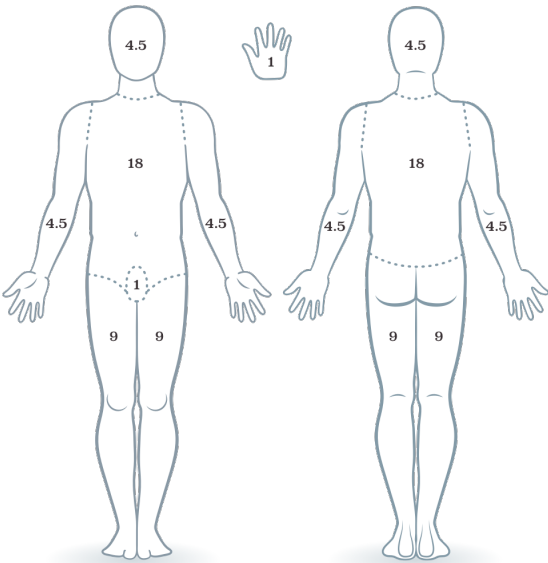
Strålskada:

Tag kontakt med lokal eller regional expertis.

Misshandel:

Vid misstanke om misshandel ges ytterligare vägledning i ESS 142.

Giftinformationscentralen 010-456 67 19 och i brådskande fall 112 och begär Giftinformationscentralen, www.giftinfo.se



Vuxen

- Drunkning/drunkningstillbud T75.1
- Dykarsjuka/ dekompressionssjukdom, misstanke om T70.3

Förberedande åtgärder

- Uteslut traumalarmskriterier ESS 38

Röda symtom

- Kramp efter drunkningstillbud
- Temp. < 32 °C
- Patient har i samband med eller efter tillbudet varit medvetslös eller utan egen andning/cirkulation

Orange symtom

- Intoxikerad patient
- Neurologiska bortfallssymtom
- Snabb uppstigning från dykning med komprimerad gas
- Temp 32 - 34,9°C
- Yrsel/ledvärk

Gula symtom

- Andningsrelaterad smärta/andfåddhet efter dyk med komprimerad gas
- Hudmarmorering/lymfödem
- Misstänkt signifikant aspiration utan påverkade VP

Gröna symtom

- Klåda
- Inget av ovanstående

Blåa symtom

Lokala processåtgärder

- | | |
|--|--|
| ➔ Rutinpaket: Stort trauma /chock/hjärtstopp | ➔ Blodgas |
| ➔ Blodgas | ➔ Vid intox överväg urindrogsscreening |
| ➔ Vid intox överväg urindrogsscreening | ➔ EKG-övervakning |
| ➔ EKG-övervakning | ➔ Om hypotermi, kontinuerlig temperaturövervakning (tempkateter, esofagus /rektaltemp) |
| ➔ Kontinuerlig temperaturövervakning (tempkateter, esofagus /rektaltemp) | ➔ Blodgas |
| ➔ Liten traumarutin | ➔ EKG |

Vid drunkningstillbud/olycka är det viktigt att VP fastställs tidigt och upprepat. Kroppstemp? Utomhustemperatur? Venös blodgas viktigt på prioritet GUL och över.

Vid dykeriolycka viktigt att även samla information om antal dyk senaste veckan, gastyp som använts, dykdjup, dyktid och symptomförlopp. Vid dykeriolycka och röd eller orange triagering bör kontakt tas med tryckkammarjour, Östra sjukhuset Göteborg eller Karlskrona sjukhus, för råd och ställningstagande till tryckkammarbehandling. Behandling med 100% syrgas bör alltid påbörjas vid dykeriolycksfall med röd-gul triagering.

- Intoxikation, se även ESS 40
- Suicidförsök - misstanke om, se även ESS 99
- Traumalarmskriterier, se ESS 38

RETTS faktaruta

Drunkning är en diagnos men ofta handlar det om ett tillbud av olika karaktär där det varit en olycka av något slag, båt, simbassäng, badplats fall i vatten etc. Cirka 120 personer drunknar varje år i Sverige.

Hypotermi är vanligt i samband med drunkning och ytterligare nedkylning ska motverkas. Hypotermi innebär att kroppens kärntemperatur är < 35°C. Nedkylning, eller hypotermi, kan delas in i olika stadier;

- Lindrig hypotermi – Uppskattad kärntemperatur 35°C- 32°C.

Alert eller begynnande slöhet. Huttrar. Takykardi. Svårigheter att ta hand om sig själv.

- Måttlig hypotermi – Uppskattad kärntemperatur 32°C - 28°C. Sänkt medvetandenivå, eventuellt hallucinationer. Bradykardi. Huttrande avtar.

- Grav hypotermi – Uppskattad kärntemperatur <28°C . Medvetslös. Huttrar inte. Långsam och svag puls som kan vara svår eller omöjlig att känna. Arytmier och evt. hjärtstopp.

Uteslut andra tillstånd/sjukdomar som behöver behandlas t.ex. trauma, alkohol/droger, hypoglykemi, hjärtinfarkt, stroke eller epilepsi.

Vid olycksfall under dykning med komprimerad gas kan dykarsjuka eller lungbristning uppstå. Samla info kring förlopp, djup och tider. Dykarsjuka kan ge ett/flera av: neurologiska symptom, ledsmärta, hudmarmoreringar, lymfödem eller klåda. Lungbristning kan ge neurologiska symptom, pneumothorax, subkutant emfysem, hosta och bröstsmärta.

Vid misstanke om dykarsjuka eller lungbristning bör behandling med 100% syrgas påbörjas. Neurologiska symptom och ledsymtom ska tryckkammarbehandlas och kontakt ska tas med tryckkammarjour på Östra sjukhuset i Göteborg eller Karlskrona sjukhus för fortsatt handläggning. Enheterna kan nås via SOS-alarm.

- Skada öga S05
- Ögonskada S05

Förberedande åtgärder

- Uteslut traumalarmskriterier ESS 38

Röda symtom

- Penetrerande skada
- Utbuktande öga efter skada

Orange symtom

- Frätskada eller misstänkt frätskada
- Inskränkt ögonrörlighet/dubbelseende
- Skada med synnedsättning

Gula symtom

- Synlig blödning i främre kammaren efter skada

Gröna symtom

- Främmande kropp i öga
- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

Polop



Bastest



Blodgruppering



PVK

Vid misstanke om frätskada på öga, eller där patienten uppger exponering för frätande ämne eller annan potentiellt toxisk /skadande substans: Spola ögonen omedelbart rikligt med ögonskölj alternativt NaCl. Förslagsvis koppla ett droppaggregat till en påse med 1000ml NaCl, öppna rullklämman och spola ögat kontinuerligt.

- Djupa penetrerande skador, se även ESS 38
- Icketraumatiska ögonproblem, se istället ESS 57
- Postoperativa besvär, se ESS 72
- Traumalarmskriterier, se ESS 38

RETTS faktaruta

ESS vägledning;

Penetrerande skada, här avses ej ytlig hornhinneskada (svetsblänk eller rispor)

Misstanke om eller känd frätskada i öga skall sköljas.

Följ lokala PM/rutiner

- Trauma Z91.6

Röda symtom

- N1.....Behov av ventilationsstöd
- N1.....AF <10 eller >29 /minut
- N1.....BT < 90mmHg eller ej palpabel radialispuls
- N1.....RLS ≥ 3 eller GCS ≤ 13
- N1.....Penetrerande våld mot hals, huvud, bål, extremiteter ovan armbåge/knä
- N1.....Öppen skallskada/impressionsfraktur
- N1.....Ansikts/halsskada med hotad luftväg
- N1.....Instabil/deformerad bröstorg
- N1.....Svår smärta i bäckenet/misstänkt bäckenfraktur
- N1.....Misstänkt ryggmärgsskada
- N1..... ≥ 2 frakturer på långa rörben
- N1.....Amputation ovan hand/fot
- N1.....Stor yttre blödning
- N1.....Brännskada $\geq 18\%$ eller inhalationsskada
- N2.....Bilolycka > 50km/h utan bälte
- N2.....Utkastad ur fordon
- N2.....Fastklämd med losstagningstid >20 min
- N2.....MC-olycka (eller motsvarande) > 35 km/h
- N2.....Fall > 5 meter
- N2.....Ospecificerat trauma - bedömd som Nivå 2 i SAMRÅD MED LÄKARE eller LAS

Orange symtom

Gula symtom

Gröna symtom

Blåa symtom

Lokala processåtgärder

- | | |
|---|---|
| ➡ Aktivera traumalarm | ➡ Bastest |
| ➡ Provpaket: Stort trauma /chock/hjärtstopp | ➡ Överväg ROTEM (tas i ljusblått rör och skicka till blodcentralen, ring dem innan) |
| ➡ Blodgas | ➡ PVK x2 |
| ➡ Blodgruppering | ➡ EKG-övervakning |

- Trauma barn se ESS 138

RETTS faktaruta

Algoritm baseras på Nationella traumalarmskriterier.

Ett eller flera kriterier i RÖD ruta ger NIVÅ 1 larm eller NIVÅ 2 larm.

Oavsett vilket/vilka kriterier som ger utfall gäller prehospitalt förvarning till AKM samt lokala riktlinjer för val av transportprioritet till sjukhus.

De patienter som saknar uppenbara eller misstänkta kriterier för RÖD prioritet måste hanteras i en annan ESS, ofta i spannet ESS 30-37.

Instabilt bäcken:

Kan misstänkas hos yngre patienter vid högenergitrauma, för äldre patienter räcker ibland ett fall från samma plan dvs lågenergitrauma. De sistnämnda ger dock sällan upphov till instabila bäckenringskador.

Symtom och tecken; Lokal smärta och deformitet, förkortad utåtroterad extremitet. Öppen blödning eller blod från urinrör, vagina eller rektum. Nedsatt cirkulation, känselstörning och/eller motorisk nedsättning.

Undersökning;

Man bör inte stabilitetspröva bäckenet, eftersom det kliniska värdet av denna undersökning är tveksamt; undersökningen i sig kan också medföra okontrollerad blödning.

Kortisolsvikt:

Patienter med kortisolsvikt / binjurebarksvikt, är särskilt känsliga vid sjukdomstillstånd som feber, gastroenterit, hypovolemi etc. Deras normala försvar i form av aktivering av binjurebark är utslagen eller nedsatt.

Patienter med kortisolsvikt / binjurebarksvikt står ofta på substitution som i samband med sjukdom ofta justeras upp enligt ett schema som patienten sköter själv. Detta kan ibland vara otillräckligt vilket gör att patienten behöver handläggas med hög prioritet eftersom tillståndet snabbt kan utvecklas till ett livshotande tillstånd med cirkulatorisk chock.

- Förgiftning/intoxikation T50.9

Röda symtom**Orange symtom**

- Buksmärt
- Intag av (känd/misstänkt) giftsvamp
- Intag av substans i suicidsyfte
- Misstanke om allvarlig intoxikation

Gula symtom

- Intag av okänd substans

Gröna symtom

- Intag av uppenbart ofarlig substans/mängd
- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

- | | |
|--|--|
| ➔ Intox-rutin | ➔ EKG-uppkoppling |
| ➔ Blodgas | ➔ Överväg U-drogscreening om drogintox |
| ➔ PVK | ➔ Intox-rutin |
| ➔ EKG-uppkoppling | ➔ Blodgas |
| ➔ Överväg U-drogscreening om drogintox | ➔ PVK |
| ➔ Intox-rutin | ➔ EKG-uppkoppling |
| ➔ Blodgas | ➔ Överväg U-drogscreening om drogintox |
| ➔ PVK | |

- Suicidförsök - misstanke om, se även ESS 99
- Överväg farlighetsbedömning, se även ESS 98

RETTS faktaruta

Vid känt suicidförsök, eller misstanke om suicidförsök måste särskild övervakning övervägas. Överväg alltid behov av kuratorskontakt och/eller uppföljning i öppenvård. Överväg eventuell LVM-anmälan vid missbruk.

Vid svampförgiftning be patienten ange sannolik svamptyp och be eventuella anhöriga att ta hand om eventuella rester för att visa svampkunnig inom sjukvården. Konsultera gärna den svampbok patienten själv använt vid plockning. Ange noggrant tidpunkt för intag av svamp/måltid.

Ange alltid tidpunkt för intag av toxisk substans/er.

Giftinformationscentralen 010-456 67 19 och i brådskande fall 112 och begär Giftinformationscentralen, www.giftinfo.se

- Bett och stick av djur T14.1A
- Toxiska effekter av djur T63.9
- Bett av människa T14.0
- Stickkada med smittorisk T14.0X

Röda symtom

- Anafylaktisk reaktion
- Initialt / lägst SBT <90 mmHg
- Svullnad i andningsvägar/mun med påverkad andning, tal eller sväljföråga
- Symtom och kliniska tecken som uppfyller nationella kriterier för sepsisalarm

Orange symtom

- Bett av djur med potentiellt gift
- Feber >38,5°C och frossa senaste 12 timmarna
- Tidigare anamnes på allvarlig allergisk reaktion av bitt eller sting av samma djur/insekt

Gula symtom

- Djup sårskada

Gröna symtom

- Kraftig lokal reaktion av bitt
- Stickador med smittorisk
- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

- | | |
|--|---|
| ➔ Provpaket: Stort trauma /hjärtstopp/chock | ➔ Bukrutin |
| ➔ Blodgas | ➔ Blodgas |
| ➔ PVK | ➔ PVK |
| ➔ Plasmalyte | ➔ Plasmalyte |
| ➔ Vid misstanke om anafylaxi: Ge syrgas och förbered Adrenalin, Tavegyl och Betapred för att ge på ordination. | ➔ Vid misstanke om anafylaxi: Ge syrgas och förbered Adrenalin, Tavegyl och Betapred för att ge på ordination |
| ➔ Vid feber >38,5°C: Rundodling | ➔ Vid feber >38,5°C: Rundodling |

Kapillärt CRP

- Misstanke om allvarlig infektion, se även ESS 47

RETTS faktaruta

Giftinformationscentralen: 010-456 67 19 och i brådska fall 112 och begär Giftinformationscentralen, www.giftinfo.se.

Små sår och skärskador bör sutureras inom 6 h. Om bitt av smådjur, stick etc fråga om handläggning och behandling, vaccination etc.

Här kan flera olika djurstick bitt klassificeras (geting, mygga, knott, fjärsing etc) var noga med rengöring och ev profylax v.b.

Ormbett kan orsaka progredierande lokal svullnad men även allmänna symtom med kräkningar, buksmärtor, blodtrycksfall och andningssvårigheter samt i vissa fall lokala nekroser, DIC-bild och kompartmentsyndrom.

Symtom som kan indikera allvarlig infektion och kan leda till sepsis:

- Feber/skakfrossa/hypotermi
- Konfusion/vakenhetssänkning/motorisk oro
- Uttalad allmänpåverkan/allmän svaghet
- Andnöd/andfåddhet/takypné/dyspné
- Kräkning/diarré
- Smärta (ex buk)

Feber är vanligt men det är även vanligt att patienterna inte har feber eller är hypoterma. Framförallt i sköra patientgrupper. Desto kraftigare frossa desto större risk att det rör sig om feber

Alla patienter med sepsis har inte feber och tänk på att patienten kan ha tagit febernedsättande, som påverkar mätningen

OBS! Lägre temperatur vid ankomst är korrelerad till högre sjukhusdödlighet.

- Fysisk misshandel T74.1
- Sexuellt våld Z04.4

Röda symtom**Orange symtom**

- Koagulationshämmande läkemedel eller blödningsbenägenhet samt pågående blödning/misstanke om icke synlig pågående blödning

Gula symtom

- Sexuellt våld
- Övriga

Gröna symtom**Blåa symtom****Lokala processåtgärder**

- | | |
|---|---------------------|
| ➔ Överväg traumalarm | ➔ Liten traumarutin |
| ➔ Provpaket: Stort trauma /hjärtstopp/chock | ➔ Blodgas |
| ➔ Blodgas | ➔ Blodgruppering |
| ➔ Blodgruppering | ➔ Bastest |
| ➔ Bastest | ➔ PVK |
| ➔ PVK | |

Vid misshandel, förbered för fotodokumentation

Vid sexuell våld, förbered för spårsäkring

- Vaginal/rektal blödning, se även ESS 31

RETTS faktaruta**Guide till alternativa ESSer**

I övrigt hanteras misshandel i den ESS som gäller för den klassificerande skadans lokalisering.

Misshandel och/eller sexuellt våld skall alltid tas på största allvar. Inte sällan föreligger också andra problem hos både patient och den som utfört misshandeln. Alkohol och droger är inte ovanligt. Det är därför extra viktigt att hantera patienten med viss skärpa eftersom det kan föreligga saker som påverkar risk och förlopp, som inte kommer fram vid första anamnesförsöket.

Erbjud alltid kuratorskontakt. Följ lokala PM för skadedokumentation, anmälan och rättsintyg.

- Allergi T78.4
- Exantem/hudutslag/blåmärke R21.9
- Klåda F45.8
- Läkemedelsreaktion T88.7X

Röda symtom

- Anafylaktisk reaktion
- Svullnad i andningsvägar/mun med påverkad andning, tal eller sväljförmåga

Orange symtom

- Tidigare anafylaktisk reaktion och nu exponerad för samma allergen

Gula symtom

- Övriga med svullnad i ansikte eller klåda hals

Gröna symtom

- Lokal urtikaria/exantem
- Övriga

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

- | | |
|--|---|
| ➡ Provpaket: Stort trauma /hjärtstopp/chock | ➡ Blodgas |
| ➡ Blodgas | ➡ PVK |
| ➡ PVK x2 | ➡ Plasmalyte |
| ➡ Plasmalyte | ➡ Om saturation <95% ge syrgas |
| ➡ Syrgas | ➡ Förbered Adrenalin, Tavegyl och Betapred för att ge på ordination |
| ➡ Förbered Adrenalin, Tavegyl och Betapred för att ge på ordination. | |

- Bett/stick utan allergisk reaktion, se ESS 41
- Misstanke om allvarlig infektion, se även ESS 47

RETTS faktaruta

Guide till alternativ ESS:

Vid allmänpåverkan, med andnings och cirkulationspåverkan, överväg infektion som orsak och se ESS 47

Infektion:

Symtom som kan indikera allvarlig infektion och kan leda till sepsis:

- Feber/skakfrossa/hypotermi
- Konfusion/vakenhetssänkning/motorisk oro
- Uttalad allmänpåverkan/allmän svaghet
- Andnöd/andfåddhet/takypné/dyspné
- Kräkning/diarré
- Smärta (ex buk)

Feber är vanligt men det är även vanligt att patienterna inte har feber eller är hypoterma. Framförallt i sköra patientgrupper. Desto kraftigare frossa desto större risk att det rör sig om feber

Alla patienter med sepsis har inte feber och tänk på att patienten kan ha tagit febernedsättande, som påverkar mätningen

OBS! Lägre temperatur vid ankomst är korrelerad till högre sjukhusdödlighet.

Allergisk reaktion:

Allergi är ett dynamiskt förlopp och kan initialt vara lindrigt men utvecklas till ett allvarligt tillstånd. Därför är tillsyn och reevaluering extra noga på patienter med allergisk reaktion.

Anafylaktiska reaktioner oavsett orsak brukar indelas i olika faser.

- Initialfasen: inom ett par minuter till en timma efter kontakt med utlösande agens. Symtomen är ofta klåda i handflator, rodnad och kutana symtom samt klåda i halsen.
- Progressfasen: Mer generella symtom med urtikaria, angioödem, tachykardi, buksmärter (även andra gastrointestinala symptom kan förekomma).
- Chockfasen: Medvetandepåverkan, hypotension och cirkulationssvikt.

Petekier:

Petekiala utslag är ingen speciell sjukdom. Det är benämning på utslag som beror på små punktformiga blödningar i huden eller i slemhinnorna (i munnen till exempel). Allt efter utslagets ålder kan de vara mer eller mindre röda, blå, lila eller brunaktiga.

Giftinformationscentralen: 010-456 6719 och i brådskande fall 112 och begär Giftinformationscentralen, www.giftinfo.se

- Blåsor i munnen J06.9
- Halsont, förkylning J06.9
- Hosta R05.9

Röda symtom

Orange symtom

- Feber >38,5°C och frossa senaste 12 timmarna
- Immunosupprimerad patient
- Uttalade sväljsvårigheter, dreglar /kraftig smärta vid sväljning

Gula symtom

- Halsont och gröttigt tal
- Gapsvårigheter (trismus)

Gröna symtom

- Bihålebesvär
- Muntorsk
- Svullen halsmandel med synlig svalgtappsförskjutning /återkommande halsböld
- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter bedömning inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

➔ Provpaket: Stort trauma /chock/hjärtstopp	➔ Rutinpaket
➔ Blodgas	➔ Blodgas
➔ PVK	➔ PVK
➔ Plasmalyte	➔ Plasmalyte
➔ Rundodling	➔ Rundodling

- Dyspné, se även ESS 4
- Misstanke om allvarlig infektion, se ESS 47

RETTS faktaruta

Övre luftvägsbesvär orsakas oftast av virus och kräver i regel endast symtomlindrande behandling.
Bedöm andningsarbete enligt ESS 4

Faryngit/laryngit:

Halskatarr (Faryngit) - är en diffus inflammation i slemhinnorna i bakre munnen, gomseglet, mandlarna och väggarna i svalget. Vanligaste orsaken till heshet och halsont hos vuxna. Blir patienten hes eller förlorar rösten innebär det att inflammationen gått ner i svalget (laryngit).

- Oftast virusorsakad, men kan i vissa fall vara bakteriell.

- Svår laryngit kan ge andningspåverkan och stridor.

Viktigt att utesluta epiglottit vid uttalade sväljsvårigheter och feber.

Epiglottit (sällsynt men allvarligt)

Kan drabba vuxna, ofta med ett snabbt förlopp.

Symtom hos vuxna:

- Uttalad halssmärta, ofta utan synliga fynd i svalget

- Gröttigt tal och sväljningssvårigheter

- Hög feber och allmänpåverkan

- Ibland andningspåverkan och stridor (vanligare hos barn)

Viktigt:

- Låt patienten sitta upp, peta ej i svalget.

- Vid uttalade sväljsvårigheter utan synliga fynd i munhålan bör larynx alltid bedömas av ÖNH-läkare.

Övriga icke infektiösa orsaker till Larynxsvullnad är exempelvis Trauma, kemiska ämnen, inandning av rök/hetta, droger Covidinfektion kan ge hos viss allvarlig pneumonit/alveolit med påverkan på syragasmättnad och AF och ibland kräva intensivvård etc.

Körtelfeber (Mononukleos):

Orsakas vanligen av Epstein-Barr-virus och drabbar ofta unga vuxna.

Vanliga symtom:

- Hög, svängande feber

- Uttalad trötthet och nattliga svettningar

- Kraftigt svullna tonsiller med gråvita beläggningar

- Halsont, illaluktande andedräkt, gröttigt tal

- Förstorade lymfkörtlar, särskilt på halsen

Peritonsillit:

Vanliga symtom/tecken:

- ensidig smärta/rodnad, svullnad och förhårdnad kring tonsill (kan förekomma dubbelsidig men är ovanligt)

- asymmetri i mun och svalg där mjuka gommen på ena sidan buktar ut och ofta förskjuter gomseglet (uvula) över medellinjen åt motsatt sida.

- gapsvårigheter (trismus)

Trismus är oförmåga eller svårighet att öppna munnen helt.

Orsakas av muskelspasm eller stelhet i tuggmuskulaturen, t.ex.

vid:

- Infektioner (t.ex. halsböld, tandinfektioner)
- Trauma mot käke eller svalg
- Symtom/tecken:
- Ensidig rodnad, svullnad och förhårdnad kring tonsill
- Asymmetri i svalget eller underkäke/haka

Muntorsk (Oral candidos):

Svampinfektion i munhålan, ofta vid nedsatt immunförsvar eller efter antibiotikabehandling.

Vanliga symtom:

- Vita beläggningar på tunga, gom och insida av kinder
- Sveda, obehag vid sväljning

- Öronproblem H93.9
- Öronvärk H93.9

Röda symtom**Orange symtom**

- Feber >38,5°C och frossa senaste 12 timmarna
- Samtidigt Meningism/Nackstelhet

Gula symtom

- Varig flytning ur hörselgången
- Rodnad och svullen processus mastoideus
- Öronvärk och samtidig perifer facialispares
- Öronvärk och samtidig kraftigt funktionsinskränkande yrsel

Gröna symtom

- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

- | | |
|---|---|
| ➔ Provpaket: Stort trauma /chock/hjärtstopp | ➔ Blodgas |
| ➔ Blodgas | ➔ Rundodling |
| ➔ Rundodling | ➔ PVK |
| ➔ PVK | ➔ Plasmalyte |
| ➔ Plasmalyte | ➔ Vid synnedsättning och allmänsymtom (tex muskelvärk, huvudvärk, tuggsmärta, onormal trötthet) som inger misstanke om temporaliserit: Rutinpaket och PVK |
| ➔ Rutinpaket | ➔ Vid synnedsättning och allmänsymtom (tex muskelvärk, huvudvärk, tuggsmärta, onormal trötthet) som inger misstanke om temporaliserit: Rutinpaket och PVK |

Kapillärt CRP

- Främmande kropp i öra, se ESS 46
- Misstanke om allvarlig infektion, se även ESS 47
- Postoperativa besvär, se ESS 72

RETTS faktaruta

Öronproblem som infektion, värk hanteras oftast av primärvård eller närsjukvård. I RETTS finns en särskild "främmande kroppsalgoritm" se ESS 46

- Främmande kropp T17
- Främmande kropp i esofagus eller i magtarmkanalen T18.1
- Främmande kropp i luftväg T17.9
- Främmande kropp i näsa T17.1
- Främmande kropp i öra T16.9

Röda symtom

- Främmande kropp i luftväg/svalg med påverkad andning/tal
- Misstanke om främmande kropp i luftrör

Orange symtom

- Misstanke om kroppssmuggling
- Nedsvält knappcells batteri eller magneter
- Svårigheter att svälja saliv

Gula symtom

- Främmande kropp som sitter kvar i näsan
- Nedsvält objekt med buksmärta
- Sväljningssvårigheter men sväljer saliv

Gröna symtom

- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

➡ Polop	➡ Polop
➡ Blodgas	➡ Blodgas
➡ Blodgruppering	➡ Blodgruppering
➡ Bastest	➡ Bastest
➡ PVK	➡ Plasmalyte
➡ Plasmalyte	

RETTS faktaruta

Knappcells batteri och/eller magneter finns i leksaker och sväljs ibland av i huvudsak barn. Batteriet skapar en svag ström mellan - och + polerna vilket kan skada slemhinna och vävnad när magneterna/polerna dras mot varandra.

Det är viktigt att patient som svält knappcells batteri (typ litiumjon) handläggs utan dröjsmål på akutmottagning och att tid till röntgen för diagnostisering och vidare handläggning är så kort som möjligt.

Prehospital sjukvård och transport:

Överväg snabb transport till sjukhus utifrån förutsättningar och omständigheter, då det är viktigt att batteriet eller magneterna snabbt avlägsnas med gastroscopi för att förhindra esofagus skada eller skador i andra delar av gastrointestinalkanalen.

(Medicinsk risknivå: LÄGST Orange prioritet enligt ESS)

ÖNH besvär hanteras även i ESS 44.

- Feber R50.9
- Infektion B99.9
- Lokal infektion i hud inkl. böld/lymfadenit L08.9
- Resistent svullnad/knöl på halsen R22.1
- Sepsis - misstanke om A41.9
- Tandvärk/tandinfektion B99.9

Förberedande åtgärder

- Venös blodgas (vB-laktat) - om möjligt

Röda symtom

- Förhöjt B-laktat (enl lokala riktlinjer)
- Initialt / lägst SBT <90 mmHg
- HF / puls högre än SBT
- Petekier
- Symtom och kliniska tecken som uppfyller nationella kriterier för sepsislarm (se faktaruta)

Orange symtom

- Akut konfusion/delirium – snabb förändring senaste dygnet
- Feber >38,5°C och frossa senaste 12 timmarna
- Immunosupprimerad patient
- Kraftig svullnad samt tydlig rodnad från kind, underkäke ned på halsen
- Lokal infektion med svår smärta
- Meningism/Nackstelhet
- Uppdriven och hård munbotten samt sväljsvårigheter

Gula symtom

- Lokal infektion (rodnad, värmeökning, smärta)

Gröna symtom

- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

- | | |
|---|---|
| ➔ Provpaket: Stort trauma /chock/hjärtstopp | ➔ Blodgas |
| ➔ Blodgas | ➔ PVK |
| ➔ Rundodling | ➔ Plasmalyte |
| ➔ PVK x2 | ➔ EKG-uppkoppling |
| ➔ Plasmalyte | ➔ Bladderscan |
| ➔ EKG-uppkoppling | ➔ U-hCG på fertil kvinna |
| ➔ Bladderscan | ➔ Rutinpaket |
| ➔ U-hCG på fertil kvinna | ➔ Vitalparametrar en gång i timmen fram till läkarbedömning |
| ➔ Rutinpaket | ➔ Vitalparametrar en gång i timmen fram till läkarbedömning |

Kapillärt CRP

- Kräkning/feber samt Addisons/indikation på binjurebarkssvikt /kortisolbrist se istället ESS 51
- Misstanke om infektion och ledengagemang, se även ESS 13

RETTS faktaruta

Sepsis är definitionsmässigt en multiorgan svikt till följd av immunsystemets reaktion på en infektion och generellt är orsaken bakteriella infektioner.

Sepsis har en av de högsta akuta mortaliteterna av alla sökorsaker på en akutmottagning, mellan 15-50%.

När patienten väl utvecklat multiorgansvikt är sällan triageringen svår att utföra - patienten är då ofta i chock med avsevärt påverkade vitala parametrar och faller ut röd.

Det är när patienten med en infektion befinner sig i "förstadiet", som det kan vara svårt att bedöma risken att tillståndet utvecklas till sepsis. Därför ökar risken att antibiotikabehandling blir sent administrerad.

Det finns i dagsläget inget felfritt verktyg för att identifiera en begynnande sepsis utan att antingen ge mycket undertriage (för låg prioritet för de med sepsis) eller mycket övertriage (för hög prioritet för de utan sepsis). Bedömning måste likväl göras och ofta är det subjektiva kriterier som flyttar misstanken antingen upp eller ned på en skala där inget solklart gränsvärde finns.

Generella råd är:

- De med sepsis insjuknar ofta relativt snabbt (timmar - dag), antingen från upplevd friskhet eller från ett tillstånd med lågintensiv infektion.

- Unga friska har oftast ett tydligare förlopp medan äldre sjukas insjuknande missas eller misstolkas som ospecifik trötthet /konfusion.

- Feber är ofta det man tänker på när infektion och sepsis diskuteras.

Observera att även patienter utan feber kan ha sepsis vilket även förekommer hos äldre, multisjuka patienter samt patienter med läkemedel som påverkar immunförsvaret (se nedan grupp för riskpatienter).

Sepsis utvecklas ofta från en tydlig infektion från ett organsystem, så som efter en urinvägsinfektion, men inte alltid.

Nationella kriterier för sepsislarm - se NPO infektion (SKR)

Det är viktigt att lära sig känna igen tecken som kan vara sepsis även på icke klassiska insjuknande.

Symtom som inger infektionsmisstanke:

- Feber/feberanamnes
- Hosta/sputa
- Dysuri/flanksmärta
- Hudrodnad, sårinfektion, petekier
- Buksmärta, kräkningar/diarré
- Akut ledsvullnad/rodnad
- Huvudvärk, ljuskänslighet
- Infektionstecken runt central infarkt
- Annan misstänkt infektion

Symtom som kan indikera allvarlig infektion och kan leda till

sepsis:

- Feber/skakfrossa/hypotermi
- Konfusion/vakenhetssänkning/motorisk oro
- Uttalad allmänpåverkan/allmän svaghet
- Andnöd/andfåddhet/takypné/dyspné
- Kräkning/diarré
- Smärta (ex buk)

Riskpatienter:

- Äldre
- Nyopererade, nyförlösta
- Immunosupprimerade
- Missbrukare
- Inopererat främmande material
- Infarter/katetrar
- Komorbiditet (närvaron av en eller flera sjukdomar eller diagnoser förutom en primär diagnos)

Det finns en risk att patienter med allvarigare infektion blir bedömda att ha "ospecifika symtom" (ESS 53), framför allt i den äldre populationen.

Ofta är bedömningen baserad på att patienten är trött eller förvirrad eller känner sig svag. Sepsis ska därför alltid övervägas hos dessa patienter!

Forskning visar att det är en grupp som konsekvent undertriageras.

Lokal smärta:

Infektionstecken i kombination med svår lokal smärta kan vara ett tecken på invasiv streptokockinfektion vilket är allvarligt.

Tandinfektion:

Kan spridas till omgivande mjukdelar vilket kan orsaka svullnad i munnen och potentiellt hota luftvägen. Tandinfektioner kan leda till svårigheter att gapa, och bör även ses som en potentiell källa till sepsis.

Petekier:

Är små punktformiga blödningar i hud eller slemhinnor (i munnen till exempel) som inte bleknar vid tryck och kan vara röda, lila eller brunaktiga beroende av ålder. I hud och slemhinnor kan de vara ett allvarligt tecken vid samtidig infektion eller akut påverkan av allmäntillstånd. Petekier är dock betydligt vanligare att se vid tillstånd som inte är infektiösa, så som trombocytpåverkan, vissa nefriter eller vaskuliter. Var alltid vaksam på vitalparametrar och sjukdomslängd vid petekier.

Ett akut insjuknande med påverkan på allmäntillstånd /vitalparametrar bör tolkas som sepsis innan motsatsen är bevisad.

Meningism:

Definieras som patient med huvudvärk, allmänpåverkad och med en reflektorisk nackstelhet vid passiv flexion i nacken (undersökaren böjer huvudet framåt). Klinisk relevant meningit är ovanligt. Tillstånd som har huvudvärk och nacksmärta utan att vara farliga är många.

Immunosupprimerad patient:

Patient med - känd immunbrist, eller behandlas med cytostatika

/kortison, eller står på annan immunosuppressiv behandling - och samtidigt påvisar infektionstecken, har ökad risk för att få en allvarlig infektion.

Inopererat material:

Så som vid shuntkatetrar, peritonealdialyskateter, mekanisk klaff etc. innebär alltid en ökad risk för allvarlig infektion där materialet är inopererat.

OBS låg temp!

Lägre temperatur vid ankomst till akutmottagning är korrelerad till högre sjukhusdödlighet.

Nedanstående algoritmer kan användas när patienten är "RETTS-ad" som ett extra stöd vid misstanke om att patienten har en Allvarlig infektion.

qSOFA 2/3 poäng för AF, systoliskt BT och vakenhet:

Observera att inte alla organisationer använder sig av qSOFA algoritmen. Följ lokala riktlinjer i din organisation.

- Diabetes, känd E14.9
- Högt blodsocker/hyperglykemi R73.9

Förberedande åtgärder

- Blodgas - om möjligt
- B-ketoner mmol/L - om möjligt
- P-glukos mmol/L

Röda symtom

- Kussmaulandning
- pH <7,3

Orange symtom

- B-ketoner >3 mmol/L
- Acetondoft
- P-glucos >15 mmol/L samt typ 1 diabetes
- P-glukos >25 mmol/L

Gula symtom

- Diarré
- Kräkningar
- P-glukos 15-25 mmol/L

Gröna symtom

- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

- | | |
|--|--|
| ➔ CVS-rutin | ➔ PVK |
| ➔ B-ketoner | ➔ EKG-uppkoppling |
| ➔ Blodgas | ➔ Vid hyperglykemi: NaCl-infusion 9mg/ml 1000ml /timme |
| ➔ PVK | ➔ CVS-rutin |
| ➔ EKG-uppkoppling | ➔ B-ketoner |
| ➔ Vid hyperglykemi: NaCl-infusion 9mg/ml 1000ml /timme | ➔ Blodgas |
| ➔ CVS-rutin | ➔ PVK |
| ➔ B-ketoner | ➔ EKG |
| ➔ Blodgas | ➔ Vid hyperglykemi: NaCl-infusion 9mg/ml 1000ml /timme |

Urinsticka

U-hCG på fertil kvinna

- Lågt blodsocker/hypoglykemin, se istället ESS 50

RETTS faktaruta

Patienter med hyperglykemi (hyperosmolärt tillstånd) eller diabetesketoacidosis kan uppvisa varierande symtom och tecken. Ibland misstänker man därför initialt andra bakomliggande diagnoser. Cerebrala, cirkulatoriska, respiratoriska och gastrointestinala symtom är vanliga.

Hos patienter med nydebuterad diabetes och/eller samtidig ketoacidosis förekommer ofta buksmärta som ibland medför att patienten primärt sorteras till disciplinen kirurgi.

Blodgas med pH och blodlaktat, info om diures, vätskeintag och vikt, är viktiga stöd i handläggningen.

Vid anamnes/kliniska tecken till överdosering av insulin /antidiabetika - ange alltid dos och tidpunkt.

Kussmaulandning:

Långsam, onormalt djup inandning följt av en kort och hastig utandning. Kan ses hos patienter med metabol acidosis, t.ex. diabeteskoma. Det är ett sätt för kroppen att bli av med protoner.

- Lågt blodsocker/hypoglykemi E16.2

Förberedande åtgärder

- P-glukos mmol/L

Röda symtom

- P-glukos <2,5 mmol/L

Orange symtom

- Oklara CNS symtom
- P-glukos <3,0 mmol/L
- Svårigheter att hålla P-glukos normalt trots tillförsel av extra energi/socker
- Överdoser av insulin eller peroral antidiabetika

Gula symtom**Gröna symtom**

- Inget av ovanstående

Blåa symtom**Lokala processåtgärder**

- | | |
|--|--|
| ➔ CVS-rutin | ➔ CVS-rutin |
| ➔ Blodgas | ➔ Blodgas |
| ➔ PVK | ➔ PVK |
| ➔ EKG-uppkoppling | ➔ EKG-uppkoppling |
| ➔ Förbered glukosbehandling med 30% glukos | ➔ Förbered glukosbehandling med 30% glukos |

Ge saft och näringsdryck/macka per os om pat kan äta och dricka

- Högt blodsocker/hyperglykemi, se istället ESS 49

RETTS faktaruta

Hypoglykemi är oftast kopplat till känd Diabetes Mellitus. Hos patienter med diabetes beror hypoglykemi ofta på överdosering av insulin i förhållande till matintag. Initialt ses symtom såsom:

- hunger
- tremor
- kallsvett
- blekhet
- kräkningar

Centralnervös påverkan medför:

- humörförändringar
- dubbelseende
- kramper
- medvetnedslöshet

Utebliven effekt av glukos:

Snabb diagnos och snabb åtgärd är viktigt. Om behandling med glukos EJ ger effekt, så skall differentialdiagnos övervägas.

Insulinpump?:

Kontrollera alltid om patienter med hypoglykemi har insulinpump som i så fall genast skall tas bort/stängas av.

- Addisons sjukdom E27.1
- Binjurebarkssvikt, känd E27.4
- Kortisolsvikt E23.0C

Förberedande åtgärder

- I anamnes: Pågående kortisonbehandling > 3 veckor med minst 5 mg Prednisolon dagligen (se faktaruta)

Röda symtom

- Ej tagit eller fått behålla ordinerad dos cortison
- Frossa och/eller feber i anamnesen
- Kräkning och/eller diarré

Orange symtom

- Infektionsanamnes men tagit cortison enligt ordination

Gula symtom**Gröna symtom****Blåa symtom****Lokala processåtgärder**

- | | |
|--|---|
| ➔ Addissonpaket | ➔ Rutinpaket |
| ➔ Blodgas | ➔ Blodgas |
| ➔ Rundodling vid misstanke om infektion | ➔ Blododling vid feber >38.5 |
| ➔ PVK (överbäg 2) | ➔ PVK |
| ➔ EKG-uppkoppling | ➔ EKG |
| ➔ NaCl-infusion 9mg/ml 1000ml, infusionstid 2 timmar | ➔ Förbered 100mg Solu-Cortef iv – ges på ordination |
| ➔ Förbered 100mg Solu-Cortef iv – ges på ordination | |

RETTS faktaruta

ESS 51 används vid misstanke om- eller vid känd kortisolbrist ex. primär binjurebarkssvikt (Addisons sjukdom) och sekundär binjurebarkssvikt – (Hypofyssvikt) eller pågående/varaktig kortisonbehandling.

Akut kortisolbrist, även känd som Addisonkris eller binjurekris, är ett livshotande tillstånd som inträffar när kroppen inte har tillräckligt med kortisol.

Patienter med kortisolbrist är särskilt känsliga vid sjukdomstillstånd som feber, gastroenterit, hypovolemi etc. Deras normala försvar i form av aktivering av binjurebark är utslagen eller nedsatt. Patienter med binjurebarkssvikt eller hypofyssjukdom står ofta på kortisonsubstitution som i samband med akut sjukdom ofta justeras upp enligt ett schema som patienten sköter själv. Detta kan ibland vara otillräckligt vilket gör att patienten behöver handläggas med hög prioritet eftersom tillståndet snabbt kan utvecklas till ett livshotande tillstånd med cirkulatorisk chock.

Patienter utan primär/sekundär binjurebarkssjukdom men som av andra orsaker har kortisonbehandling >3 veckor med minst 5 mg prednisolon dagligen, har ökad risk för att utveckla sekundär binjurebarkssvikt (kortisolbrist).

Beakta att kortisonbehandling är en form av immunosupprimerad behandling. I RETTS blir den här patienten lägst Orange.

Immunosupprimerad patient:

I samhället finns det allt fler patienter som av olika skäl har immunosupprimerad behandling. Viktigt är att man redan vid ankomst dokumenterar om det föreligger immunosuppression och vid behov vidtar de åtgärder som finns utarbetade på det sjukhus som patienten befinner sig på.

Står hen på cytostatika, cortison eller andra nyare immunosuppressions läkemedel - se även de ESS och symtom som patienten uppvisar.

- Fallbenägenhet R29.6
- Hälsoundersökning Z00.1
- Högt blodtryck/hypertoni I10.9
- Intyg Z02.7
- Ospecifika symtom R69.9
- PEG-relaterade problem Z93.1
- Sjukdomskänsla trötthet R53.9

Förberedande åtgärder

- Se alltid även ESS 47
- Venös blodgas (vB-laktat) - om möjligt

Röda symtom

- Akut konfusion och samtidigt SBT >240mmHg och DBT >140mmHg
- Förhöjt B-laktat (enl lokala riktlinjer)
- HF / puls högre än SBT

Orange symtom

- Akut konfusion/delirium – snabb förändring senaste dygnet
- DBT >140mmHg (upprepade mätningar) samt klar och opåverkad

Gula symtom

- Avvikande beteende - nyttillkommet
- Immunosupprimerad patient - med ospecifika eller ej ESS listade symtom
- Hastigt insättande - med ospecifika eller ej ESS listade symtom

Gröna symtom

- Essentiell hypertoni som behöver följas upp inom primärvården.
- PEG (gastrostomi) som lossnat eller riskerar att åka ut
- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

- | | |
|---|------------------------------|
| ➔ Provpaket: Stort trauma /chock/hjärtstopp | ➔ Blodgas |
| ➔ Blodgas | ➔ Rundodling vid feber >38.5 |
| ➔ Rundodling vid feber >38.5 | ➔ PVK |
| ➔ PVK | ➔ EKG |
| ➔ EKG-uppkoppling | ➔ Rutinpaket |
| ➔ CVS-rutin | ➔ Rundodling vid feber >38.5 |

Överväg annan ESS? Särskilt vid röd/orange prioritet

Kapillärt CRP
Kapillärt Hb
EKG
Bladderscan
Urinsticka
U-hCG på fertil kvinna

- Gravid patient, se även ESS 21
- Misstanke om allvarlig infektion, se även ESS 47
- Neurologiska bortfall, se även ESS 12
- Tremor vid missbruk, se ESS 85

RETTS faktaruta

Det finns potentiellt allvarliga bakomliggande orsaker som psykiatri, misshandel, sociala förhållande, infektion, skador, förgiftningar etc. som kan ge ospecifika symtom. Tänk på att äldre patienter kan ha svårt att redogöra för sin symtombild av olika skäl.

Matcha symtombilden först och främst mot kriterier i andra symtomkort än

ESS 53 som delvis är en ospecifik ESS och inte bör användas slentrianmässigt inom akutsjukvården.

Hypotoni/hypertoni:

Patienter som söker vård med högt blodtryck är ofta remisspatienter. Högt eller lågt blodtryck är ett vanligt undersökningsfynd i akutvårdskedjan. Ett eller några få höga mätvärden behöver dock INTE vara hypertoni utan kan vara fysiologiskt då patienten har en hög cardiac output och vasokonstriktion på grund av stresspådrag. Om högt blodtryck däremot är associerat med cerebrala symtom och/eller kardiella symtom skall högt blodtryck värderas som ett möjligt alarmtecken och handläggas därefter.

OBS: Vid blodtryck $\geq 160/110$ mmHg på gravida, skall preeklampsi misstänkas.

Malign hypertoni:

Om patienten på urinsticka inte har proteinuri så kan det höga blodtrycket sannolikt vara tillfälligt. Vid misstanke om malign hypertoni, ett tillstånd som är ovanligt, skall patienten handläggas mer skyndsamt och alltid skrivas in på sjukhus. Malign hypertoni går alltid med proteinuri, fundus hypertonicus III och ofta med hypertensiv encephalopati (påverkat sensorium).

Fallbenägenhet:

Pat med återkommande falltillbud den sista tiden bör genomgå en mer omfattande undersökning av den utlösande faktorn.

PEG (gastrostomi) som åkt ut bör snarast åtgärdas, då det perkutana ingångshålet snabbt försluts. Hålet kan vidmakthållas genom att en vanlig KAD förs in.

- Dubbelseende - enskilt öga (Monokulär diplopi) H53.2
- Infektion öga H05.9
- Ögoninfektion H05.9
- Ögonproblem H57.9

Röda symtom

- Nyopererat öga, med plötslig svår värk och synnedsättning (endoftalmit)
- Plötslig svår värk i öga och synnedsättning med rött öga /illamående/kräkning/ljusstel pupill.

Orange symtom

- Akut synnedsättning i enskilt öga - övergående <1 dygn - (misstanke om Amaurosis fugax), Se Faktaruta.
- Feber >38,5°C och frossa senaste 12 timmarna

Gula symtom

- Infekterat/rött öga med synpåverkan
- Plötslig synnedsättning/synförändring/skugga framför ögat
- Spontan blödning i ögat med synförändring

Gröna symtom

- Dubbelseende - enskilt öga (Monokulär diplopi)
- Övriga med spontan blödning i ögat
- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

Ordinationer efter kontakt med ögonjour

- Dubbelseende - båda ögonen (Binokulär diplopi), se istället ESS 12
- Misstanke om allvarlig infektion, se även ESS 47
- Postoperativa besvär, se ESS 72
- Synfältsbortfall, se istället ESS 12
- Ögonskada, se istället ESS 37

RETTS faktaruta

Ögonproblem och infektion hanteras i regel av primärvården.

Fokalneurologiska bortfallssymtom:

Orsakade av en cirkulationsrubbing i en artär som försörjer ett specifikt kärlområde i centrala nervsystemet, där samtliga symtom är övergående inom 24 timmar (vanligen inom 5-60 minuter). Även arteriellt orsakad övergående monokulär synnedsättning, Amaurosis fugax, tillhör begreppet TIA.

Akut debuterande fokalneurologiska bortfall som kvarstår skall handläggas som misstänkt stroke.

Dubbelseende enskilt öga (Monokulär diplopi):

Är sällan tidskritiskt. Hanteras av ögonläkare inom primärvård.

Dubbelseende båda ögonen:

Var observant på att symtom som "dubbelseende" som drabbar båda ögonen samtidigt (Binocular diplopia), kan vara tecken på stroke.

Andra symtom:

Synfältsbortfall, isolerade symtom som plötslig synrubbing, kan vara tecken på stroke, men kan också bero på akut Glaukom.

Vid misstanke om stroke (Ex. Synfältsbortfall/Binokulär diplopi), se istället ESS 12.

Vid misshandel och ögonskada, se istället ESS 37.

- Cirkulationsstillestånd I46.9

Röda symtom

- Pågående HLR
- ROSC

Orange symtom**Gula symtom****Gröna symtom****Blåa symtom**

- Patienten avliden. Återupplivning ej påbörjad/avslutad utan resultat

RETTS processåtgärder**RETTS faktaruta**

Vid hjärtstopp startas HLR regelmässigt. Om patienten återfår någon form av cirkulation (ROSC) är patienten fortfarande prioritet RÖD. Oavsett orsak till cirkulationsstillestånd eller resultat av återupplivningsförsök, kan denna ESS användas för registrering av patienten.

Gäller patienter som påträffas med cirkulationsstillestånd, EJ patienter som under vårdtiden får cirkulationsstillestånd. Detta för att fortfarande kunna mäta mortaliteten i respektive ESS.

- Provsvarsalgoritm i RETTS R79.9
- Rekommenderade basprover i RETTS

Röda symtom

- pH <7,3

Orange symtom

- BE <-4 eller >4 - nytillkommen
- B-ketoner >3 mmol/L
- B-laktat >4.0 mmol/L
- CRP >200 g/L
- P-glukos <3 eller >25 mmol/L
- P-glucos >15 mmol/L samt typ 1 diabetes
- PK-INR >2,5 för patient utan koagulationshämmande läkemedel
- S-K >5,5 eller <2,7 mmol/L
- S-kreatenin >500 micromol/L
- S-Na <125 mmol/L
- S-paracetamol micromol/L > referens för antidotbehandling
- Troponin nanogram/L > lokal gräns för myokardinfarkt/ACS

Gula symtom

- Hb <90 g/L
- LPK <1,0

Gröna symtom

- Trombocytopeni/trombocytos
- Inget av ovanstående

Blåa symtom

Lokala processåtgärder

➡ Provpaket: Stort trauma /chock/hjärtstopp

➡ Blodgas

➡ Rundodling vid feber >38.5

➡ PVK, överväg 2st

➡ EKG-uppkoppling

➡ Blodgruppering och Bastest om anemi

➡ CVS-rutin/Bukrutin

➡ Blodgas

➡ Rundodling vid feber >38.5

➡ PVK

➡ EKG-uppkoppling

➡ Blodgruppering och Bastest om anemi

➡ Rutinpaket

➡ Blodgas

➡ Rundodling vid feber >38.5

➡ PVK

➡ EKG

➡ Blodgruppering och Bastest om anemi

Överväg annan ESS?

RETTS faktaruta

Inom akutsjukvården finns det ett behov men också en ökad tillgång till patientnära analyser som oftast ger snabba analyssvar. Detta ställer högre krav på snabb bedömning och åtgärd eftersom vissa analyser har ett starkare direkt prediktivt värde än andra.

De flesta patienter som söker på akutmottagningen med en kontaktorsak som innehåller en eller flera frågor kommer med en remiss från primärvården, närsjukvård eller liknande.

De provsvar som finns i ESS 70 kan då användas som prioritetsnivåer kopplat till det provsvar som anges på remissen.

- Gipsproblem T98.3

Röda symtom

Orange symtom

- Ingen kapillär återfyllnad nedom skada/gips
- Kall extremitet
- Svår smärta i den gipsade extremiteten
- Symtom/tecken på kompartmentsyndrom

Gula symtom

- Lokal infektion
- Måttlig smärta i den gipsade extremiteten

Gröna symtom

- Trasigt gips
- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

- | | |
|------------------|---|
| ➔ Rutinpaket | ➔ Bastest |
| ➔ Blodgas | ➔ Blododling vid infektionstecken eller feber >38,5 |
| ➔ Kapillärt CRP | ➔ Kapillärt CRP |
| ➔ Blodgruppering | |

Lossa gips efter läkarkontakt

RETTS faktaruta

Gipsproblem:

Fråga efter anamnes på skadan, åtgärd + tidsförloppet, hur länge har gipset suttit? Finns det genomförd kirurgi före gipsning? Om, ja så skall komplikation med postoperativ infektion uteslutas. Allmänna infektionstecken, B-laktat, venös blodgas.

Gips som sitter fel kan både orsaka obehag och skador. Om patienten klagar på smärta eller obehag skall det alltid tas på allvar. Tilltagande smärtor får inte nonchaleras utan noggrann undersökning.

Normalt sker inte prioritering utifrån smärtupplevelsen i RETTS med undantaget i denna ESS. Se VAS skala nedan.

Komplikationer kan utvecklas på kort tid. Ofta finns det anledning att avlägsna gipset men då bör läkare kontaktas först och det görs på ordination eller delegering enligt lokal processåtgärd. Komplikationer är tex. tryckskador, sårbildning, kärlskador eller nervskador.

Om tecken på cirkulationsstörning finns, se orange kriterier, skall gipset avlägsnas omedelbart.

Om patienten endast har svullnad eller hematoma kan det ibland vara normalstillstånd efter skadan. Dessutom kan instabila frakturer komma ur läge om gipset avlägsnas varför patienter med reponerade frakturer som princip bör läkarbedömas före avgipsning.

Kompartmentsyndrom:

Ett tillstånd där trycket inuti muskulaturen stiger till den punkt att det hämmar blodflödet, vilket leder till syrebrist (ischemi). Återställs inte blodförsörjning i extremiteten skyndsamt, kan tillståndet inom några timmar leda till permanent och svår muskelskada, nekros och vävnadsdöd. Observera att normala pulsationer inte utesluter kompartmentsyndrom.

Symtom/tecken på kompartmentsyndrom:

- Svår smärta i extremitet även vid passiv rörelse
- Distal känselnedsättning
- Nedsatt muskelkraft, muskelsvaghet intill pares
- Lokal ömhet
- Nedsatt färg och temperatur

Exempel orsaker till kompartmentsyndrom:

- Trånga förband (gips)
- Operativa ingrepp
- Inflammation
- Brännskada eller trauma.

Prioritet vid kompartmentsyndrom:

Kompartmentsyndrom är ett tidskritiskt tillstånd och tidsfaktorn är särskilt avgörande. I RETTS prioriteras den här patienten lägst ORANGE.

Överväg därför att prioritera upp till RÖD utifrån kliniska fynd och omständigheter I DE FALL DÅ TIDEN TILL BEHANDLING bedöms påverka patientens tillstånd negativt.

Smärta graderas enligt lokalt verktyg för smärtskattning (oftast VAS-skalan). Smärtvärdering skall användas på samma patient och inte jämföras mellan patienter.

Ingen smärta: 0

Lätt smärta: 1-3

Måttlig smärta: 4-7

Svår smärta: 8-10

- Operationskomplikation T98.3

Röda symtom

- Initialt / lägst SBT <90 mmHg
- Nyopererat öga, med plötslig svår värk och synnedsättning (endoftalmit)
- Petekier och infektionstecken
- Postoperativ ymnig reblödning från operationssår - ej kontrollerbar
- Pågående smärta samt blek/kallsvettig
- Symtom och kliniska tecken som uppfyller nationella kriterier för sepsisalarm

Orange symtom

- Anlagd kärlanastomos/kärlfistel
- Blödning/svullnad från operation i och runt halsen
- Feber >38,5°C och frossa senaste 12 timmarna
- Hematom med svullnad i ljumske - snabbt växande - efter ingrepp
- Immunosupprimerad patient
- Koagulationshämmande läkemedel eller blödningsbenägenhet samt pågående blödning
- Sårruptur på bålen
- Symtom/tecken på kompartmentsyndrom

Gula symtom

- Hematom med svullnad i handled - snabbt växande - efter ingrepp
- Lokala infektionstecken
- Postoperativ reblödning från operationssår - komprimerbar /kontrollerad - behov av re-suturering

Gröna symtom

- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

- | | |
|---|------------------------------|
| ➔ Provpaket: Stort trauma /chock/hjärtstopp | ➔ Rutinpaket |
| ➔ Blodgas | ➔ Blodgas |
| ➔ Rundodling vid feber >38.5 | ➔ Rundodling vid feber >38.5 |
| ➔ Blodgruppering | ➔ Blodgruppering |
| ➔ Bastest | ➔ Bastest |
| ➔ PVK x2 | ➔ PVK |
| ➔ Plasmalyte | ➔ EKG-uppkoppling |
| ➔ Beställa blod? | ➔ Bladderscan |
| ➔ EKG-uppkoppling | ➔ U-hCG på fertil kvinna |
| ➔ Bladderscan | ➔ Rutinpaket |

- Misstanke om allvarlig infektion, se även ESS 47

RETTS faktaruta

Fråga efter anamnesen; typ av kirurgi, lokalisation och operationsdag, dragna drän, när??

Operationskomplikationer kan vara lokala komplikationer som tex. sårruptur, infektion eller blödning. Det kan även röra sig om mer generella komplikationer som DVT, UVI, pneumoni, sepsis men de handläggs bäst med annan algoritm t.ex ESS 15 eller ESS 47.

Infektion:

Symtom som kan indikera allvarlig infektion och kan leda till sepsis:

- Feber/skakfrossa/hypotermi
- Konfusion/vakenhetssänkning/motorisk oro
- Uttalad allmänpåverkan/allmän svaghet
- Andnöd/andfåddhet/takypné/dyspné
- Kräkning/diarré
- Smärta (ex buk)

Feber är vanligt men det är även vanligt att patienterna inte har feber eller är hypoterma. Framförallt i sköra patientgrupper. Desto kraftigare frossa desto större risk att det rör sig om feber

Alla patienter med sepsis har inte feber och tänk på att patienten kan ha tagit febernedsättande, som påverkar mätningen

OBS! Lägre temperatur vid ankomst är korrelerad till högre sjukhusdödlighet.

Om det finns förband eller gips som täcker ett operationsområde bör det alltid avlägsnas vid misstanke om komplikation.

Kompartmentsyndrom (se ESS 71) kan uppstå pga inre svullnad efter trauma (fraktur, blödning eller muskelbristning), yttre kompression (gipsbehandling) eller vid brännskada. Det ökade trycket leder till nedsatt blodförsörjning i extremiteten och kan inom några timmar leda till permanent och svår muskelskada. Symtomen är ofta svår smärta, nedsatt muskelkraft, nedsatt känsel, nedsatt färg och temperatur samt smärta vid passiv rörelse. Observera att normala pulsationer inte utesluter kompartmentsyndrom!

Patienter som är nyopererade på halsen kan vid blödning snabbt få kompression av luftstrupen med åtföljande ofri luftväg.

- Depressiv episod F32.9

Förberedande åtgärder

- Farlighetsbedömning och suicidriskbedömning

Röda symtom**Orange symtom****Gula symtom**

- Social isolering
- Psykomotorisk oro (oroligt beteende, rastlöshet)
- Pågående affektlabilitet
- Påtaglig hämning (emotionellt, motoriskt, kognitivt)

Gröna symtom

- Anhedoni (svårigheter att känna glädje, lust, intresse)
- Asteni (trötthet/uttröttbarhet, irritabilitet)
- Förändrad aptit (viktnedgång, viktuppgång)
- Nedsatt koncentration
- Tendens till isolering

Blåa symtom

- Efter undersökning och bedömning enligt ESS 90 inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

Dygnet runt kontaktas psykiatriska akutteamet, om ej behov av somatisk bedömning först. Tänk på att detta kan vara en riskpatient, ordna adekvat tillsyn (överbäg extravak) tills personal från psykiatrien övertar ansvaret.

- Farlighetsbedömning, se även ESS 98
- Suicidriskbedömning, se även ESS 99

RETTS faktaruta

Överbäg alltid om det kan finnas bakomliggande somatisk orsak. Använd somatisk ESS i kombination vid somatiska symtom.

Nedstämdhet är den vanligaste orsaken till kontakt med psykiatri. Symtom under större delen av tiden under minst 2 veckor påverkan av, samt nedsatt funktionsnivå, talar för en kliniskt signifikant depression.

Minskat intresse, lust och glädje är vanligt. Skuldkänslor, ambivalens, irritabilitet, energilöshet, sömnstörningar hör ofta till bilden.

Patienter med melankoliska symtom (uttalade hämning, sömnstörning, skuldkänslor, svår ångest, viktnedgång, likgiltighet, hopplöshet) ska handläggas i relation till eventuell suicidrisk.

Samsjuklighet med missbruk ökar suicidrisken. Viktigt att fastställa tidigare suicidförsök, eventuell bipolär sjukdom eller underliggande psykossjukdom.

- Hypomani F30.0
- Mani F30.9

Förberedande åtgärder

- Farlighetsbedömning och suicidriskbedömning

Röda symtom**Orange symtom****Gula symtom**

- Blandtillstånd (samtidig hypomani/ mani och depression)
- Desorientering/konfusion
- Gränslöshet
- Psykomotorisk oro (oroligt beteende, rastlöshet)
- Pågående affektlabilitet
- Riskfyllt beteende
- Snabbt tankförlopp, kraftigt ökat talflöde (icke avledbart tal)

Gröna symtom

- Lätt distraherbar
- Minskat sömnbehov
- Ökad energi, upprymdhet
- Ökad impulsivitet
- Ökad social interaktion
- Ökat talflöde

Blåa symtom

- Efter undersökning och bedömning enligt ESS 90 inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

Dygnet runt kontaktas psykiatriska akutteamet, om ej behov av somatisk bedömning först. Tänk på att detta kan vara en riskpatient, ordna adekvat tillsyn (överbäg extravak) tills personal från psykiatri övertar ansvaret.

- Farlighetsbedömning, se även ESS 98
- Förgiftning, se även ESS 40
- Suicidriskbedömning, se även ESS 99

RETTS faktaruta

Överbäg alltid om det kan finnas bakomliggande somatisk orsak. Använd somatisk ESS i kombination vid somatiska symtom.

Vid mani/ hypomani är grundstämningen övervägande förhöjd men blandtillstånd dvs samtidig depressivitet är inte ovanligt. Patienten har ökat självförtroende eller grandiositet, uppvisar rastlöshet, minskat sömnbehov, ångest, snabbt tankeförlopp, ökad talflöde, distraherbarhet och koncentrationssvårigheter. Vid mani är sjukdomsbilden mer uttalad, ofta saknas sjukdomsinsikt och psykotiska symtom är vanligt.

Ökad impulsivitet, gränslöshet och brist på "takt och ton" är vanligt. Som vid depression måste samtidigt missbruk/abstinens uteslutas.

Blandtillstånd har hög suicidrisk.

- Panikångestsyndrom F41.0
- Ångest F41.9

Förberedande åtgärder

- Farlighetsbedömning och suicidriskbedömning

Röda symtom**Orange symtom****Gula symtom**

- Dissociation (överklighetskänsla beträffande sin identitet eller omgivning)
- Psykomotorisk oro (oroligt beteende, rastlöshet)
- Pågående affektlabilitet
- Pågående panikattack
- Somatiska symtom
- Tvångstankar/tvångshandlingar
- Ångest/oro som avsevärt begränsar vardagliga/basala aktiviteter

Gröna symtom

- Förekomst av ångest och/eller oro

Blåa symtom

- Efter undersökning och bedömning enligt ESS 90 inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

Dygnet runt kontaktas psykiatriska akutteamet, om ej behov av somatisk bedömning först. Tänk på att detta kan vara en riskpatient, ordna adekvat tillsyn (överbäg extravak) tills personal från psykiatrien övertar ansvaret.

- Farlighetsbedömning, se även ESS 98
- Suicidriskbedömning, se även ESS 99
- Vid samtidig bröstsmärta, se även ESS 5
- Vid samtidig dyspné, se ESS 4

RETTS faktaruta

Överväg alltid om det kan finnas bakomliggande somatisk orsak. Använd somatisk ESS i kombination med ESS 80-99 vid samtidiga somatiska symtom.

Ångest/oro kan begränsa patientens funktionsnivå, särskilt paniksyndrom, social fobi och tvångssyndrom. Samtliga tillstånd kan leda till sekundära mer ihållande ångestsymtom och sömnstörningar. Inte sällan utvecklar patienten även lätt till måttliga depressiva symtom.

Panikattack är den vanligaste orsaken till ett akutbesök. Patienten upplever stort obehag då symtomen debuterar till synes utan orsak inom några minuter och når sin kulmen efter någon halvtimme. Symtomen klingar av/går över av sig själv efter en stund.

Symtom som ses är hjärklappning, svettning, darrning, skakning, hyperventilation, kvävningsskänsla, smärta eller obehag i bröstet/magen, rädsla att mista kontrollen eller "bli tokig" samt dödsskräck. Bröstsmärtor som liknar symtom på hjärtinfarkt är inte ovanligt.

Alla ångestsyndrom kan ge panikattacker men långvariga ångesttillstånd utan panikattacker är också en sökorsak. Social fobi innebär en rädsla för att exponera sig i olika sammanhang och att framträda inför andra. Det är socialt handikappande och patienter anpassar sitt liv efter symtomen vilket medför nedsatt funktionsnivå och tendens till isolation.

Missbruk/abstinens är en viktig differentialdiagnos och samtidig förekomst är mycket vanligt förekommande och medför nedsatt funktionsnivå och tendens till isolation.

Dissociation = överklighetskänsla beträffande sin identitet eller omgivningen, förändrad minnesfunktion (exempelvis genom bortträngning)

- Sömnstörning G47.9

Förberedande åtgärder

- Farlighetsbedömning och suicidriskbedömning

Röda symtom**Orange symtom****Gula symtom**

- Overklighetskänsla
- Psykomotorisk oro (oroligt beteende, rastlöshet)
- Pågående affektlabilitet

Gröna symtom

- Asteni (trötthet/uttröttbarhet, irritabilitet) som begränsar vardagliga/basala aktiviteter
- Koncentrationssvårigheter

Blåa symtom

- Efter undersökning och bedömning enligt ESS 90 inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

Dygnet runt kontaktas psykiatriska akutteamet, om ej behov av somatisk bedömning först. Tänk på att detta kan vara en riskpatient, ordna adekvat tillsyn (överbäg extravak) tills personal från psykiatrien övertar ansvaret.

- Farlighetsbedömning, se även ESS 98
- Suicidriskbedömning, se även ESS 99

RETTS faktaruta

Överväg alltid om det kan finnas bakomliggande somatisk orsak. Använd somatisk ESS i kombination vid somatiska symtom. Sömnstörning är vanligt vid de flesta psykiska och somatiska sjukdomar samt vid belastande/stressfyllda livsbetingelser. Hypersomni innebär onormal trötthet vilket visar sig i förlängd nattsömn, uttalad trötthet dagtid, eller behov av att sova dagtid.

Hyposomni innebär förkortad sömntid vilket kan inkludera svårigheter att somna, orolig yttlig sömn med frekventa uppvaknanden samt tidigt uppvaknande. Alkohol och annat missbruk liksom utveckling av tolerans mot sedvanliga sömnmediciner är vanliga orsaker till sömnstörning. Observera att antidepressiva, särskilt SSRI ofta är en annan orsak till sömnstörning. Omfattande anamnes är av stor vikt för att utesluta bakomliggande orsaker. Långvarig sömnstörning kan ge symtom på ångest och nedstämdhet.

- Psykotiska symtom F23.9

Förberedande åtgärder

- Farlighetsbedömning och suicidriskbedömning
- Alkometer ev U-toxicitetprov - om möjligt

Röda symtom**Orange symtom****Gula symtom**

- Bristande sjukdomsinsikt
- Hallucinationer, vanföreställningar eller tankestörningar
- Psykomotorisk oro (oroligt beteende, rastlöshet)
- Pågående affektlabilitet

Gröna symtom

- Kroniska vanföreställningar, negativa symtom och/eller hallucinationer

Blåa symtom

- Efter undersökning och bedömning enligt ESS 90 inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

Dygnet runt kontaktas psykiatriska akutteamet, om ej behov av somatisk bedömning först. Tänk på att detta kan vara en riskpatient, ordna adekvat tillsyn (överbäg extravak) tills personal från psykiatri övertar ansvaret.

- Farlighetsbedömning, se även ESS 98
- Förgiftning, se även ESS 40
- Suicidriskbedömning, se även ESS 99

RETTS faktaruta

Överväg alltid om det kan finnas bakomliggande somatisk orsak. Använd somatisk ESS i kombination med ESS 80-99 vid samtidiga somatiska symtom.

Störd verklighetsuppfattning är vanligt förekommande vid psykosjukdomar, affektiva sjukdomar och missbruk. Den kan förekomma i form av hallucinos (hörsel, syn, lukt, smak, taktil) eller vanföreställningar.

Vid långvarig psykosjukdom kan kognitiva brister och negativa symtom (som emotionell avflackning, energilöshet och motivationsbrist) vara framträdande. Osammanhängande tal, katatoni (påverkan på motoriken; orörlig eller agiterad) kan ibland ses i akuta situationer.

Samsjuklighet med missbruk är vanligt (dubbeldiagnos) och ger mer allvariga psykotiska symtom. Drogrelaterad inducerad psykos förekommer inte sällan hos yngre, misstänk särskilt s.k. internetdroger. Var uppmärksam på tecken på cerebral påverkan eller kroppslig sjukdom. Långvarigt alkoholmissbruk kan ge bestående alkoholhallucinos.

Vid nydebuterad sjukdomsbild är anamnesen viktig och bör vara omfattande.

- Missbruk/beroende F10.2
- Tremor vid missbruk R.25.1

Förberedande åtgärder

- Farlighetsbedömning och suicidriskbedömning

Röda symtom

Orange symtom

- Abstinenssymtom med somatiska symtom
- Delirium tremens eller misstanke om
- Kramper i abstinensfas

Gula symtom

- Aktuell svår somatisk sjukdom
- Psykomotorisk oro (oroligt beteende, rastlöshet)
- Pågående affektlabilitet
- Tremor

Gröna symtom

- Missbruk som begränsar vardagliga/basala aktiviteter
- Önskemål om avgiftning eller abstinensbehandling hos patient med alkohol/substanspåverkan utan allvarigare symtom

Blåa symtom

- Efter undersökning och bedömning enligt ESS 90 inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

➔ Intoxrutin

➔ Blodgas

➔ PVK

➔ EKG-uppkoppling

➔ Intoxrutin

➔ Blodgas

➔ PVK

➔ EKG

Alkometer

Dygnet runt kontaktas psykiatriska akutteamet, om ej behov av somatisk bedömning först. Tänk på att detta kan vara en riskpatient, ordna adekvat tillsyn (överbäg extravak) tills personal från psykiatri övertar ansvaret.

- Farlighetsbedömning, se även ESS 98
- Förgiftning, se även ESS 40
- Suicidriskbedömning, se även ESS 99

RETTS faktaruta

Överbäg alltid om det kan finnas bakomliggande somatisk orsak. Använd somatisk ESS i kombination med ESS 80-99 vid samtidiga somatiska symtom.

Missbruk kan vara ett livslångt tillstånd med upprepade återfall. Uppmärksamma eventuell förekomst av somatiska och neurologiska skador. Anamnes på Delirium tremens och epileptiska anfall är viktigt eftersom det är allvarliga tillstånd.

Vanliga symtom vid Delirium tremens:

- plockighet
- vanföreställningar
- stark oro
- konfusion
- samt syn- och hörselhallucinos

Ökat blodtryck/puls och måttlig temperaturökning ses oftast.

Wernicke-Korsakoffs syndrom är orsakat av tiaminbrist och kräver omedelbar behandling.

Vanliga symtom:

- konfusion
- ostadig gång
- dubbelseende/nystagmus

LVM-anmälan enligt 6 § LVM bör övervägas via alla tillstånd med avancerat missbruk.

- Självskadebeteende F91.9

Förberedande åtgärder

- Farlighetsbedömning och suicidriskbedömning
- Uteslut Traumalarmskriterier ESS 38

Röda symtom

Orange symtom

- Koagulationshämmande läkemedel eller blödningsbenägenhet samt pågående blödning

Gula symtom

- Blödning (färska sårskada, se även skadekort)
- Impulsivitet
- Psykomotorisk oro (oroligt beteende, rastlöshet)
- Pågående affektlabilitet

Gröna symtom

- Självskadebeteende utan aktuell självskadehandling

Blåa symtom

- Efter undersökning och bedömning enligt ESS 90 inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

Kapillärt Hb vid sårskada med pågående eller avstannad blödning.

Dygnet runt kontaktas psykiatriska akutteamet, om ej behov av somatisk bedömning först. Tänk på att detta kan vara en riskpatient, ordna adekvat tillsyn (överbäg extravak) tills personal från psykiatri övertar ansvaret.

- Blödning - självskadebetingad, se även ESS 32
- Farlighetsbedömning, se även ESS 98
- Förgiftning, se även ESS 40
- Suicidriskbedömning, se även ESS 99
- Traumalarmskriterier, se ESS 38

RETTS faktaruta

Överväg alltid om det kan finnas bakomliggande somatisk orsak. Använd somatisk ESS i kombination med ESS 80-99 vid samtidiga somatiska symtom.

Personen utsätter avsiktligt sin kropp för skada exempelvis genom att skära eller bränna sig själv. Orsaken till beteendet är inte alltid tydlig för patienten. De med självskadebeteenden försöker sällan ta sitt liv. Den yttersta funktion självskadandet fyller är att hantera övermäktiga känslor. Känslor som kan beskrivas som fritt flytande ångest som lindras eller blir mer uthärdliga då de ersätts av kroppslig smärta.

I bilden ingår ofta impulsivitet. Självskadebeteende är ett vanligt symtom vid vissa personlighetsstörningar, som borderline eller andra tillstånd med emotionell instabilitet.

Påverkan av alkohol, eller benzodiazepiner ökar risken för självskada då dessa droger minskar tröskeln för impuls kontroll. Vid bedömning av patienten är det av stor vikt att patienten tillfrågas om anledningen till självskadebeteendet samt tillvägagångssätt och omfattning. Uppgifter om tidigare självskadebeteende skall alltid efterfrågas.

- Ätstörning F50.9

Förberedande åtgärder

- Farlighetsbedömning och suicidriskbedömning

Röda symtom

Orange symtom

Gula symtom

- BMI < 14
- Försämrad kognitiv funktion vid svältpåverkan

Gröna symtom

- Behov av att bryta recidiv av ätstörning
- BMI 14-17.5
- Hetsätning med/utan efterföljande självrensning
- Trötthetskänslor

Blåa symtom

- Efter undersökning och bedömning enligt ESS 90 inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

➔ Blodgas

➔ PVK

➔ EKG

➔ Blodgas

➔ EKG

Dygnet runt kontaktas psykiatriska akutteamet, om ej behov av somatisk bedömning först. Tänk på att detta kan vara en riskpatient, ordna adekvat tillsyn (överväg extravak) tills personal från psykiatri övertar ansvaret.

- Farlighetsbedömning, se även ESS 98
- Suicidriskbedömning, se även ESS 99

RETTS faktaruta

Överväg alltid om det kan finnas bakomliggande somatisk orsak. Använd somatisk ESS i kombination med ESS 80-99 vid samtidigt somatiska symtom.

Anorexia nervosa (AN) och Bulimia nervosa (BN) kännetecknas av en fixering vid kroppsform och vikt, vilket ger upphov till viktfoxi och uttalad rädsla att öka i vikt även om man är underviktig. Detta resulterar i bantning/svält och/eller hetsätning med kompensatoriskt beteende. Vid AN ska individen ha en avsiktligt låg vikt, som är mindre eller lika med 85% av vad som anses normalt med avseende på ålder och längd (BMI ≤ 17,5). Till sjukdomen hör även störd kroppsuppfattning.

Räkna ut BMI:

BMI = vikt / längd² (kg / M x M) ex: 82 kg / (1,82 X 1,82) = 24,75
Kvoten = BMI

Ett viktigt symtom på AN är amenorré. Vid AN påverkas flera av kroppens vitala organ, vilket kommer i uttryck i en mängd olika tecken och symtom av olika allvarlighetsgrad.

BN kännetecknas av hetsätning med kontrollförlust, vilket medför att man under en begränsad tidsperiod äter man en betydligt större mängd mat än vad som kan anses normalt. Ett kompensatoriskt beteende finns alltid vid självrensning (kräkning /laxering) eller genom svält och överdriven motionering. Både AN och BN ger upphov till såväl psykiska som fysiska komplikationer samt har hög komorbiditet i form av depression, tvångssyndrom, missbruk, social fobi, samt olika personlighetsstörningar.

- Krisreaktion F43.0
- Reaktion på svår stress F43.9

Förberedande åtgärder

- Farlighetsbedömning och suicidriskbedömning

Röda symtom**Orange symtom****Gula symtom**

- Dissociation (överklighetskänsla beträffande sin identitet eller omgivning)
- Psykomotorisk oro (oroligt beteende, rastlöshet)
- Pågående affektlabilitet
- Stupor

Gröna symtom

- Isoleringstendens
- Koncentrationssvårigheter

Blåa symtom

- Efter undersökning och bedömning enligt ESS 90 inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

Dygnet runt kontaktas psykiatriska akutteamet, om ej behov av somatisk bedömning först. Tänk på att detta kan vara en riskpatient, ordna adekvat tillsyn (överbäg extravak) tills personal från psykiatrien övertar ansvaret.

- Farlighetsbedömning, se även ESS 98
- Suicidriskbedömning, se även ESS 99

RETTS faktaruta

Överväg alltid om det kan finnas bakomliggande somatisk orsak. Använd somatisk ESS i kombination med ESS 80-99 vid samtidiga somatiska symtom.

Ett flertal psykiatriska sjukdomstillstånd kan utvecklas som reaktion på akut eller subakut stress (i olika former). Akut stressreaktion, posttraumatiskt stressyndrom, anpassningsstörning samt utmattningssyndrom är vanliga orsaker till kontakt med akutmottagningen. Gemensamt för alla tillstånd är att yttre faktorer, en traumatisk händelse i bred mening, upplevs överväldigande och försätter patienten i ett tämligen hjälplöst tillstånd med rädsla, skräck, ångest, oro, nedstämdhet och beteendestörningar.

Personen kan reagera med intensiv rädsla, hjälplöshet eller skräck särskilt vid händelser som innebär död och allvarlig skada mot egen eller andras/närståendes fysiska/psykiska integritet. En "normal akut stressreaktion" brukar avta inom 48 timmar. Ibland kan dock symtomen kan kvarstå längre än så.

- Demens F03.9
- Desorienterad R41.0
- Organiska psykiska störningar F00-F09

Förberedande åtgärder

- Farlighetsbedömning och suicidriskbedömning

Röda symtom**Orange symtom****Gula symtom**

- Apati
- Desorientering/konfusion
- Försämrat minne, språkstörning, nedsatt motorisk förmåga
- Psykomotorisk oro (oroligt beteende, rastlöshet)
- Pågående affektlabilitet

Gröna symtom

- För omgivningen tydligt avvikande beteende, nedsatt omdöme och insikt

Blåa symtom

- Efter undersökning och bedömning enligt ESS 90 inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

Eventuellt Intoxrutin
Kapillärt CRP
Kapillärt Hb
EKG
Bladderscan
Urinsticka

- Farlighetsbedömning, se även ESS 98
- Suicidriskbedömning, se även ESS 99

RETTS faktaruta

Överväg alltid om det kan finnas bakomliggande somatisk orsak. Använd somatisk ESS i kombination med ESS 80-99 vid samtidiga somatiska symtom.

Oklar kontaktorsak kan maskera en allvarlig psykisk sjukdom. Alkohol och/eller drogrelaterade eller bakomliggande somatisk /neurologisk sjukdom är vanliga orsaker som kan ge en varierande och fluktuerande symtombild.

Påverkan av kognitiva funktioner (försämrat minne, språkstörning, nedsatt motorisk förmåga och desorientering) kan tyda på ett permanent demenstillstånd. Särskilda beteenderubbningar som rastlöshet, oro, paranoidea symtom och andra vanföreställningar, aggressivitet, hallucinos, konfusion, bristande sjukdomsinsikt är vanliga symtom hos äldre med cerebral påverkan.

- Ej akut psykiatrisk problematik F99.9

Förberedande åtgärder

- Farlighetsbedömning och suicidriskbedömning

Röda symtom**Orange symtom****Gula symtom****Gröna symtom**

- Ej akut - övrig psykiatrisk problematik

Blåa symtom

- Enbart social problematik
- Ex. Lindrig psykisk ohälsa som inte uppfyller kriterier inom övriga psykiatriska sökorsaker
- Opåverkat ABCDE (vitalparametrar tagna)
- Opåverkat allmäntillstånd
- Patient som inte uppfyller tydliga kriterier för akut läkarundersökning.
- Önskemål om recept/läkemedel/intyg
- Önskemål om samtalsstöd som inte uppfyller kriterier för psykiatrisk akutsjukvård

Lokala processåtgärder

Dygnet runt kontaktas psykiatriska akutteamet, om ej behov av somatisk bedömning först. Tänk på att detta kan vara en riskpatient, ordna adekvat tillsyn (överbäg extravak) tills personal från psykiatrin övertar ansvaret.

- Farlighetsbedömning, se även ESS 98
- Suicidriskbedömning, se även ESS 99

RETTS faktaruta

Patienter som inkommer till en psykiatrisk akutmottagning utgör en heterogen patientgrupp där det kan vara svårt att bedöma det aktuella vårdbehovet. Därför kommer alla sökanden genomgå bedömning.

Vid hänvisning av patient till primärvård, annan akutmottagning eller ordinarie öppenvård så SKALL tillräckligt beslutsunderlag finnas till grund för bedömningen.

Äldre patienter har en ökad risk för komplikationer, biverkningar och kan ha svårt att redogöra för symtombilden. Detta medför att åldern är en faktor att ta hänsyn till om patienten skall hänvisas till annan vårdgivare eller inte.

- Organisk katatoni F06.1

Förberedande åtgärder

- Farlighetsbedömning och suicidriskbedömning

Röda symtom

- Dehydrering
- Hypertermi
- Mutism eller stupor

Orange symtom

- Automatisk lydnad
- Ekolali (upprepning av andras ord)
- Ekopraxi (imitation av andras rörelser)
- Muskelrigiditet
- Stereotypier (enkla upprepade rörelser)
- Vaxliknande böjlighet

Gula symtom

- Koagulationshämmande läkemedel eller blödningsbenägenhet

Gröna symtom**Blåa symtom**

- Inget av ovanstående och efter undersökning och bedömning enligt ESS 90 inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

- | | |
|---|----------------|
| ➔ Provpaket: Stort trauma /chock/hjärtstopp | ➔ Blodgas |
| ➔ Blodgas | ➔ PVK |
| ➔ PVK | ➔ EKG |
| ➔ EKG-uppkoppling | ➔ Kapillärt Hb |
| ➔ CVS-rutin/intoxrutin | |

Bladderscan

Urinsticka

U-hCG på fertil kvinna

- Farlighetsbedömning, se även ESS 98
- Suicidriskbedömning, se även ESS 99

RETTS faktaruta

Katatoni är ett ovanligt men allvarligt sjukdomstillstånd som kan uppkomma vid schizofreni, affektiva tillstånd, toxiska tillstånd (SSRI, neuroleptika) och somatisk sjukdom.

De vanligaste symtomen och tecken är de som beskrivs i röd och orange ruta.

Tillståndet är livshotande och behandling av dehydrering och hypertermi är viktigt tidigt i förloppet.

- Beteendestörning av utagerande slag F91
- Farlighetsbedömning AU122

Förberedande åtgärder

- Suicidriskbedömning

Röda symtom

- Pågående aktivt våldsam / pågående attack mot person eller djur

Orange symtom

- Allvarlig våldshandling senaste 7 dagarna
- Attackerar föremål
- Fysiskt hotfullt beteende
- Snabbt växlande humör
- Verbalt hotfullt beteende

Gula symtom

- Bristande emotionell kontakt
- Bullrigt beteende
- Retligt/lättirriterat beteende
- Utförd våldshandling från 7 dagar till 3 månader

Gröna symtom

- Förvirrat/desorienterat beteende
- Tidigare våldsam beteende (äldre än 3 månader)

Blåa symtom

- Efter undersökning och bedömning enligt ESS 90 inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

Dygnet runt kontaktas psykiatriska akutteamet, om ej behov av somatisk bedömning först. Tänk på att detta kan vara en riskpatient, ordna adekvat tillsyn (övernatt extravak) tills personal från psykiatri övertar ansvaret.

- Förgiftning, se även ESS 40
- Suicidriskbedömning, se även ESS 99

RETTS faktaruta**Statistiska riskfaktorer:**

- Man 16-25 år
- Missbruk/beroende av alkohol/droger
- Psykostillstånd (schizofreni, vanföreställningssyndrom, manisk episod)
- Personlighetsstörning (framförallt antisocial och emotionellt instabil)
- Övriga psykiatriska diagnoser (Aspergers syndrom, utvecklingsstörning, hjärnskada, neurologiska sjukdomar)
- Tidigare beteendestörning före 16 års ålder (uppförandestörning, antisocialt beteende)
- Tidigare kriminalitet
- Tidigare aggressivitet/våld (hot, ofredande, misshandel, dråp, mord)
- Viktimisering* senaste året (*ett samlingsnamn för olika typer av övergrepp som en person kan utsättas för i barndomen och /eller i vuxen ålder. Övergreppen kan vara sociala, ekonomiska, psykiska, sexuella och fysiska).
- Aktuella sociala problem
- Arbetsrelaterade (arbetslös, konflikter på arbetsplatsen)
- Bostadslös (tillfälligt eller permanent)
- Relationsproblem (separation, förlust)
- Ekonomiska
- Andra stressorer (upplevd kränkning)
- Aktuell psykiatrisk problematik
- Avvikelse från vårdplan hos känd patient (uteblivna besök, bristande compliance till läkemedelsbehandling)
- Tankar/röster om att skada någon
- Upplevt hot mot den egna personen
- Agerar utifrån psykossymtom (vanföreställningar, hallucinos)
- Bristande sjukdomsinsikt
- Negativ attityd
- Bristande emotionell kontakt
- Agiterade beteenden (irritabilitet, agitation, rastlöshet, bullrigt el. gravt avvikande beteende)
- Alkohol/drogpåverkad
- Abstinens alkohol/drogpåverkad
- Tidigare känt samband med våldshandlingar
- Förvirrat/desorienterat beteende

- Suicidriskbedömning AU118

Förberedande åtgärder

- Farlighetsbedömning

Röda symtom

- Pågående/Omedelbar suicidal handling

Orange symtom

- Allvarlig suicidhandling senaste 7 dagarna
- Nyttillkomna/förvärrade suicidtankar i kombination med alkohol /drogpåverkan
- Uttalade suicidala avsikter och/eller planer

Gula symtom

- Nyttillkomna/förvärrade suicidtankar
- Utförd suicidhandling från 7 dagar till 3 månader

Gröna symtom

- Kroniska suicidtankar utan försämring
- Suicidförsök tidigare än 3 månader
- Uttalade dödstanke
- Uttalad dödsönskan

Blåa symtom

- Efter undersökning och bedömning enligt ESS 90 inget omedelbart behov av akutsjukvård

Lokala processåtgärder

Dygnet runt kontaktas psykiatriska akutteamet, om ej behov av somatisk bedömning först. Tänk på att detta kan vara en riskpatient, ordna adekvat tillsyn (överbäg extravak) tills personal från psykiatri övertar ansvaret.

- Farlighetsbedömning, se även ESS 98

RETTS faktaruta

Överväg alltid om det kan finnas bakomliggande somatisk orsak. Använd somatisk ESS i kombination vid somatiska symtom.

Impulsiva patienter kan göra allvarliga suicidförsök trots att de inte har medvetna dödsönskningar/suicidtankar.

Patienter med antisociala/manipulativa personlighetsdrag kan uttala hot om suicid i syfte att få sina krav uppfyllda, i dessa fall är ej suicidstegen tillämplig.

Patient som motsätter sig vård eller är likgiltig till vård bör ges en högre prioritet.

Statistiska riskfaktorer:

- Ensamboende utan relationer
- Högt ångestnivå/tankestörning/psykotiskt tänkande oavsett grundsjukdom
- Kön (man)
- Missbruk/beroende*
- Närstående som suiciderat
- Psykisk sjukdom och dess svårighetsgrad/fas/samsjuklighet
- Reaktion på akuta livs händelser/separation/dödsfall/kränkning
- Självmoordsredskap finns tillgängligt
- Somatisk sjukdom
- Tidigare suicidförsök
- Tidigare eller aktuell aggressivitet, impulsivitet
- Utsatt för övergrepp/våldshandling
- Uttalat självskadebeteende
- Ålder (<19 eller >45)

Akut utlösande faktorer:

- Akut påverkad/abstinens eller nyligen tagit överdos
- Förlust/hot om förlust
- Kränkning/skam (självakttningsproblem)
- "Smittorisken" när det nyligen skett suicid i nära omgivning
- Svår fysisk smärta
- Sömnstörning
- Utskrivning från psykiatrisk vård
- Återgång i arbete/arbetslöshet
- Även inskrivning till psykiatrisk vård kan utlösa suicidhandling

Skyddande faktorer:

Personell resurs t.ex. god problemlösningsförmåga, god samtalskontakt
Nätverkets resurs, anhöriga, vänner, tillhörighet

- Onormal hjärtrytm R00.8

Förberedande åtgärder

- EKG

Röda symtom

- Pågående symtom och påverkat allmäntillstånd
- Illamående/blek/kallsvettig

Orange symtom

- Medvetandeförlust senaste dygnet
- Pågående symtom men opåverkat allmäntillstånd

Gula symtom

- Medfött hjärtfel/hjärtopererad

Gröna symtom

- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

RETTS processåtgärder**RETTS faktaruta**

Hos barn beror onormal hjärtrytm oftast på en återkopplings-takykardi, SVT (supraventrikulär takykardi), vilket kan komma intermittent.

Fråga aktivt efter tidigare hjärtrusning, hjärtoperation och medfödda hjärtfel.

ESS-Vägledning:

Prioritera EKG-tagning innan den onormala rytmen försvinner.

Allmäntillstånd:

BARN: Ett opåverkat barn 0-4 år öppnar ögonen spontant, är alert, orienterar efter ljud, jollar/svarar de ord han/hon kan och spädbarn skall ha sugintresse.

Ett opåverkat barn över 4 år öppnar ögonen spontant, hör sammar muntliga besked, är orienterat och pratar.

Ett barn som

- 1) inte uppfyller detta och som
 - 2) inte ter sig friskt
- har ett påverkat allmäntillstånd

- Blodig upphostning/hemoptys R04.2
- Näsblödning/epistaxis R04.4
- Postoperativ tonsillblödning R04.1

Röda symtom

- Pågående stor okontrollerad blödning från näsa/mun

Orange symtom

- Koagulationshämmande läkemedel eller blödningsbenägenhet
- Pågående medelstor näsblödning
- Svalgkirurgi senaste 14 dagarna

Gula symtom

- Intermittent färsk näsblödning

Gröna symtom

- Övriga med hemoptys
- Övriga med avstannad näsblödning
- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

RETTS processåtgärder

- Stora blödningar från mun utan känd svalgkirurgi, överväg ESS 108

RETTS faktaruta

Hemoptys (blodig hosta) kan förekomma vid lungsjukdom som embolier, lunginflammationer och lungblödningar. Hemoptys kan också komma från övre luftvägen vid intensiv hosta och är vanligare hos patienter med påverkad på koagulationssystemet.

Näsblödning brukar vara ett godartat symtom hos en i övrigt opåverkad patient men i vissa fall som efter svalgkirurgi kan även en intermittent blödning tyda på ett livshotande tillstånd.

Blödningsdefinition:

Liten blödning Mer saliv än blod

Medelstor blödning Mer blod än saliv

Stor blödning Blod rinner från näsa och/eller mun

- Andningsbesvär/dyspné/andnöd R06.0
- Andningsuppehåll/apné R06.8
- Bröstmärta vid andning R07.1
- Hyperventilation R06.4

Förberedande åtgärder

- Kontrollera KapÅ

Röda symtom

- Kraftigt andningspåverkad/andningsarbete
- Sepsis/meningitmisstanke
- Samtidig urticaria eller svullnad i ansiktet
- Stridor, feber och svårighet att svälja

Orange symtom

- Andningsuppehåll hos spädbarn
- Akut påkomna symtom/misstanke om främmande kropp
- Hjärtopererad senaste månaden
- Känd svår allergi
- KapÅ >2 sekunder
- Måttligt andningspåverkad
- Samtidig bröstmärta

Gula symtom

- Känd medfödd eller annan kronisk hjärt-lungsjukdom
- Lätt andningspåverkad

Gröna symtom

- Skällande hosta utan ökat andningsarbete
- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget behov av akutsjukvård

RETTS processåtgärder

- Misstanke om främmande kropp, se istället ESS 146
- Allergi, se även ESS 143
- Misstanke om misshandel, se även ESS 142

RETTS faktaruta**Epiglottit -se ESS 144**

Andningsuppehåll hos spädbarn är ett ospecifikt tecken som kan signalera allt från allvarliga infektioner/kramper till banala aspirationstillbud.

Andningsbesvär beror oftast på någon form av lungsjukdom. Det är viktigt att även beakta kardiella orsaker eller metabola som vid metabol acidosis (som vid diabetes).

Andningspåverkan kan vara en del i en chockbild utlöst som vid sepsis, anafylaxi, blödning eller dehydrering.

Det är viktigt att hålla barnet lugnt och låta barnet själv välja kroppsställning, reagerar barnet på syrgasmasken kan föräldern istället flöda syrgas över barnets näsa och mun.

Apné/andningsuppehåll kan hos de minsta barnen indikera sepsis.

Vissa hematologiska sjukdomar ger också ökad risk för tromboembolism, liksom vid graviditet, nyligen förlösta och hormonbehandlade patienter.

Kraftigt andningspåverkad: misstänkt övre luftvägshinder (dämpad röst, dreglar, sväljningssvårigheter, stridor och ökat andningsarbete), cyanos, uttalade indragningar, näsvingespel, grunting, takypné/bradypné, andningsuppehåll, oregelbunden andning, enstaka ord eller orkar ej prata, tyst och stillsam, likgiltigt gentemot förälder.

Måttligt andningspåverkad: ökad andningshjälp av bröstorg /axlar, förlängd expiration, stridor hos vaket barn med bevarad host- och kräkreflex, lätta-måttliga indragningar, takypné, talar i korta fraser.

Lätt andningspåverkad: dyspné, snabb andning, andfådd vid ansträngning, normalt andningsarbete, talar hela meningar, frekvent hosta. Dyspné är en subjektiv upplevelse av andningsbesvär

- Bröstsmärta/bröstkorgssmärta R07.4

Röda symtom

- Illamående/blek/kallsvettig
- Pågående bröstsmärta och påverkat allmäntillstånd

Orange symtom

- Hjärtopererad senaste månaden
- Pågående bröstsmärta med dyspné

Gula symtom

- Övriga med pågående bröstsmärta

Gröna symtom

- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

RETTS processåtgärder

- Samtidig dyspné, se även ESS 104
- Misshandel - misstanke om, se även ESS 142

RETTS faktaruta

Bröstsmärta är relativt vanligt hos ungdomar. Till skillnad från vuxna patienter är ischemi/infarkt extremt sällsynt, och därför är EKG förändringar också ovanliga.

Smärtan kan även vara orsakad av pneumoni, pleurit, pneumothorax, epigastralgi från buken eller vara muskeloskelettal. Kardiella orsaker är hjärtmuskel- och hjärtsäcks-inflammation (perimyokardit) eller snabba takykardier.

Bröstsmärta kan vara relaterat till aortastenosis, kardiomyopati och kranskärls-avvikelse även om dessa sällan debuterar akut hos barn. Efterhör hereditet för rytmrubbningar, plötslig död i tidiga år eller ärftliga hjärtsjukdomar.

ESS 105 är en av de få ESSer där smärtan används som ett verktyg i prioriteringen inom RETTS. Smärta graderas enligt lokalt verktyg för smärtskattning och skall användas för utvärdering på samma patient vid upprepade tillfällen.

Ingen smärta: - 0

Lätt smärta: 1-3

Måttlig smärta: 4-7

Svår smärta: 8-10

Dyspné är en subjektiv upplevelse av andningsbesvär

Allmäntillstånd:

BARN: Ett opåverkat barn 0-4 år öppnar ögonen spontant, är alert, orienterar efter ljud, jollar/svarar de ord han/hon kan och spädbarn skall ha sugintresse.

Ett opåverkat barn över 4 år öppnar ögonen spontant, hörsammar muntliga besked, är orienterat och pratar.

Ett barn som

1) inte uppfyller detta och som

2) inte ter sig friskt

- har ett påverkat allmäntillstånd

- Buksmärtor R10.4
- Flanksmärtor R10.4
- Magsmärtor R10.4
- Mag-tarmproblem A09
- Smärta/svullnad buk K42.0
- Smärta/svullnad lumske K40.9

Förberedande åtgärder

- P-glukos vid känd diabetes

Röda symtom

- Akut debut med pågående smärta och påverkat allmäntillstånd

Orange symtom

- All tidigare bukkirurgi
- Buksmärtor och påverkat allmäntillstånd
- Buksmärtor hos flicka/kvinna i pubertal ålder - plötslig debut, lågt sittande med intensiv konstant smärtpunkt
- Diabetes och P-glukos >12 mmol/L
- Icke reponibel resistens i lumsken
- Immunosupprimerad patient
- Intervallartad smärta flera ggr/tim hos barn <4år
- Spänd och ömmande buk
- Ökad törst och urinmängd senaste tiden
- Öm testikel

Gula symtom

- Buksmärtor med >2 kräkningar sista 4 timmarna
- Intervallartad buksmärtor flera ggr/tim hos barn >4år
- Reponibel resistens i lumsken
- Svår/måttlig smärta men opåverkat allmäntillstånd*

Gröna symtom

- Lätt smärta
- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

RETTS processåtgärder

- Buk/flanksmärta hos Gravid patient fr.o.m. v. 20+0 postpartum <30 dagar, se även ESS 121
- Förgiftning/intoxikation - misstanke om, se även ESS 140
- Högt blodsocker, se även ESS 149
- Känd diabetes, se även ESS 155
- Skada buk, se istället ESS 131
- Skrotal smärta, se istället ESS 117
- Gynekologiska besvär - vid misstanke om, se även ESS 121

RETTS faktaruta**Buksmärtor:**

Barn förlägger ofta smärtförmittelsen till magen även om den egentliga orsaken kan sitta på andra ställen t.ex. vid pneumoni.

Tänk på gastroenterit vid diarréer och kräkningar.

Diabetes mellitus kan debutera med buksmärtor som huvudsymtom. Det finns oftast anamnes på ökad törst och urinmängd senaste dagar-veckor.

Enbart kräkningar kan vara annan allvarlig sjukdom. U-sticka rekommenderas vid oklar symtombild.

Blindtarmsinflammation:

Är den vanligaste orsaken till buksmärtor hos barn som behöver åtgärdas kirurgiskt. Ovanlig diagnos innan 2 års ålder.

Intervallartade kraftiga buksmärtor bör föra tankarna till invagination, vilket är ett potentiellt allvarligt tillstånd och en diff. diagnos till den vanliga spädbarnskoliken.

Invagination är vanligast mellan 2 mån- 3 års ålder.

Förstoppning och körtelbuk är vanligt hos barn.

Testistorsion kan ha buksmärtor som enda symtom.

LÅGT SITTANDE BUKSMÄRTOR HOS FLICKA/KVINNA

Vid lågt sittande buksmärtor hos fertila kvinnor skall man alltid misstänka graviditet eller postpartum komplikation.

Graviditetstest rekommenderas. Vid graviditet över v 20+0 skall blodtrycket inte vara $\geq 160/110$ mmHg. Om så är fallet rekommenderas kontakt med obstetriker direkt.

Gravid patient, se även ESS 121. OBS Blodtryck samt medvetandegrad.

Ovarialtorsion:

Symtom som förekommer hos flickor/kvinnor är Buksmärtor med plötslig intensiv smärtdebut, lågt sittande med konstant smärtpunkt som ej avtar. Ej att förväxla med menstruationssmärtor. Ovarialtorsion leder till syrebrist i vävnaden (ischemi) och har genom sitt läge i buken en symptomatologi och förlopp som är svårare att både misstänka, bekräfta eller avfärda på ett säkert sätt. Vid låg buk/ryggsmärta skall alltid möjligheten till bakomliggande ovarialtorsion övervägas och uteslutas med både klinisk och fysikalisk undersökning.

Allmäntillstånd:

BARN: Ett opåverkat barn 0-4 år öppnar ögonen spontant, är alert, orienterar efter ljud, jollar/svarar de ord han/hon kan och spädbarn skall ha sugintresse.

Ett opåverkat barn över 4 år öppnar ögonen spontant, hör samman muntliga besked, är orienterat och pratar.

Ett barn med påverkat allmäntillstånd uppfyller in kriterierna ovan och ter sig inte friskt.

Smärta graderas enligt lokalt verktyg för smärtskattning (oftast VAS-skalan). Smärtvärdering skall användas på samma patient och inte jämföras mellan patienter.

Ingen smärta: 0

Lätt smärta: 1-3

Måttlig smärta: 4-7

Svår smärta: 8-10

- Blodig avföring/melena K92.1
- Diarré/lös avföring A09
- Symtom från anus och rektum/hemorroider K62.9

Förberedande åtgärder

- Kontroll av KapÅ

Röda symtom

- Pågående stor rektal blödning även mellan avföringar

Orange symtom

- Immunosupprimerad patient
- Intervallartad buksmärtor och blodig avföring
- KapÅ >2 sekunder
- Koagulationshämmande läkemedel eller blödningsbenägenhet samt pågående blödning
- Röd geléaktig avföring
- Svår törst

Gula symtom

- Svart avföring
- Övriga med rektal blödning

Gröna symtom

- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

RETTS processåtgärder

- Buksmärtor, se även ESS 106
- Vaginal blödning, istället ESS 121

RETTS faktaruta

Barn <2 år med stora diarrémängder riskerar hyperton dehydrering som bland annat visar sig genom svår törst (hög natriumhalt i blodet orsakas av vattenförluster).

Invagination ger kraftiga intermittenta buksmärtor och ibland röd geléaktig avföring.

Meckels divertikel i tunntarmen kan blöda kraftigt.

Blodiga diarréer kan orsakas av bakterien EHEC. EHEC kan i alla åldrar men ffa hos förskolebarn orsaka HUS (hemolytiskt uremiskt syndrom) och kan leda till allvarlig njurpåverkan med njursvikt.

Analfissur, exempelvis vid förstoppning, kan blöda.

Tarmallergier (vanligen mjölk), inflammatoriska tarmsjukdomar och gastroenterokolit kan ge blod i avföringen.

Spädbarn som ammar en sårig bröstvårta kan kräkas eller bajsas rött/svart blod.

Misstankar om sexuella övergrepp måste tas på allvar och dessa uppgifter ska i förekommande fall dokumenteras och framföras till undersökande läkare. Se ESS 142.

- Blodig kräkning/hematemes K92.0
- Illamående R11.9A
- Kräkning R11.9B

Förberedande åtgärder

- Kontroll av KapÅ

Röda symtom

- Sepsis/meningitmisstanke
- Pågående stor blodig kräkning/hematemes

Orange symtom

- Diabetes eller annan metabol sjukdom
- Huvudvärk
- Hydrocefalus/shunt
- Immunosupprimerad patient
- KapÅ >2 sekunder
- Koagulationshämmande läkemedel eller blödningsbenägenhet samt pågående blödning
- Svalgkirurgi senaste 14 dagarna
- Svår törst

Gula symtom**Gröna symtom**

- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning och bedömning inget omedebart behov av akutsjukvård

RETTS processåtgärder

- Buksmärta, se även ESS 106
- Kräkning/feber/frossa/diarré samt Addisons/indikation på binjurebarkssvikt/kortisolbrist se även ESS 151

RETTS faktaruta

Vid gastroenterit är det viktigt att bedöma graden av uttorkning (dehydrering). Hyperton dehydrering kan vara ett livshotande tillstånd. Hög misstanke - små barn med stora förluster!

Kräkningar med intermittenta kraftiga buksmärtor bör föra tankarna till invagination eller tunntarmshinder, särskilt vid gröna gallfärgade kräkningar. Vid pylorusstenos, vanligast vid 2-8v ålder, kan barnet ha matkräkningar även lång tid efter måltid.

Kräkningar hos spädbarn kan vara matöverskotts-kräkningar som hänger samman med en slapp övre magmun.

Kräkningar utan diarré bör i första hand ej klassas som gastroenterit. Tänk på ökat intrakraniellt tryck, metabol åkomma (t.ex. diabetes), intoxication och barnmisshandel (se ESS 142).

Sepsis/Meningitmisstanke symtomförklaring, se ESS 147

- Epilepsi, känd G40.9
- Frånvaroattack G40.3A
- Krämper R56.8
- Ryckningar hos spädbarn P90.9

Förberedande åtgärder

- Mät blodtryck på gravid patient

Röda symtom

- Sepsis/meningitmisstanke
- SBT ≥ 180 samt gravid
- DBT ≥ 120 samt gravid

Orange symtom

- Diabetes eller annan metabol sjukdom
- Huvudvärk
- Hydrocephalus/shunt
- Koagulationshämmande läkemedel eller blödningsbenägenhet
- Trauma mot huvudet
- Upprepade krämper senaste dygnet hos tidigare friskt barn
- Upprepade kräkningar senaste dygnet

Gula symtom

- Ökad krämfrekvens senaste dygnet hos barn med känd epilepsi
- Inget av ovanstående

Gröna symtom**Blåa symtom****RETTS processåtgärder**

- Förgiftning/intoxikation, se även ESS 140
- Vid graviditet, se även ESS 121

RETTS faktaruta

Sepsis/Meningitmisstanke symtomförklaring, se ESS 147.

Feberkrämper (generaliserad krämper kortare än 15 min) förekommer hos 2-5 % av barn mellan 6 månader och 5 år.

Vid svimning eller starka känsloutbrott förekommer ibland krämper hos vissa barn.

Vidare kan man tänka på möjligheten av cerebral infarkt/blödning. En överstående krämper hos ett väsentligen opåverkat barn kan däremot ofta handläggas som GUL.

Frånvaroattack kan hos de minsta barnen kan vara ett tecken på sepsis.

Status epilepticus innebär ett kontinuerligt epileptiskt anfall eller flera kortare, tätt återkommande, krämper utan full vakenhet mellan anfallen, som har pågått mer än 20-30 min.

Hypertoni - högt blodtryck - kan debutera under graviditeten (efter v 20) och kallas då graviditetshypertoni. Patienten kan också vara diagnostiserad innan graviditeten och har då en essentiell hypertoni.

Hos gravida skall blodtrycket observeras och monitoreras. Vid graviditet > V 20 och blodtryck $\geq 160/110$ mmHg skall preeklampsi misstänkas, ta blodtryck x flera. Kontakt med obstetriker rekommenderas.

Gravid patient med krämper, misstänk preeklampsi.

- Yrsel, balanssvårigheter R42

Förberedande åtgärder

- Kontroll av KapÅ

Röda symtom

- Koagulationshämmande läkemedel eller blödningsbenägenhet

Orange symtom

- Huvudvärk - Plötsligt påkommen
- Hydrocefalus/shunt
- KapÅ >2 sekunder
- Medvetandeförlust i samband med debut

Gula symtom

- Kräkningar

Gröna symtom

- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

RETTS processåtgärder

- Neurologiskt bortfall, se ESS 112
- Samtidig onormal hjärtrytm, se även ESS 101
- Samtidig skada huvud, se även ESS 130

RETTS faktaruta

Yrsel kan yttra sig som en känsla av ostadighet eller karusellkänsla.

I samband med infektioner kan påverkan på lillhjärnan ge balansrubbing (cerebellär ataxi).

Andra orsaker till yrsel:

Migrän, epilepsi, stroke, arytmier samt expansiva förändringar i bakre skallgropen.

Rotatorisk yrsel är ofta utlöst av mellanörats balanssystem vid sjukdomar såsom

- godartad lägesyrsel (yrsel vid lägesändring)
 - vestibularisneurit (plötslig debut, kontinuerlig)
 - labyrinthit (öronvärk)
 - Menière (hörselpåverkan, tryckkänsla och öronsus)
- och hos barn förekommer även attackvis yrsel.

- Facialispares G51.9
- Neurologiskt bortfall/symtom R29.8

Röda symtom

- Koagulationshämmande läkemedel eller blödningsbenägenhet
- Huvudvärk - Plötsligt påkommen
- Stroke - misstanke om

Orange symtom

- Feber >38.5°C senaste dygnet
- Hydrocephalus/shunt
- Kräkning/illamående/yrsel
- Trauma mot huvud, nacke eller rygg senaste månaden

Gula symtom

- Huvudvärk - långvarig

Gröna symtom

- Perifer facialispares utan andra symtom
- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

RETTS processåtgärder

- Skada huvud/nacke, se istället ESS 130
- Skada rygg, se istället ESS 131

RETTS faktaruta

Neurologiskt bortfall/symtom = nytillkommen nedsatt kraft, ändrad /avsaknad av känsel eller koordinationsrubbnig. Vanligast i extremiteter och ansikte. Viktigt att läkare vid strokemisstanke snarast gör bedömning om trombolyt/ trombektomi är aktuell. Så fort barnet är respiratoriskt och cirkulatoriskt stabilt skall datortomografi utföras. Åtgärder baseras på lokala rutiner och på PM

Riskbarn är de med hjärtsjukdom, onkologiska tillstånd, inflammatoriska sjukdomar i tarm eller vid systemsjukdomar eller hematologiska sjukdomar, nyligen genomgången varicella, trauma mot hals/nacke samt vid koagulationsdefekter.

Bortfall av motorisk funktion eller känsel kan, förutom efter stroke, exempelvis ses efter ett epilepsi- eller migränanfall (kortvarigt bortfall) och efter långvarigt tryck på stora nerver. Hjärntumör och borreliainfektion är orsaker som kan behöva uteslutas.

ESS-Vägledning

* Strokemisstanke vid symtom som:

- Akut hemipares
- Akut central facialispares
- Akut tal/språksvårighet
- Akut synfältsbortfall
- Akut yrsel i kombination med akut nytillkommet bortfallsymtom, ataxi eller ögonmuskelpares

Vid osäkerhet rådfråga doktor snarast!

**Perifer facialispares = förlamning/svaghet i ansiktet med svårigheter att stänga öga. (Vid central facialispares kan patienten stänga ögat.)

- Ledvärk utan trauma M25.5
- Hälta utan trauma R26.8

Röda symtom

- Sepsis/meningitmisstanke

Orange symtom

- Feber >38.5°C senaste dygnet samt svullen/öm led
- Immunosupprimerad patient

Gula symtom

- Inopererat material/protes i värkande led
- Kan ej stödja på extremitet
- Omöjligt att flektera/extendera
- Svår smärta

Gröna symtom

- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

RETTS processåtgärder

- Skada på ben/fot, se istället ESS 134
- Skada på hand/arm, se istället ESS 133

RETTS faktaruta

Sepsis/Meningitmisstanke symtomförklaring, se ESS 147.

Barn kan ha svårt att korrekt lokalisera smärta i nedre extremiteter så rygg-, höft- eller knäsmärta kan lätt misstolkas. Fråga om trauma. Ofarlig simplexcoxitis är den vanligaste orsaken till att barn utan föregående trauma inte vill stödja på benet. Dock måste alltid septisk artrit uteslutas. Vid septisk artrit är oftast en stor led inblandad. Patienten har feber och kraftig smärta/ömhets från den påverkade leden. Barn har särskilda sjukdomar (Perthes, femurepifysiolys) som drabbar höften och ger hälta.

Undersök pungen hos pojkar (testistorsion) vid hälta utan trauma.

Smärta graderas enligt lokalt verktyg för smärtskattning (oftast VAS-skalan). Smärtvärdering skall användas på samma patient och inte jämföras mellan patienter.

Ingen smärta: 0

Lätt smärta: 1-3

Måttlig smärta: 4-7

Svår smärta: 8-10

- Ryggsmärta utan trauma M54.9
- Smärta i brösttryggen utan trauma M54.6
- Smärta nacke utan trauma M54.2

Förberedande åtgärder

- I anamnes - hematologiska sjukdomar?

Röda symtom

- Sepsis/meningitmisstanke

Orange symtom

- Feber >38,5°C senaste dygnet
- Neurologiskt bortfall - nytillkommet
- Urinretention

Gula symtom

- Inget av ovanstående

Gröna symtom**Blåa symtom****RETTS processåtgärder**

- Blodsjukdom, se även ESS 148
- Kardiell genes - misstanke om, se även ESS 105
- Samtidig hematuri, se även ESS 116
- Samtidigt neurologiskt symtom, se även ESS 112
- Smärta flank, se även ESS 106

RETTS faktaruta

Sepsis/Meningitmisstanke symtomförklaring, se ESS 147.

Neurologiskt bortfall/symtom innebär ändrad eller avsaknad av känsel eller styrka i någon del av kroppen. Vanligaste ställen är extremiteter och ansikte.

Om det samtidigt förekommer infektionstecken såsom feber, frossa, sjukdomskänsla kan värken bero på exempelvis njurbäckeninflammation, pneumoni, bukåkomma, myelit, osteomyelit eller annan infektion.

Intraspinal tumör kan också ge ryggsmärta.

Ovarialtorsion:

Symtom som förekommer hos flickor/kvinnor är Buksmärta med plötslig intensiv smärtdebut, lågt sittande med konstant smärtpunkt som ej avtar. Ej att förväxla med menstruationssmärta. Ovarialtorsion leder till syrebrist i vävnaden (ischemi) och har genom sitt läge i buken en annan symtomatologi och förlopp som är svårare att både misstänka, bekräfta eller avfärda på ett säkert sätt. Vid låg buk/ryggsmärta skall alltid möjligheten till bakomliggande ovarialtorsion övervägas och uteslutas med både kliniks och fysikalisk undersökning.

- Extremitetsbesvär M79.6
- Smärta i extremitet M79.6
- Svullnad i extremitet R22.4
- Ödem R60.9

Förberedande åtgärder

- I anamnes - hematologiska sjukdomar?

Röda symtom**Orange symtom**

- Koagulationshämmande läkemedel eller blödningsbenägenhet samt pågående blödning
- Svår smärta i extremitet

Gula symtom

- Kan ej stödja på extremitet
- Känd njursjukdom
- Svullnad/konsistensökning

Gröna symtom

- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

RETTS processåtgärder

- Blodsjukdom, se även ESS 148
- Ledbesvär, se även ESS 113
- Lokal infektion, se istället ESS 147
- Samtidigt neurologiskt symtom, se även ESS 112
- Samtidig skada ben, se även ESS 134

RETTS faktaruta

Ödem förekommer vid nefrotiskt syndrom och debuterar med svullnad utan andra symtom.

Ödemet beror på proteinläckage via njurarna. I dessa fall ses proteinuri, dvs. $\geq 3+$ ($>2\text{g/l}$) på urinsticka.

Vid feber/frossa, svullnad och kraftig lokal smärta kan allvarlig lokal infektion föreligga, såsom vid nekrotiserande fasciit, vilket skall handläggas skyndsamt. Nekrotiserande fasciit utgör omedelbart livshot.

Smärta med svullnad kan också bero på kärltrombos, artäremboli eller ett kompartmentsyndrom.

Vissa hematologiska sjukdomar (exempel: sickelcellsanemi) ger också ökad risk för tromboembolism (blodpropp), liksom vid graviditet, nyligen förlösta och hormonbehandlade patienter. Vid sickelcellsanemi, tänk på vätska och smärtstillande. Vid smärta syns det inte alltid på AT hos dessa barn.

ESS-Vägledning:

Barn kan ha svårt att lokalisera smärtan till exakt rätt plats, tänk därför även på lederna (se ESS 113).

Smärta graderas enligt lokalt verktyg för smärtskattning (oftast VAS-skalan). Smärtvärdering skall användas på samma patient och inte jämföras mellan patienter.

Ingen smärta: 0

Lätt smärta: 1-3

Måttlig smärta: 4-7

Svår smärta: 8-10

- Blod i urin/hematuri R31
- KAD-relaterade problem Y84.6
- Smärta vid vattenkastning R30
- Urinretention R33
- Urinvägsproblem R39

Röda symtom**Orange symtom**

- Feber >38,5°C senaste dygnet
- Koagulationshämmande läkemedel eller blödningsbenägenhet
- Urinretention

Gula symtom

- Buksmärta
- Känd njursjukdom och ödem
- Makroskopisk hematuri

Gröna symtom

- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

RETTS processåtgärder

- Buksmärta, se även ESS 106

RETTS faktaruta

Hematuri (blod i urinen) är vanligt vid urinvägsinfektioner men förekommer också vid njursten, sjukdom i urinröret och efter trauma.

Samtidigt är det viktigt att inte missa pyelonefrit hos små barn som ibland kan yttra sig som oklar feber utan övriga symtom.

Stora urinvägsproblem=polyuri kan tyda på diabetes eller njursjukdom.

Vid miktionsvärde bör också könssjukdom beaktas

Vid nytillkommen sängvätning eller urinläckage bör diagnoser som diabetes och urinvägsinfektion övervägas.

Ibland ligger en förstoppning bakom urinläckage och UVI
Urinblåsans volym hos barn: $30 + (\text{åldern} \times 30) \text{ ml}$

Prehospitalt kriterie:

<Prehospitalt patientuppdrag med vårdinsats/bedömning på plats - ej omedelbart behov av ambulanstransport>

Vid vissa patientuppdrag framkommer det vid anamnes och undersökning uppgifter som leder till att patienten inom viss tid bör undersökas av läkare, men EJ har ett uppenbart behov av ambulanstransport till vårdinrättning. Bedömning görs från fall till fall och beslut om hänvisning fattas utifrån lokala riktlinjer och aktuell vårdgivares ansvar, inte utifrån RETTS Beslutstöd. Följ lokala processer och riktlinjer när- och i vilka specifika patientfall då grön prioritet kan väljas i ESS 116.

- Besvär i penis/urinrör N 48.9
- Skrotal smärta N44.9
- Skrotal svullnad N50.8

Röda symtom**Orange symtom**

- Icke reponibelt, smärtande ljumskbräck
- Misstanke om parafimosis
- Priapism
- Skrotal smärta
- Skrotal svullnad/ödem
- Smärta/svullnad penis med samtidig urinretention

Gula symtom

- Blödande penis
- Svullen rodnad förhud/penis
- Sårskada som behöver sutureras

Gröna symtom

- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

RETTS processåtgärder

- Skada buk/bäcken/könsorgan, se istället ESS 131

RETTS faktaruta

Allvarligaste orsakerna till smärta i underlivet hos pojkar är testistorsion och inklämt ljumskbräck. Testistorsion kan ha buksmärta som enda symptom.

Akut epididymit förekommer i alla åldrar men är ovanligt före puberteten. Sexuellt överförbar sjukdom förekommer hos ungdomar. Misstankar om sexuella övergrepp måste tas på allvar och dessa uppgifter ska i förekommande fall framföras till ansvarig läkare.

Torsion av Morgagnis hydatid (appendix testis) förekommer framför allt från 7 - 14 års ålder.

ESS-Vägledning:

Parafimosis innebär att relativt trång förhud dragits tillbaka och fastnat bakom ollonet.

Priapism innebär smärtsam långvarig erektion.

- Huvudvärk R51

Förberedande åtgärder

- Mät blodtryck på gravid patient

Röda symtom

- Sepsis/meningitmisstanke
- SBT ≥ 180 samt gravid
- DBT ≥ 120 samt gravid

Orange symtom

- Feber $>38.5^{\circ}\text{C}$ senaste dygnet
- Förvirring/beteendeförändring
- Hydrocephalus/shunt
- Kraftig huvudvärk med plötslig debut det senaste dygnet
- Krampanamnes
- Känd tumor cerebri
- Upprepade kräkningar senaste dygnet
- SBT ≥ 160 samt gravid
- DBT ≥ 110 samt gravid

Gula symtom

- Enstaka kräkning

Gröna symtom

- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

RETTS processåtgärder

- Smärta i nacken utan trauma, se istället ESS 114
- Samtidiga neurologiska symtom, se istället ESS 112
- Skada huvud/nacke, se istället ESS 130
- Gravid patient, se även ESS 121

RETTS faktaruta

Sepsis/Meningitmisstanke symtomförklaring, se ESS 147.

Kraftig huvudvärk med plötslig debut är ett kardinalsymtom vid subarachnoidalblödning och skall tas på största allvar.

Hos barn med huvudvärk som uppvisar avvikande beteende eller påverkat medvetande skall CNS-infektion misstänkas, särskilt vid feber.

Spänningshuvudvärk, migrän eller ömma halskörtlar är vanliga orsaker.

Hypertoni -högt blodtryck- hos gravid är ett observandum och kan vara ett tecken på preeklampsi. Hypertoni kan debutera under graviditeten (efter v 20+0) och kallas då graviditetshypertoni. Kvinnan kan också vara diagnostiserad innan hon blir gravid och har då en essentiell hypertoni. Hos gravida skall blodtrycket observeras och monitoreras.

- Medvetandeförlust R55
- Svimning/syncopé R55

Förberedande åtgärder

- Kontrollera KapÅ

Röda symtom

Orange symtom

- KapÅ >2 sekunder
- Medfött hjärtfel/hjärtopererad
- Medvetandeförlust vid fysisk ansträngning
- Upprepade medvetandeförluster

Gula symtom

- En medvetandeförlust

Gröna symtom

- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

RETTS processåtgärder

- Yrsel, se även ESS 111
- Gravid patient, se även ESS 121

RETTS faktaruta

Svimning föregås ofta av svaghet, yrsel och känslan av att försvinna bort. En klar majoritet orsakas av en vasovagal reaktion med blodtrycksfall vilket ger försämrad syresättning av hjärnan en kort stund. Detta kan utlösas i en lång rad situationer. Barn kan i samband med svimning få ett kort krampfall. Epileptisk kramp eller affektkramp (utlöses av starka känslor, upprördhet eller smärta) kan tolkas som svimning. Ortostatism med blodtrycksfall vid uppresning eller efter stillastående är inte ovanligt. Rent kardiellt orsakade svimningar är ovanligare men viktiga att upptäcka.

ESS-Vägledning: Svimning/synkope = medvetandeförlust

- Graviditet O20.9
- Gynekologiska besvär N92.6
- Postpartum < 30 dagar Z39.0
- Underlivsbesvär N92.6
- Vaginal blödning N93.9

Förberedande åtgärder

- Mät blodtryck på gravid patient

Röda symtom

- Plötslig debut med pågående smärta och påverkat allmäntillstånd
- Pågående förlossning
- SBT ≥ 180 samt gravid
- DBT ≥ 120 samt gravid

Orange symtom

- Feber $> 38,5^{\circ}\text{C}$ senaste dygnet
- Gravid och buksmärta
- Gravid och vaginalblödning
- Koagulationshämmande läkemedel eller blödningsbenägenhet samt pågående blödning
- Låg buksmärta av intervallkaraktär
- Mycket stor vaginal blödning utan påverkat allmäntillstånd
- Postpartum <30 dagar samt anamnes på feber
- SBT ≥ 160 samt gravid
- DBT ≥ 110 samt gravid

Gula symtom

- Stor vaginal blödning
- Sårskada som behöver sutureras

Gröna symtom

- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

RETTS processåtgärder

- Buksmärta, se även ESS 106
- Sexuella övergrepp - vid misstanke om, se även ESS 142

RETTS faktaruta

Rodnad eller irritation i underlivet kan hos barn bero på en bakterieinfektion.

Vid flytning kan även främmande kropp misstänkas.

Misstankar om sexuella övergrepp måste tas på allvar och dessa uppgifter ska i förekommande fall framföras till undersökande läkare.

Ovarialtorsion förekommer hos flickor/kvinnor och har ett liknande förlopp som testistorsion hos pojkar/män. Ovarialtorsion leder till syrebrist i vävnaden (ischemi) och har genom sitt läge i buken en annan symtomatologi och förlopp som är svårare att både misstänka, bekräfta eller avfärda på ett säkert sätt. Vid låg buk/ryggsmärta skall alltid möjligheten till bakomliggande ovarialtorsion övervägas och uteslutas med både klinisk och fysikalisk undersökning (vaginalt ULJ)

Allmäntillstånd:

BARN: Ett opåverkat barn 0-4 år öppnar ögonen spontant, är alert, orienterar efter ljud, jollar/svarar de ord han/hon kan och spädbarn skall ha sugintresse.

Ett opåverkat barn över 4 år öppnar ögonen spontant, hör sammar muntliga besked, är orienterat och pratar.

Ett barn som

1) inte uppfyller detta och som

2) inte ter sig friskt

- har ett påverkat allmäntillstånd

Blödning definieras;

- Mycket stor vaginal blödning; blödning eller koagler genom en normal binda på mindre än 30 min (utan tecken på att avta)
- Stor vaginal blödning; kraftigare än en riklig mens med eller utan koagler. Blöder genom en normal binda mellan 30 min och 2 timmar
- Riklig vaginal blödning: blöder genom en normal binda mellan 2 till 6 timmar
- Måttlig vaginal blödning: mindre blödning som blöder genom en normal binda på mer än 6 timmar (större blödning än tunna strimmor av blod)
- Sparsam vaginal blödning: tunna strimmor av blod/trosskydd

- Gulsot/ikterus R17

Förberedande åtgärder

- Kontroll av KapÅ

Röda symtom

- Sepsis/meningitmisstanke

Orange symtom

- KapÅ >2 sekunder

Gula symtom

- Feber >38.5.C

Gröna symtom

- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning och bedömning inget omedelbart behov av sjukvård

RETTS processåtgärder

- Samtidig buksmärta, se även ESS 106

RETTS faktaruta

Sepsis/Meningitmisstanke symtomförklaring, se ESS 147.

Gulsot är vanligt i nyföddhetsperioden och oftast helt normalt. Bilirubinnivån bör dock fastställas akut (utan vänta) på alla ikteriska barn under nyföddhetsperioden.

Gulsoten kan dock även bero på allvarliga sjukdomar som hemolys, gallvägsmissbildning, sepsis eller annan infektion.

Gulsot kan ses vid leversjukdom, störningar i gallflödet och vid ökat sönderfall av röda blodkroppar.

- Hängning/strykning Y20.99
- Käkskada S00.8
- Skada huvud/ansikte/näsa S09.9
- Skada nacke/hals S11.9
- Tandskada K03.8

Förberedande åtgärder

- Uteslut Traumalarmskriterier ESS 138

Röda symtom

- Ansikts/halsskada med hotad luftväg (se ESS 138)
- Misstänkt ryggmärgsskada (se ESS 138)
- Penetrerande våld mot hals, huvud (se ESS 138)
- Öppen skallskada/impressionsfraktur (se ESS 138)
- Hängningsförsök - symtom efter/misstanke om
- Koagulationshämmande läkemedel eller blödningsbenägenhet
- Neurologiska bortfall
- Pulserande blödning i/på halsen/på huvudet
- Strykningsförsök - symtom efter/misstanke om
- Svullnad hals/nacke - kraftig eller ökande
- Sväljningssvårigheter

Orange symtom

- Berusad/intoxikerad
- Blödning/vätska från hörselgång
- Fraktur skalle/skallbas/ansiktsskelett/nacke - misstanke om
- Huvudvärk/smärta i nacke - svår
- Luxation käkled - misstanke om
- Medvetslöshet >1 min i samband med skada
- Misshandel - misstanke om
- Påverkat mentalt status

Gula symtom

- ≥2 kräkningar
- Amnesi
- Djup/suturkrävande sårskada
- Hematom/blåaktig svullnad på ytteröra
- Huvudvärk/smärta i nacke - lätt till måttlig
- Hörselnedsättning - nyttillkommen i samband med skada

Gröna symtom

- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

RETTS processåtgärder

- ➔ Överväg traumalarm

- Berusad/misstanke om förgiftning se även ESS 140
- Traumalarmskriterier, se ESS 138
- Ögonskada, se även ESS 137

RETTS faktaruta

Kraftig svullnad i huvud-halsregionen kan allvarligt påverka andningsvägarna.

Tillse att patienten blir rengjord i och omkring sårområdet direkt efter första bedömning efter primärkontakt.

Vid skada mot huvud/hals är det viktigt att fråga efter om patienten äter koagulationshämmande läkemedel vilket kan ge ökad blödningsbenägenhet.

(Läs mer om ökad blödningsbenägenhet i "RETTS - Riktlinjer för bedömning av antitrombotiska läkemedel och blödningsbenägenhet". RETTS E-learning / Resurser / RETTS Manualer).

Pulserande blödning:

Misstänkt arteriell blödning i regionen.

Skador i/på ansikte kan ibland vara kombinerat med ögonskada och ansiktsfraktur.

Misstanke om sådan ger automatiskt högre prioritet till läkare (lägst orange).

Frakturer på skallen:

En skallfraktur räknas som infekterad (förorenad) om det finns en öppning genom den överliggande huden, samt när frakturen omfattar bihålorna eller mellanörat.

Hos barn under två år kan en stor mjuk bula på sidan av skallen tyda på en fraktur.

Öppna eller slutna frakturer på kraniet kan delas in i:

1) Linjära frakturer - längsgående frakturer på sidan av huvudet (vanligast förekommande) med risk för bristningar och sprickor i blodkärlen, den vanligaste orsaken till epiduralblödning.

2) Stämpelfraktur (impressionsfraktur) - skallen är intryckt - krossfraktur med multipla benfragment

3) Skallbasfraktur - "botten" av skallen.

Skallbasfrakturer kan skada blodkärlen, dessa medför också ofta skador på hjärnnerver och kan leda till hjärnhinneinflammation.

Symtom som kan vara förenat med skallbasfraktur:

- Blödning/vätska från hörselgång, på grund av trauma mot huvud.

- (Förväxla ej med vätska från hörselgången relaterat till skada mot inneröra i anamnes) - se även ESS 45 Öronproblem.

- Hematom bakom örat (Battles tecken).

- Hematom kring ögonen (Brillnhematom) kan vara förenat med skallbasfraktur.

- Hörselbortfall kan tyda på fraktur i hörselbenen, blod i mellanörat eller skada på hörselnerven.

- Bortfall av luktsinne och syn kan bero på skada på luktnerven och synnerven.

- Dubbelseende och nedsatt syn kan bero på skador på hjärnnerverna som går till ögonmusklerna, eller en fraktur på

skelettet i ögonbotten.

- Felställt bett/svårt att gapa.

Fraktur nacke:

Misstanke om fraktur på nackkotpelare med neurologisk påverkan ger medicinsk risknivå Röd.

Misstanke om fraktur på nackkotpelare utan neurologisk påverkan ger medicinsk risknivå Orange.

Skelettskada näsa:

Näsbensfraktur utan tecken på andra skador (isolerad) ger medicinsk risknivå Gul.

Luxation av käkled:

Kan förekomma efter trauma men också spontant i samband med käkrörelse. Käkluxation måste tas på allvar eftersom det i närheten finns både kärl och nerver som kan skadas. Konsultera vid behov ÖNH- konsult eller tandläkare.

Kraftig svullnad i huvud/halsregionen kan vara förenat med ökad risk för att andningsvägarna kan påverkas och kan medföra sväljningssvårigheter.

Motoriskt orolig patient skall vara ett observandum.

Med Berusad/intoxikerad menas när patienten har intagit alkohol /droger i sådan mängd där det är svårt att värdera den primära orsaken till patientens avvikande beteende.

Vid misstänkt commotio/hjärnskakning se lokala processåtgärder. Immobiliserad patient bör påses skyndsamt och enligt lokala rutiner.

Vid misstanke om misshandel ges ytterligare vägledning i ESS 142.

Immobilisering enligt lokala anvisningar.

Om pat är intoxikerad, medvetandepåverkad eller funktionshindrad på ett sådant sätt att patienten ej volontärt kan skydda en eventuellt skadad nacke så ska pat immobiliseras.

- Skada buk S39.9
- Skada könsorgan S30.2
- Skada thorax/rygg S29.9

Förberedande åtgärder

- Uteslut Traumalarmskriterier ESS 138

Röda symtom

- Instabil/deformerad bröstorg (se ESS 138)
- Misstänkt ryggmärgsskada (se ESS 138)
- Penetrerande våld mot bål (se ESS 138)
- Andningskorrelerad thorakal smärta samt blek/kallsvettig
- Avsaknad av ensidiga andningsljud - nyttillkommen vid skada
- Fraktur på rygg - med/utan neurologisk påverkan - misstanke om
- Halsvenstas
- Subcutana emfysem

Orange symtom

- Blödning rektal/vaginal - debut efter skada
- Buksmärta/bukomfång - tilltagande
- Fraktur på bröstorg (ej revben/nyckelben) - misstanke om
- Koagulationshämmande läkemedel eller blödningsbenägenhet
- Skada scrotum och kraftig smärta/ödem
- Sårskada - djup/sutureringskrävande
- Urinstämna/makroskopisk hematuri

Gula symtom

- Misshandel - misstanke om
- Skada underliv samt mindre yttre svullnad/blödning
- Trauma mot buk

Gröna symtom

- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

RETTS processåtgärder

- ➔ Överväg traumalarm

- Traumalarmskriterier, se ESS 138

RETTS faktaruta

Blödningar skall misstänkas och pneumothorax skall alltid uteslutas.

Tillse att patienten blir rengjord i och omkring sårområdet direkt efter första bedömning efter primärkontakt.

Vid stark andningskorrelerad bröstsmärta eller smärta vid palpation över bröstorg kan man misstänka fraktur.

Instabilt bäcken;

Misstanke; Instabilt bäcken kan misstänkas hos yngre patienter vid högenergitrauma, för äldre patienter räcker ibland ett fall från samma plan dvs lågenergitrauma. De sistnämnda ger dock sällan upphov till instabila bäckenringskador.

Symtom och tecken; Lokal smärta och deformitet, förkortad utåtroterad extremitet. Öppen blödning eller blod från urinrör, vagina eller rektum. Nedsatt cirkulation, känselstörning och/eller motorisk nedsättning.

Undersökning; Man bör inte stabilitetspröva bäckenet, eftersom det kliniska värdet av denna undersökning är tveksamt; undersökningen i sig kan också medföra okontrollerad blödning. Vid misstanke om misshandel ges ytterligare vägledning i ESS 142.

- Hematom/svullnad/blåmärke T14.0
- Skrubbsår T14.0B
- Skärsår T14.1
- Sårskada T14.1

Förberedande åtgärder

- Se ALLTID ÄVEN skadekort ESS 130-131 samt ESS 133-137
- Uteslut Traumalarmskriterier ESS 138

Röda symtom

- Skärskada - ymnig/pulserande blödning - ej kontrollerbar

Orange symtom

- Koagulationshämmande läkemedel eller blödningsbenägenhet samt pågående blödning

Gula symtom

- Skärskada på extremitet - yttlig med omfattande sår längd - ej pulserande (se även ESS 199)
- Sårskada på extremitet med lokala infektionssymtom (se även ESS 147)

Gröna symtom

- Hematom/bula/lindrig sårskada på huvudet - lätt/avstannad blödning
- Hematom/bula/sårskada i ansiktet - ymnig blödning - komprimerbar/kontrollerad
- Skadad nagel
- Sticka i finger/hand/fot - djupt sittande som kräver sjukvårdsinsats
- Skrubbsår på extremitet - smutsigt/kapillärblödning som kräver bedömning och rengöring

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av sjukvård

RETTS processåtgärder

- Brännskada, se istället ESS 135
- Självskadebeteende, se även ESS 199
- Skada huvud, se även ESS 130
- Skada buk, könsorgan, thorax/rygg, se istället ESS 131
- Traumalarmskriterier, se ESS 138
- Övrig sekundärinfektion, se även ESS 147

RETTS faktaruta

ESS 132 är ett symtomkort för sårskador i olika omfattning. Kortets syfte är att komplettera övriga skadekort med överlappning på vissa symtom/kriterier.

ESS 132 ersätter inte de skador/symtom som i första hand kan hanteras i skadekort ESS 130-131 och 133-138. Vårdaren behöver därför ALLTID först bedöma om skadans art istället kan triageras utifrån de skadekort.

Sårskador i mindre omfattning kräver inte alltid akutsjukvård och behandlas ofta lokalt med sterilisering och omplåstring på annan sjukvårdsinrättning och ibland prehospitalt. Lite större lokala sårskador avseende på längd eller djup kan kräva tejpnig, limning eller suturering och i de fallen behöver patienten därför komma till sjukvårdsinrättning som kan hantera detta.

Nekrotiserande faciit:

Tänk på att även små sår kan utvecklas till allvarlig infektion. Mindre sårskador med lokala infektionstecken såsom var-ansamling kan behöva tömmas, rengöras och omplåstras. En bedömning av risken för infektionsspridning skall alltid göras utifrån ESS 147.

- Skada axel/nyckelben S49.9
- Skada arm/handled S69.9
- Skada hand/finger S66.3

Förberedande åtgärder

- Uteslut Traumalarmskriterier ESS 138

Röda symtom

- ≥ 2 frakturer på långa rörben (se ESS 138)
- Penetrerande våld mot övre extremiteter ovan armbåge (se ESS 138)
- Amputation ovan hand (se ESS 138)
- Stor yttre blödning (se ESS 138)
- Amputation nedom handled exkl fingertoppar
- Fraktur/luxation samt pulslös perifert om skada
- Pulserande blödning

Orange symtom

- Distalstatus - nedsatt
- Fraktur/luxation exkl fingrar/nyckelben - felställning/öppen
- Koagulationshämmande läkemedel eller blödningsbenägenhet samt pågående blödning
- Smärta och tecken på kompartmentsyndrom

Gula symtom

- Amputation/delvis amputerad - fingertopp
- Blödning - kontrollerbar
- Fraktur/luxation i fingrar - felställning/öppen
- Fraktur i armbågsled/långa rörben/axelled - slutet/ej felställd - misstanke om
- Fraktur nyckelben - misstanke om
- Misshandel - misstanke om
- Sårskada - djup/sutureringskrävande

Gröna symtom

- Fraktur/luxation övrigt - misstänkta/konstaterade
- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

RETTS processåtgärder

- ➔ Överväg traumalarm

- Sekundärinfektion i/nära led, se även ESS 113
- Smärta/svullnad i extremitet utan trauma, se istället ESS 115
- Traumalarmskriterier, se ESS 138

RETTS faktaruta

Tillse att patienten blir rengjord i och omkring sårområdet direkt efter den första bedömningen efter primärkontakt.

Yngre barn kan vid drag i armen få subluxation/lux av radius i armbågen, pigluxation, och vill då inte använda den drabbade extremiteten. Fingeramputationer hos barn har bättre prognos vid reimplantation än vuxna. Bevara fingret väl!

Vid misstanke om misshandel ges ytterligare vägledning i ESS 142.

ESS-Vägledning

Kompartimenttecken där symptomen är ofta svår smärta, nedsatt muskelkraft, nedsatt känsel, nedsatt färg och temperatur samt smärta vid passiv rörelse. Observera att normala pulsationer inte utesluter kompartmentsyndrom!

Nedsatt distalstatus föreligger om pulsar och eller upplevd känsel är påverkade bortom skadan.

Med långa rörben menas humerus (överarm) eller femur (lår). ≥ 2 frakturer på långa rörben hanteras i ESS 138

- Skada fot/tå S99.9
- Skada höft/lårben/bäcken S79.9
- Skada knä/underben S89.9

Förberedande åtgärder

- Uteslut Traumalarmskriterier ESS 138

Röda symtom

- ≥ 2 frakturer på långa rörben (se ESS 138)
- Amputation - ovan fot (se ESS 138)
- Penetrerande våld mot nedre extremiteter ovan knä (se ESS 138)
- Stor yttre blödning (se ESS 138)
- Svår smärta i bäckenet/misstänkt bäckenfraktur (se ESS 138)
- Amputation - nedom fotled inkl stortå exkl övriga tår
- Fraktur/luxation samt pulslös perifert om skada
- Fraktur ovan knä - öppen/felställd
- Pulserande blödning

Orange symtom

- Distalstatus nedsatt
- Fraktur knä/nedom knä till ovan tår - öppen/felställd
- Fraktur ovan knä exkl bäcken - slutet/ej felställd - misstanke om
- Luxation ovan tår
- Koagulationshämmande läkemedel eller blödningsbenägenhet samt pågående blödning
- Smärta och tecken till kompartmentsyndrom

Gula symtom

- Amputation/delvis amputerad tå exkl stortå
- Blödning - kontrollerbar
- Fraktur knä/nedom knä - slutet/ej felställd - misstanke om
- Fraktur i tår - öppen
- Misshandel - misstanke om
- Sårskada - djup/sutureringskrävande

Gröna symtom

- Fraktur/luxation övrigt - misstänkta/konstaterade
- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

RETTS processåtgärder

Överväg traumalarm

- Sekundärinfektion i/nära led, se även ESS 113
- Smärta/svullnad i extremitet utan trauma, se istället ESS 115
- Traumalarmskriterier, se ESS 138

RETTS faktaruta

Tillse att patienten blir rengjord i och omkring sårområdet direkt efter första bedömning efter primärkontakt.

Kompartmentsyndrom uppstår när en muskel i benet svullnar så mycket att trycket påverkar muskler, blodflöde och nerver. Det kan även uppstå om ett gips är för trång och trycket på vävnaden därigenom blir för högt. Måste behandlas skyndsamt för att undvika bestående skador.

Tillståndet ger symtom som svår smärta, nedsatt muskelkraft, nedsatt känsel, nedsatt färg och temperatur samt smärta vid passiv rörelse. Observera att normala pulsationer inte utesluter kompartmentsyndrom!

Nedsatt distalstatus föreligger om pulsar och eller upplevd känsel är påverkade bortom skadan.

≥ 2 frakturer på långa rörben hanteras i ESS 138.

Långa rörben;

Humerus (överarm)

Femur (lårben)

Samtidig fraktur på både tibia och fibula (underbensbenen)

Vid misstanke om misshandel ges ytterligare vägledning i ESS 142.

- Blixtnedslag T75.0
- Brännskada T30.0
- Elolycka T75.4
- Frätskada T30.4
- Hypertermi/Värmeslag T67.0
- Hypotermi T68
- Inhalationsskada T59
- Kemisk skada T65
- Köldskada T35.7
- Strålskada T66.9
- Toxisk effekt av kolmonoxid T58.9

Förberedande åtgärder

- Uteslut Traumalarmskriterier ESS 138

Röda symtom

- Bränn-, frät- el. skållskada ansikte/hals
- Bränn-, frät- el. skållskada >5% barn <1 år
- Bränn-, frät- el. skållskada >10% barn >1 år
- Elolycka högsppänning
- Hypertermi i samband med yttre påverkan till överhettning/gravt värneslag med temp över 40,5 °C
- Hypotermi i samband med nedkylning med temp under 32 °C
- Inhalationsskador av rök inomhus eller kemisk produkt
- Kem/frätskador av potentiellt livshotande ämne
- Stridor
- Strålskada
- Svullnad i ansikte/tunga, svedda ansiktshår, sot i näsa/mun

Orange symtom

- Bränn-, frät- el. skållskada 1-5%, barn <1 år
- Bränn-, frät- el. skållskada 1-10% barn >1 år
- Hosta efter rökinalation
- Hypertermi i samband med yttre påverkan till överhettning /värmeutmattnng med temp upp till 40,5 °C
- Lindrig hypotermi i samband med nedkylning med temp 32-34,9 °C
- Lokal köldskada i svalg med - kraftig sväljsmärtasvårt att svälja saliv - efter inhalation av gaser/kemikalier

Gula symtom

- Blixtnedslag - i patientens omedelbara närhet
- Köldskada - lokal
- Misshandel - misstanke om

Gröna symtom

- Bränn-, frät- el. skållskada <1%
- Inget av ovanstående
- Övrig elolycka

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

RETTS processåtgärder

➔ Överväg traumalarm

EKG vid elolycka/högsppänning/blixtnedslag

- Traumalarmskriterier, se ESS 138

RETTS faktaruta

Bränn-, frät- el. skållskada ansikte/hals som ger Röd prio!!

- vid brännskada från öppen eld
- vid stor risk för inhalationsskada (som t.ex. brand inomhus eller sot i mun-näsa).
- om skållskada >1%.

Högsppänning:

Med högsppänning menas här allt >1000 V t.ex. kontaktledningar för tåg, högsppänningsledningar eller blixtnedslag.

Patienter som utsatts för vanlig hushållsel (230V) kan behöva uppföljning kring senkomplikation (nervskador etc). Att patienten suttit fast i strömkällan ökar risken för muskelskador - var lyhörd kring kvarvarande smärtor i delar som exponerats.

Symtomgivande strömgenomgång i hjärtat ger besvär omedelbart, antingen genom att det elektriska systemets slås ut (div arytmier/asystoli), eller genom brännskada i hjärtmuskeln. Detta sker inte med latens eller utan signifikanta symtom.

Oavsett volt och nuvarande symtom kan patienten behöva uppföljning kring senkomplikation (micronervskador etc), generellt planerat via primärvården.

Hypertermi:

Ett medicinsk tillstånd där kärnkroppstemperaturen stegras och blir onormalt hög och kan ge upphov till:

Värmevramp, värnesynkopé och värneslag.

Som sökorsak skall Hypertermi användas vid hög kärnkroppstemp som orsakats av att patienten till exempel har utsatts för yttre påverkan av extrem värme (bastu, bil, annan varm miljö) eller dehydrering samt andra medicinska orsaker på grund av sviktande temperaturreglering. Använd EJ denna sökorsak vid feber!

Vid feber med misstanke om infektion eller inflammation - se istället ESS 47

Värneslag indelas i:

- Värmeutmattnng p g a förlust av vatten och elektrolyter orsakad av värme men utan kraftig stegring av kroppskärntemperaturen (eng. "heat exhaustion") upp till 40,5 °C.
- Gravt värneslag: Akut livshotande tillstånd med centralnervös påverkan och skador på multipla organsystem till följd av en kroppstemperatur över 40,5 °C (eng. "heat stroke")

Hypotermi:

Innebär att kroppens kärntemperatur är < 35°C. Nedkylning, eller hypotermi, kan delas in i olika stadier;

- Lindrig hypotermi – Uppskattad kärntemperatur 35°C- 32°C.

Alert eller begynnande slöhet. Huttar. Takykardi. Svårigheter att ta hand om sig själv.

- Måttlig hypotermi – Uppskattad kärntemperatur 32°C - 28°C. Sänkt medvetandenivå, eventuellt hallucinationer. Bradykardi. Huttande avtar.

- Grav hypotermi – Uppskattad kärntemperatur <28°C . Medvetslös. Huttar inte. Långsam och svag puls som kan vara svår eller omöjlig att känna. Arytmier och evt. hjärtstopp.

Brännskador och Inhalationsskador:

Vid brännskador och rökinalation är det viktigt att kontrollera COHb i blodet. O2-saturation hos dessa patienter kan visa ett normalt värde trots att patienten har syrebrist. Symtom i samband med rökinalation som anses allvarliga kan vara CNS symtom (tidigare medvetandeförlust) eller svår hosta, dyspné. COHb i blodet bör kontrolleras om det varit en brand inomhus där patienten har vistas.

Barn är mer känsliga för vätskeförluster än vuxna och prioriteras högre. Vid tveksamhet välj högre prio.

Brännskada:

Brännskador från öppen eld ger djupare skador och behöver en snabbare handläggning.

Brännskadade patienter är oftast dehydrerade vilket kan ge cirkulationspåverkan.

Det som skall räknas in i utbredningen är ytliga och djupa dermala + fullhudsskador (tidigare grad 2 & 3).

Endast rodnad (ytlig brännskada) räknas inte till utbredningen.

För en mer exakt uträkning rekommenderas att använda patientens handflata eller detaljerade tabeller.

Handflatan+ fingrar motsvarar ca 1 % av kroppsytan hos både barn och vuxna.

Inhalationsskada vid användning av lustgaser mm.

Luftflödet vid Inhalation av lustgas direkt från gräddsifon kan vara väldigt kallt och orsaka lokala köldskador i munhåla och svalg. Köldskadorna kan ge upphov till svullnad runt larynx och potentiellt hota luftvägen. Symtom som kraftig smärta vid sväljning efter inhalation av lustgas bör därför alltid omhändertas brådskande för undersökning av larynx även om patienten inkommer flera timmar efter inhalationen.

Kemolycka:

Vid kemolyckor beakta risken för kontamination av personal och utrustning. Beslut om sanering sker prehospitalt.

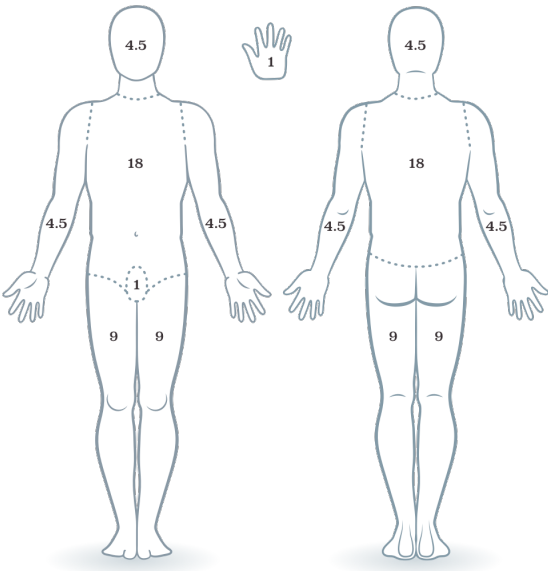
Strålskada:

Tag kontakt med lokal eller regional expertis.

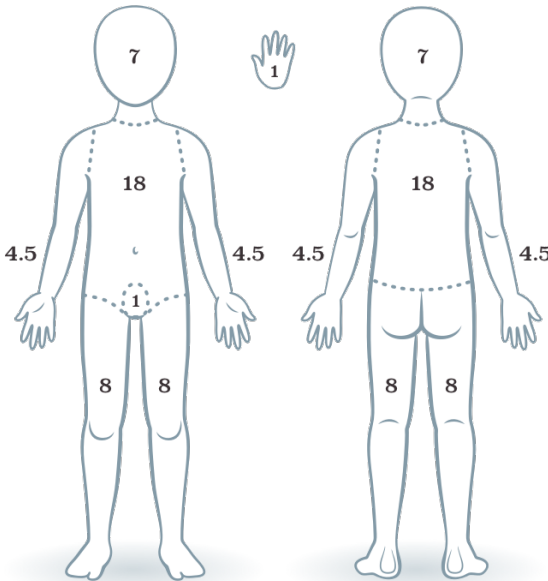
Misshandel:

Vid misstanke om misshandel ges ytterligare vägledning i ESS 142.

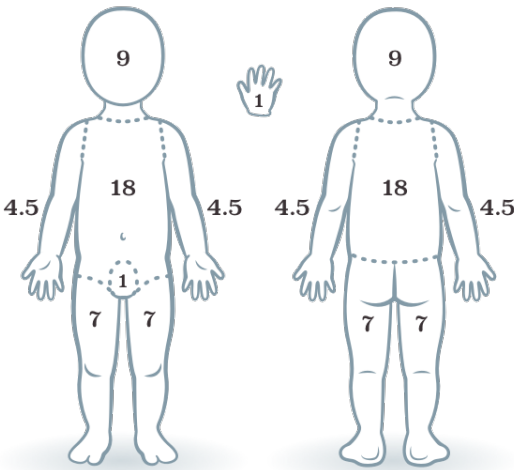
Giftinformationscentralen 010-456 67 19 och i brådskande fall 112 och begär Giftinformationscentralen, www.giftinfo.se



Vuxen



5 År



1 År

- Drunkning/drunkningstillbud T75.1
- Dykarsjuka/dekompressionssjukdom, misstanke om T70.3

Förberedande åtgärder

- Uteslut Traumalarmskriterier ESS 138

Röda symtom

- Aspiration och samtidig dyspné
- Kramp efter drunkningstillbud
- Patient har i samband med eller efter tillbudet varit medvetlös eller utan egen andning/cirkulation
- Temp. < 32 °C

Orange symtom

- Intoxikerad patient
- Aspiration av vatten - misstanke om
- Neurologiska bortfallssymtom
- Snabb uppstigning från dykning med komprimerad gas
- Temp 32 - 34,9°C
- Yrsel/ledvärk

Gula symtom

- Andningsrelaterad smärta/andfåddhet efter dyk med komprimerad gas
- Hudmarmorering/lymfödem
- Till synes somatiskt oskadad

Gröna symtom

- Klåda
- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

RETTS processåtgärder

➔ Överväg traumalarm

Vid drunkningstillbud/olycka är det viktigt att VP fastställs tidigt och upprepat. Kroppstemp? Utomhustemperatur? Venös blodgas viktigt på prioritet GUL och över.

Vid dykeriolycka viktigt att även samla information om antal dyk senaste veckan, gastyp som använts, dykdjup, dyktid och symptomförlopp. Vid dykeriolycka och röd eller orange triagering bör kontakt tas med tryckkammarjour, Östra sjukhuset Göteborg eller Karlskrona sjukhus, för råd och ställningstagande till tryckkammarbehandling.

Behandling med 100% syrgas bör alltid påbörjas vid dykeriolycksfall med röd-gul triagering.

- Intoxikation, se även ESS 140
- Traumalarmskriterier, se ESS 138

RETTS faktaruta

Drunkning är en diagnos men ofta handlar det om ett tillbud av olika karaktär där det varit en olycka av något slag, båt, simbassäng, badplats fall i vatten etc.

Cirka 120 personer drunknar varje år i Sverige.

Hypotermi är vanligt i samband med drunkning och ytterligare nedkylning ska motverkas. Hypotermi innebär att kroppens kärntemperatur är < 35°C. Nedkylning, eller hypotermi, kan delas in i olika stadier;

- Lindrig hypotermi – Uppskattad kärntemperatur 35°C- 32°C.

Alert eller begynnande slöhet. Huttrar. Takykardi. Svårigheter att ta hand om sig själv.

- Måttlig hypotermi – Uppskattad kärntemperatur 32°C - 28°C.

Sänkt medvetandenivå, eventuellt hallucinationer. Bradykardi. Huttrande avtar.

- Grav hypotermi – Uppskattad kärntemperatur <28°C .

Medvetlös. Huttrar inte. Långsam och svag puls som kan vara svår eller omöjlig att känna. Arytmier och evt. hjärtstopp.

Uteslut andra tillstånd/sjukdomar som behöver behandlas t.ex. trauma, alkohol/droger, hypoglykemi, hjärtinfarkt, stroke eller epilepsi.

Vid olycksfall under dykning med komprimerad gas kan dykarsjuka eller lungbristning uppstå. Samla info kring förlopp, djup och tider. Dykarsjuka kan ge ett/flera av: neurologiska symptom, ledsmärta, hudmarmoreringar, lymfödem eller klåda. Lungbristning kan ge neurologiska symtom, pneumothorax, subkutant emfysem, hosta och bröstsmärta.

Vid misstanke om dykarsjuka eller lungbristning bör behandling med 100% syrgas påbörjas. Neurologiska symtom och ledsymtom ska tryckkammarbehandlas och kontakt ska tas med tryckkammarjour på Östra sjukhuset i Göteborg eller Karlskrona sjukhus för fortsatt handläggning. Enheterna kan nås via SOS-alarm.

- Skada öga S05
- Ögonskada S05

Förberedande åtgärder

- Uteslut Traumalarmskriterier ESS 138

Röda symtom

- Penetrerande skada
- Utbuktande öga efter trauma

Orange symtom

- Frätskador, eller misstanke om
- Inskränkt ögonrörlighet/dubbelseende
- Skada med synnedsättning

Gula symtom

- Misshandel - misstanke om
- Skada som kan behöva sutureras
- Synlig blödning i främre kammaren efter skada
- Tårsekretion och smärta

Gröna symtom

- Främmande kropp - öga
- Övriga med spontan blödning i ögat
- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

RETTS processåtgärder

- ➔ Överväg traumalarm

- Icketraumatiska ögonproblem, se istället ESS 157
- Misshandel - vid misstanke om, se även ESS 142
- Synfälsbortfall, se istället ESS 112
- Traumalarmskriterier, se ESS 138

RETTS faktaruta

Barn som söker med akut ögonsymtom skall bedömas av ögonläkare primärt eller sekundärt. Om problemet uppenbart bedöms vara primärvårdskaraktär dokumenteras detta tydligt. Sårskador i huden skall primärsutureras inom 6 timmar från skadan. Tillse att patienten blir rengjord i och omkring sårområdet direkt efter den primära bedömningen.

Vid misstanke om misshandel ges ytterligare vägledning i ESS 142.

- Trauma Z91.6

Röda symtom

- N1.....Behov av ventilationsstöd
- N1.....Över 15 år; AF <10 eller >29/minut
- N1.....Under 15 år; Andningspåverkan
- N1.....Över 15 år; BT <90mmHg eller ej palpabel radialispuls
- N1.....Under 15 år; Kapillär återfyllnad > 2 sek
- N1.....0-1år; Puls < 90 eller >190
- N1.....1-5 år; Puls < 70 eller > 160
- N1.....RLS ≥ 3 eller GCS ≤ 13
- N1.....Penetrerande våld mot hals, huvud, bål, extremiteter ovan armbåge/knä
- N1.....Öppen skallskada/impressionsfraktur
- N1.....Ansikts/halsskada med hotad luftväg
- N1.....Instabil/deformerad bröstorg
- N1.....Svår smärta i bäckenet/misstänkt bäckenfraktur
- N1.....Misstänkt ryggmärgsskada
- N1..... ≥ 2 frakturer på långa rörben
- N1.....Amputation ovan hand/fot
- N1.....Stor yttre blödning
- N1.....Brännskada $\geq 18\%$ eller inhalationsskada
- N2.....Bilolycka >50km/h utan bälte
- N2.....Utkastad ur fordon
- N2.....Fastklämd med losstagningstid >20min
- N2.....MC-olycka (eller motsvarande) > 35 km/h
- N2.....Under 15 år: Påkörd/överkörd av motorfordon
- N2.....Över 15 år: Fall > 5 m
- N2.....Under 15 år: Fall > 3 m
- N2.....Ospecificerat trauma - bedömd som Nivå 2 i SAMRÅD MED LÄKARE eller LAS

Orange symtom

Gula symtom

Gröna symtom

Blåa symtom

RETTS faktaruta

Algoritm baseras på Nationella traumalarmskriterier.

Ett eller flera kriterier i RÖD ruta ger NIVÅ 1 larm eller NIVÅ 2 larm.

För tydlighet har ålder skrivits ut framför några symtom. Övriga symtom som inte hänvisar till en specifik ålder, gäller för samtliga patienter oavsett ålder.

Oavsett vilket/vilka kriterier som ger utfall gäller prehospital förvarning till AKM samt lokala riktlinjer för val av transportprioritet till sjukhus.

De patienter som saknar uppenbara eller misstänkta kriterier för RÖD prioritet måste hanteras i en annan ESS, ofta i spannet ESS 130-137.

Instabilt bäcken:

Kan misstänkas hos yngre patienter vid högenergitrauma, för äldre patienter räcker ibland ett fall från samma plan dvs lågenergitrauma. De sistnämnda ger dock sällan upphov till instabila bäckenringskador.

Symtom och tecken; Lokal smärta och deformitet, förkortad utåtroterad extremitet. Öppen blödning eller blod från urinrör, vagina eller rektum. Nedsatt cirkulation, känselstörning och/eller motorisk nedsättning.

Undersökning;

Man bör inte stabilitetspröva bäckenet, eftersom det kliniska värdet av denna undersökning är tveksamt; undersökningen i sig kan också medföra okontrollerad blödning.

Kortisolsvikt:

Patienter med kortisolsvikt / binjurebarksvikt är särskilt känsliga vid sjukdomstillstånd som feber, gastroenterit, hypovolemi etc. Deras normala försvar i form av aktivering av binjurebark är utslagen eller nedsatt.

Patienter med kortisolsvikt / binjurebarksvikt står ofta på substitution som i samband med sjukdom ofta justeras upp enligt ett schema som patienten sköter själv.

Detta kan ibland vara otillräckligt vilket gör att patienten behöver handläggas med hög prioritet eftersom tillståndet snabbt kan utvecklas till ett livshotande tillstånd med cirkulatorisk chock.

RETTS processåtgärder

➡ (N1) NIVÅ 1...AMK: Fullt traumateam.

➡ (N2) NIVÅ 2...AMK: Begr. traumateam.

➡ Beakta
OBSERVANDUM: se processåtgärder

➡ Beakta OSKYDDAD patient: Tillägg / förtydliganden, se processåtgärder

OBSERVANDUM

Om inga kriterier för traumalarm är uppfyllda, men ett eller flera observandum föreligger, ska detta föranleda kontakt med jourhavande läkare för att prioritera handläggning av patient, anpassa behov av larm eller korrigera larmnivå.

- Successiv försämring av misstänkt allvarligt skadad patient
- Ökad blödningsrisk (antikoagulantia)
- Ålder <5 år eller >60 år
- Allvarlig grundsjukdom
- Hypotermi <35°C
- Drogpåverkad (inkl även etylpåverkad)
- Gravid

TILLÄGG / FÖRTYDLIGANDEN

Nivå 2-larm utlöses om skademekanism talar för att patienten OSKYDDAD har utsatts för högenergetiskt våld, och det finns risk för svåra skador trots stabila vitalparametrar.

Exempel kan vara:

- Avkastad av häst i galopp
- Sparkad/trampad av häst i buk/thorax/huvud/bäcken
- Skidåkare/pulkaåkare/cyklist som i hög fart (över 35 km/h) kolliderat med fast föremål
- Kollisionsolyckor i hög fart (över 35 km/h) i skidbacke
- Olycka med vattenskoter eller vattenskidor
- Olycka med snöskoter/fyrhjuling

Rörelsebegränsad patient eller trafikolycka ska i sig, inte automatiskt utgöra skäl för att utlösa traumalarm.

Den slutliga traumanivåbedömningen - Nivå 1 och Nivå 2, sker på sjukhus för RÖD PRIORITET .

Ospecificerat trauma:

I RETTS ESS 38 finns kriteriet "N2.....Ospecificerat trauma - bedömd som Nivå 2 i SAMRÅD MED LÄKARE eller LAS".

Kriteriet kan användas vid misstanke om att patienten utsatts för trauma som inte matchar symtom/kriterier i ESS 38 eller i övriga skadekort 30-37. Val av det här kriteriet SKALL ALLTID ske i SAMRÅD MED LÄKARE eller med LAS (el. motsvarande befattning) vid Förvarning till akuten!

Patienten kan EJ erhålla orange, gul eller grön prioritet i ESS 138.

Om det efter undersökning konstateras att patienten inte är röd enligt ESS 138, skall annan lämplig ESS användas, ofta i spannet ESS 130-137.

- Förgiftning/intoxikation T65.9

Röda symtom

- Allvarlig intoxikation - misstanke om
- Intag av (känd/misstänkt) giftsvamp

Orange symtom

- Buksmärta
- Intag av okänd substans/mängd
- Intag av substans i suicidsyfte

Gula symtom**Gröna symtom**

- Intag av uppenbart ofarlig substans/mängd
- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

RETTS processåtgärder Ring Giftinfo Ring Giftinfo

- Suicidbedömning, se istället ESS 199
- Självskaдебeteende, se istället ESS 199

RETTS faktaruta

Förgiftningsolycksfall är vanliga bland småbarn. I regel är substansen känd medan dosen ofta är osäker. Feldosering av läkemedel förekommer.

I tonåren är förgiftningar ofta relaterade till självdestruktivt beteende.

Var uppmärksam för risken för blandintoxikation.

ESS-Vägledning

Giftinformationscentralen nås på tel 112 eller 010-456 67 19 eller www.giftinfo.se

Se Överdoserings i FASS.

Försök att få föräldrar att ange typ och tidpunkt samt fråga efter förpackningar.

Uppenbart ofarlig substans/mängd innebär att triagessk känner sig otvetydigt säker på det inte föreligger intoxikation. Vid minsta osäkerhet konsultera ansvarig läkare.

Vid misstanke om självskadebeteende se:

<http://bup.se/sv/Rad-och-fakta/Sjalvskada/>

Suicidriskbedömning och självskadebeteende se ESS 199 resp 198

- Bett av människa T14.1
- Bett och stick av djur T14.1
- Stickskada med smittorisk Y28.99
- Toxiska effekter av djur T63.9

Röda symtom

- Anafylaktisk reaktion
- Svullnad i andningsvägar/mun med påverkad andning, tal eller sväljförmåga

Orange symtom

- Bett av djur med potentiellt gift
- Bett/stick i svalg
- Misstanke om sekundärinfektion och feber $>38,5^{\circ}\text{C}$
- Tidigare allvarlig reaktion vid bett eller stick

Gula symtom

- Sårskada - djup

Gröna symtom

- Bett eller misstanke om bett av djur som är ogiftigt
- Reaktion av bett - kraftig lokal
- Stickskador med smittorisk
- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

RETTS processåtgärder

- Allergisk reaktion av djur, se även ESS 143
- Infektion, se istället ESS 147

RETTS faktaruta

Svullnad och rodnad runt ögat med feber kan tyda på ethmoidit.

Huggormsbett är farligare för barn än för vuxna pga. den relativt sett högre dosen.

Ormbett kan orsaka progredierande lokal svullnad men även allmänna symtom med kräkningar, buksmärter, blodtrycksfall och andningssvårigheter.

Nekrotiserande fasciit/myosit och SSSS (Staphylococcus Scalded Skin Syndrome) är livshotande hudinfektioner som ofta ger svåra smärter och ibland sepsis med cirkulatorisk påverkan.

ESS-Vägledning:

Anafylaktisk reaktion innebär en allvarlig allergisk reaktion, ofta med utslag/svullnad, som påverkar flera organsystem med andningssymptom och/eller cirkulationspåverkan. Patienten bör vara under noggrann tillsyn och status skall reevalueras ofta.

Allergiska reaktioners olika faser:

Initialfasen kommer inom ett par minuter till 1h efter kontakt med utlösande agens. Symtomen är ofta klåda i handflator, rodnad och hudsymptom samt klåda i halsen.

Progressfasen (anafylaktisk reaktion) ger mer generella symtom med urtikaria, angioödem, andningssvårigheter (bronkospasm, stridor), takykardi, buksmärter. Agitation/oro.

Chockfasen: Medvetandepåverkan, hypotension och cirkulationssvikt.

- Fysisk misshandel/misstanke om T74.9
- Sexuellt övergrepp/misstanke om Z04.4

Röda symtom**Orange symtom**

- Koagulationshämmande läkemedel eller blödningsbenägenhet samt pågående blödning
- Misshandel/övergrepp - inom senaste 2 dygnen - tecken på /misstanke om
- Pågående vaginal/rektal blödning
- Svår ångest

Gula symtom

- Emotionell labilitet
- Psykomotorisk oro/agitation
- Ångest/oro
- Inget av ovanstående

Gröna symtom**Blåa symtom****RETTS processåtgärder**

- Vaginal/Rektal blödning, se även ESS 131

RETTS faktaruta

All sjukvårdspersonal har lagstadgad skyldighet att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa, barnmisshandel /sexuella övergrepp. Överväg en polisanmälan i dialog med kollegor.

Kommunicera tydligt med dina arbetskamrater om din misstanke. Dokumentera berättelsen ordagrant. Jämför intryck och anamnes. Vid frakturer –prata med radiolog. Vid frågor kan barnbakjour kontaktas. Socialjouren finns att kontakt dygnet runt via 112 (dagtid via kommunens växel).

Handläggning:

Kläder som tas om hand får ej läggas i plastpåsar då DNA kan förstöras. För utförlig instruktioner se "spårsäkringskit" från polis och åklagare. Tänk på att inte tvätta bort eventuella spår då det kan omöjliggöra spårsäkringen och försvårar brottsutredningen. Spara även eventuell urin, avföring och kräkning.

Vid smärta använd specifik ESS/EESer för smärtans lokalisation och övriga symtom och tecken. Smärta skall behandlas och värderas men utgör inget som avgör prioriteten enligt RETTS.

En traumatisk händelse upplevs överväldigande och försätter patienten i ett tämligen hjälplöst tillstånd med rädsla, skräck, ångest, oro, nedstämdhet och beteendestörningar. Personen kan reagera med intensiv rädsla, hjälplöshet och skräck särskilt vid händelse som innebär död och allvarlig skada mot egen fysiska/psykiska integritet. En "normal akut stressreaktion" brukar avta inom 48 timmar. Ibland kan dock symtomen kan kvarstå längre än så.

I övrigt hanteras misshandel i den algoritm som gäller för den klassificerande skadans lokalisation och aktuella vitalparametrar.

Varningstecken:

Aggressiva föräldrar

Avvikande samspel barn/förälder

Diskrepans mellan anamnes och status

Frånvarande/deprimerat/distanslöst barn

Förälderfokus på sig själv/vill gå/vägrar undersökning

Minskad skuld eller oro hos förälder

Oklar anamnes

Skada orimlig för åldern (ex spädbarn kryper inte)

Söker sent i förhållande till skadetillfället

Upprepade skadetillfällen

Typiska skador:

Brännskador, t.ex. cigaretter

Extremitetsfrakturer

Förgiftning

Mönstrade hudskador

Revbensfrakturer (kotpelarnära)

Skador med olika ålder

Skallfrakturer

Skador på bukorganen

Riskbarn:

Arbetslöshet, missbruk

Ensamkommande flyktingbarn
"Failure to thrive"
Funktionshinder/kroniker
Oönskat barn
Prematur/tvilling
Små barn/spädbarn

Utifrån skadelokal t.ex., se ESS 130

Det förekommer att barn blir allvarligt misshandlade. Förövaren är oftast en förälder/styvförälder. Anamnes: Låt barnet själv prata, ev. utan föräldrar i rummet. Status: Klä av alla barn! (Undersök hudkostym när nakenvikt tas)
Dokumentera! Dokumentera berättelsen ordagrant och status inkl hud noggrant, ev. med hjälp av kamera.

- Allergi T78.4
- Exantem/hudutslag/blåmärke R21
- Klåda F45.8
- Läkemedelsreaktion T88.7

Röda symtom

- Anafylaktisk reaktion
- Svullnad i andningsvägar/mun med påverkad andning, tal eller sväljförmåga

Orange symtom

- Immunosupprimerad patient
- Svullnadskänsla i svalget
- Tidigare allvarlig reaktion av samma allergen

Gula symtom

- Övriga med svullnad i ansikte eller klåda hals

Gröna symtom

- Urtikaria
- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

RETTS processåtgärder

- Bett/stick utan allergisk reaktion, se istället ESS 141
- Blodsjukdom, se även ESS 148
- Sepsis/meningit misstanke, se även ESS 147
- Misshandel -vid misstanke om, se istället ESS 142

RETTS faktaruta

Överväg misshandel (se ESS 142) vid ex.v. blåmärken och hudförändringar som ej kan förklaras på ett trovärdigt sätt.

Anafylaktisk reaktion:

Anafylaktisk reaktion innebär en allvarlig allergisk reaktion, ofta med utslag/svullnad, som påverkar flera organsystem med andningssymptom och/eller cirkulationspåverkan. Initialfasen kommer inom ett par minuter till 1h efter kontakt med utlösande agens. Symptomen är ofta klåda i handflator, rodnad och hudsymtom samt klåda i halsen.

Progressfasen (anafylaktisk reaktion) ger mer generella symptom med urtikaria, angioödem, andningssvårigheter (bronkospasm, stridor), takykardi, buksmärter, agitation/oro. Chockfasen: Medvetandepåverkan och cirkulationssvikt

Urtikaria:

Urtikaria är stora sammanflytande kliande utslag som flyttar sig runt på kroppen – ofarligt om inga andra tecken på allergi /anafylaxi föreligger.

Petekier/purpura:

Petekier är små punktformiga blödningar i hud eller slemhinnor som inte bleknar vid tryck och som kan vara röda, lila eller brunaktiga beroende av ålder. Kan i samband med infektion vara ett mycket allvarligt tecken på snabbt progredierande sjukdom. Andra orsaker till petekier kan vara för kräkningar, virusbetingade, låga trombocytnivåer vid systemsjukdomar.

- Blåsor i munnen J06.9
- Förkylning/halsont J06.9
- Hosta R05.9

Röda symtom

- Sepsis/meningitmisstanke
- Stridor, feber och svårighet att svälja

Orange symtom

- Främmande kropp - akut påkomna symtom/misstanke om (ESS 146)
- Immunosupprimerad patient
- Uttalade sväljsvårigheter, dreglar /kraftig smärta vid sväljning

Gula symtom

- Halsont och grötigt tal
- Gapsvårigheter (trismus)

Gröna symtom

- Bihålebesvär
- Muntorsk
- Skällande hosta utan ökat andningsarbete
- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning och bedömning inget omedelbart behov av sjukvård

RETTS processåtgärder

- Andningsbesvär/dyspné, se även ESS 104
- Blodig hosta/näsblödning, se istället ESS 103
- Främmande kropp - misstanke om, se istället ESS 146

RETTS faktaruta

Vanligtvis är övre luftvägsbesvär orsakade av virus, vilket inte kräver annat än symtomlindrande behandling.

Krävs andningsarbete, se ESS 104.

Sepsis/Meningitmisstanke symtomförklaring, se ESS 147.

Faryngit/laryngit:

Halskatarr (Faryngit) är en diffus inflammation i slemhinnorna i bakre munnen, gomseglet, mandlarna och väggarna i svalget som är vanligare hos vuxna medan barn oftare får Krupp. Blir patienten hes eller förlorar rösten innebär det att inflammationen gått ner i svalget (laryngit).

Vanligast är virusinfektion. Viktigt är att utesluta epiglottit och stridor som oftast, men inte alltid, fångas med RETTS VP

Krupp (akut subglottisk laryngit, tidigare pseudokrupp/falsk krupp):

Orsakas oftast av virus och drabbar främst barn 6 mån–3 år.

Vanligaste symtomen hos barn:

- skällande hosta
- heshet och inspiratorisk stridor
- ofta värre på natten.

Viktigt att ta en noggrann anamnes från vårdnadshavare och utesluta främmande kropp.

Epiglottit:

Epiglottit (mycket sällsynt hos barn pga vaccination, men allvarligt)

Vanligaste symtomen:

- Stridor och andningssvårigheter hos febrigt, allmänpåverkat barn
- Svårigheter att svälja sin egen saliv, ofta med dregling
- Kraftig halssmärta och grötigt tal/röstförändringar
- Hög feber och framåtlutad kroppshållning för att underlätta andningen

Viktigt:

- Låt barnet sitta upp, peta ej i svalget.
- Vid sväljsvårigheter utan synliga fynd i munhålan bör larynx alltid bedömas av ÖNH-läkare.

Övriga orsaker till Larynxsvullnad är exempelvis trauma, inhalationer av droger, värme/kyla eller kemiska ämnen.

Körtelfeber (Mononukleos):

Orsakas vanligen av Epstein-Barr-virus och drabbar ofta unga vuxna.

Vanliga symtom:

- Hög, svängande feber
- Uttalad trötthet och nattliga svettningar
- Kraftigt svullna tonsiller med gråvita beläggningar
- Halsont, illaluktande andedräkt, grötigt tal
- Förstorade lymfkörtlar, särskilt på halsen

Peritonsillit:

Vanliga symtom/tecken:

- ensidig smärta/rodnad, svullnad och förhårdnad kring tonsill (kan förekomma dubbelsidig men är ovanligt)
- asymmetri i mun och svalg där mjuka gommen på ena sidan buktar ut och ofta förskjuter gomseglet (uvula) över medellinjen åt motsatt sida.
- gapsvärigheter (trismus)

Trismus är oförmåga eller svårighet att öppna munnen helt.

Orsakas av muskelspasm eller stelhet i tuggmuskulaturen, t.ex. vid:

- Infektioner (t.ex. halsböld, tandinfektioner)
- Trauma mot käke eller svalg
- Symtom/tecken:
- Ensidig rodnad, svullnad och förhårdnad kring tonsill
- Asymmetri i svalget eller underkäke/haka

Muntorsk (Oral candidos):

Svampinfektion i munhålan, ofta vid nedsatt immunförsvar eller efter antibiotikabehandling.

Vanliga symtom:

- Vita beläggningar på tunga, gom och insida av kinder
- Sveda, obehag vid sväljning

- Öronproblem H93.9
- Öronvärk H93.9

Röda symtom

- Sepsis/meningitmisstanke

Orange symtom

- Ensidigt utstående öra
- Immunosupprimerad patient
- Misshandel - misstanke om
- Rodnad och svullnad bakom örat (Mastoidit)
- Övre luftvägsinfektion med svullnad kring ett öga, ev feber (Ethmoidit)

Gula symtom

- Samtidig yrsel och/eller facialispares

Gröna symtom

- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

RETTS processåtgärder

- Blåaktig svullnad på öra, se istället ESS 130

RETTS faktaruta

Sepsis/Meningitmisstanke symtomförklaring, se ESS 147.

Vid mellanöreinflammation förekommer värk och feber. Ibland är denna bakteriellt orsakad.

Mastoidit är en potentiellt allvarlig spridning av infektion i mellanörat till skelettet (processus mastoideus). Ytterörat står ofta ut och det är ofta rött, svullet och palpationsömt bakom örat.

Inflammation i den yttre hörselgången ger klåda och värk. Ofta är besvären dock beroende på trumhinnekatarr eller förändrade tryckförhållanden i samband med förkylning.

Ethmoidit hos barn är en akut bakteriell sinuit i ethmoidalceller och är oftast ensidig. Tillståndet kräver akut handläggning för att undvika spridning till orbita och risk för blindhet. Sällsynt komplikation är septisk sinus cavernosus-trombos. Det kan vara svårt att initialt skilja ethmoiditer från mer ytliga inflammationer som t ex preseptal cellulit. Man måste i akutskedet därför se allvarligt på ensidig svullnad/rodnad öga i kombination med övre luftvägsinfektion, ev feber.

Ett allmänpåverkat barn med smärta från öron- och halsregion skall undersökas med tanke på meningit, mastoidit och sepsis. Detta gäller särskilt barn under 2år!

- Främmande kropp T17
- Främmande kropp i esofagus eller i magtarmkanalen T18.1
- Främmande kropp i luftväg T17.9
- Främmande kropp i näsa T17.1
- Främmande kropp i öra T16.9

Röda symtom

- Främmande kropp i luftväg/svalg med påverkad andning/tal
- Stridor

Orange symtom

- Immunosupprimerad patient
- Nedsvält knappcells batteri eller magneter
- Pågående hosta
- Svårigheter att svälja saliv

Gula symtom

- Främmande kropp som sitter kvar i näsan
- Sväljningssvårigheter men sväljer saliv

Gröna symtom

- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

RETTS processåtgärder

- Hemoptys eller blödning i halsregionen, se även ESS 103

RETTS faktaruta

Överväg "föräldrakysen" vid främmande kropp i näsan: förälder blåser genom barnets mun och täpper samtidigt till den fria näsborren.

De flesta föremål som sväljs passerar obehindrat genom magtarmkanalen. Föremål längre än 5 cm har större risk att fastna. Öppna säkerhetsnålar och trätandpetare behöver ofta extraheras, likaså föremål som suttit i matstrupen längre än 24h.

Knappcells batteri i öra kan orsaka skador om de lämnas kvar för länge.

Flera nedsvälta magneter kan häfta i varandra och orsaka tarmperforation.

Knappcells batteri och/eller magneter finns i leksaker och sväljs ibland av i huvudsak barn. Batteriet skapar en svag ström mellan - och + polerna vilket kan skada slemhinna och vävnad när magneterna/polerna dras mot varandra.

Det är viktigt att patient som svält knappcells batteri (typ litiumjon) handläggs utan dröjsmål på akutmottagning och att tid till röntgen för diagnostisering och vidare handläggning är så kort som möjligt.

Prehospital sjukvård och transport:

Överväg snabb transport till sjukhus utifrån förutsättningar och omständigheter, då det är viktigt att batteriet eller magneterna snabbt avlägsnas med gastroskopi för att förhindra esofagusskada eller skador i andra delar av gastrointestinalkanalen.

(Medicinsk risknivå: LÄGST Orange prioritet enligt ESS)

ÖNH besvär hanteras även ESS 144.

- Lokal infektion i hud (inkl böld/lymfadenit) L08.9
- Resistent svullnad/knöl på halsen R22.1
- Tandvärk/tandinfektion K08.9

Förberedande åtgärder

- Kontrollera KapÅ

Röda symtom

- Sepsis/meningitmisstanke

Orange symtom

- Diabetes eller annan metabol sjukdom
- Feber >38,5°C senaste dygnet
- Immunosupprimerad patient
- KapÅ >2 sekunder
- Kraftig svullnad samt tydlig rodnad från kind, underkäke ned på halsen
- Snabbt progredierande infektion med kraftig lokal smärta
- Svullnad och rodnad kring öga samt feber
- Upptäckt och hård munbotten samt sväljsvårigheter

Gula symtom

- Kraftig lokal infektion

Gröna symtom

- Inget av ovanstående

Blåa symtom**RETTS processåtgärder**

- Kräkning/feber samt Addisons/indikation på binjurebarkssvikt /kortisolbrist se även ESS 151
- Misstanke om infektion och ledengagemang, se istället ESS 113
- Operationskomplikationer, se istället ESS 172

RETTS faktaruta

Feber är ett vanligt symtom hos barn.

Ofta är orsaken virusinfektioner och kan och skall lämnas utan särskild åtgärd. Dock kan det i enbart feber dölja sig allvarliga orsaker som vid första bedömningen är mer eller mindre dolda.

Sepsis (blodförgiftning) är ett mycket allvarligt tillstånd. Hos små barn kan symtombilden vara mycket diffus med t.ex. enbart minskad matlust och trötthet.

Nekrotiserande fasciit/myositis och SSSS är livshotande hudinfektioner som ofta ger svåra smärtor och ibland sepsis med cirkulatorisk påverkan.

Svullnad och rodnad runt ögat med feber kan tyda på ethmoidit.

Tandinfektion kan spridas till omgivande mjukdelar vilket kan orsaka svullnad i munnen och potentiellt hota luftvägen. Tandinfektioner kan leda till svårigheter att gäpa, och bör även ses som en potentiell källa till sepsis.

Sepsis/Meningitmisstanke:

Misstänkt sepsis när barnet -

- Är sjukt från flera ställen

(ex. takypné OCH kräkning/diarré).

- Försämras snabbt eller inte förbättras som förväntat.

- Upplevs sjukare än förväntat (baserat på primärinfektionen).

Inget enskilt blodprov kan verifiera eller utesluta sepsis hos barn.

Förutsättning:

Barnet ter sig allvarligt sjukt (toxiskt)

Ofta ses även något av följande symtom:

- Feber - oftast men inte alltid

- Irritabilitet

- Sugslöhet/försämrad kontakt

- Perifert kall

- KapÅ > 2sek

- Äkta nackstelhet

- Petekier/purpura

OBS! Vid osäkerhet kontakta ansvarig läkare genast!

- Anemi D64.9
- Blodsjukdomar Z86.2

Förberedande åtgärder

- I anamnes - hematologiska sjukdomar?

Röda symtom

- Känd blodsjukdom med feber >38,5°C samt intensiv smärta i extremiteter/bröst/thorax/buken

Orange symtom

- Feber >38.5°C senaste dygnet
- Koagulationshämmande läkemedel eller blödningsbenägenhet samt pågående blödning
- Känd blodsjukdom samt intensiv smärta i extremiteter/bröst /thorax/buken
- Känd immunbrist

Gula symtom**Gröna symtom**

- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning och bedömning inget omedelbart behov av sjukvård

RETTS processåtgärder

- Blodig avföring, se även ESS 107
- Blodig kräkning, se även ESS 108
- Näsblödning/blodig hosta, se även ESS 103
- Vaginal blödning, se även ESS 121

RETTS faktaruta

Anemi kan uppkomma vid en lång rad olika tillstånd. Om den uppkommit snabbt till följd av inre eller yttre blödning bör det handläggas akut och då via en mer specifik ESS än 148.

Men ofta har anemin funnits en längre tid, cirkulationen har då hunnit anpassa sig och handläggningen blir inte lika akut. Om inte vitalparametrar säger annat kan patienten handläggas i lugn och ro.

De flesta patienter som söker på akutmottagningen med anemi som kontaktorsak kommer med en remiss från primärvård eller närsjukvårdsenhet eller liknande.

Anemi kan förorsakas av leukemi som också kan ge nedsatt immunförsvar.

Vissa hematologiska sjukdomar (exempel: sickelcellsanemi) ger också ökad risk för tromboembolism (blodpropp), liksom vid graviditet, nyligen förlösta och hormonbehandlade patienter. Vid sickelcellsanemi, tänk på vätska och smärtstillande. Vid smärta syns det inte alltid på AT hos dessa barn.

- Högst blodsocker/hyperglykemi R73.9

Förberedande åtgärder

- Blodgas - om möjligt
- B-ketoner mmol/L - om möjligt, se även ESS 155
- P-glukos mmol/L

Röda symtom

- Kussmaulandning och P-glukos >12 mmol/L

Orange symtom

- Acetondoft
- Anamnes på tidigare medvetandepåverkan
- Buksmärta och P-glukos >12 mmol/L
- Kräkningar
- P-glukos >15 mmol/L

Gula symtom

- Diarré
- P-glukos mellan 7-15 mmol/L
- Inget av ovanstående

Gröna symtom**Blåa symtom****RETTS processåtgärder**

- Lågt blodsocker/hypoglykemi, se istället ESS 150

RETTS faktaruta

Vid nydebuterad diabetes, eller hyperglykemi vid redan känd diabetes, är det mer bråttom att ta hand om en patient som hunnit utveckla ketoacidosis, än de utan ketoacidosis. Provtagning behövs för att fastställa eller avskriva ketoacidosis.

Hos patienter med nydebuterad diabetes och/eller samtidig ketoacidosis förekommer ofta buksmärta vilket ibland medför att patienten primärt sorteras till disciplinen kirurgi.

Venös blodgas med blodlaktat, är ett viktigt stöd i handläggningen.

Vid anamnes/kliniska tecken till överdosering av insulin /antidiabetika - ange alltid dos och tidpunkt.

Kussmaulandning:

Långsam, onormalt djup inandning följt av en kort och hastig utandning. Kan ses hos patienter med metabol acidosis, t.ex. diabeteskoma. Det är ett sätt för kroppen att bli av med protoner.

- Lågt blodsocker/hypoglykemi E16.2

Förberedande åtgärder

- P-glukos mmol/L

Röda symtom

- P-glukos <2,5 mmol/L

Orange symtom

- Glukagon givet i hemmet
- Insulinöversdosering; säker eller misstänkt
- P-glukos <3,5 mmol/L
- Svårigheter att hålla P-glukos normalt trots tillförsel av extra energi/socker
- Inget av ovanstående

Gula symtom**Gröna symtom****Blåa symtom****RETTS processåtgärder**

- Högt blodsocker/hyperglykemi, se istället ESS 149

RETTS faktaruta

Vid hypoglykemi ses initialt symtom såsom hunger, skakighet, kallsvett, blekhet och kräkningar. Centralnervös påverkan medför humörförändringar, dubbelseende, kramper och medvetslöshet. Hos patienter med diabetes beror hypoglykemi ofta på överdosering av insulin i förhållande till matintag. Nyfödda, som är känsliga för hypoglykemi, drabbas i huvudsak efter för tidig födsel eller vid intrauterin tillväxthämning eller "svält vid bröstet"=matbrist. Hypoglykemi hos små barn kan bero på nydebuterad metabol sjukdom som skall utredas och prover tas helst skall tas i akutskedet.

- Addisons sjukdom. TILLÄGGS-ALGORITM, barn skall även triageras utifrån sökorsak E27.1
- Binjurebarkssvikt, känd. TILLÄGGS-ALGORITM, barn skall även triageras utifrån sökorsak E27.4
- Kortisolbrist. TILLÄGGS-ALGORITM, barn skall även triageras utifrån sökorsak E23.0C

Förberedande åtgärder

- I anamnes: Pågående kortisonbehandling > 3 veckor med minst 5 mg Prednisolon dagligen (se faktaruta)

Röda symtom

- Ej tagit eller fått behålla ordinerad dos cortison
- Frossa / feber i anamnesen
- Kräkning / diarré

Orange symtom

- Infektionsanamnes men tagit cortison enligt ordination

Gula symtom

Gröna symtom

Blåa symtom

RETTS processåtgärder

- Metabola problem ESS 155

RETTS faktaruta

ESS 151 används vid misstanke om- eller vid känd kortisolbrist ex. primär binjurebarksvikt (Addisons sjukdom) och sekundär binjurebarksvikt – (Hypofyssvikt) eller pågående/varaktig kortisonbehandling.

Akut kortisolbrist, även känd som Addisonkris eller binjurekris, är ett livshotande tillstånd som inträffar när kroppen inte har tillräckligt med kortisol.

Patienter med kortisolbrist är särskilt känsliga vid sjukdomstillstånd som feber, gastroenterit, hypovolemi etc. Deras normala försvar i form av aktivering av binjurebark är utslagen eller nedsatt. Patienter med binjurebarksvikt eller hypofyssjukdom står ofta på kortisonsubstitution som i samband med akut sjukdom ofta justeras upp enligt ett schema som patienten sköter själv. Detta kan ibland vara otillräckligt vilket gör att patienten behöver handläggas med hög prioritet eftersom tillståndet snabbt kan utvecklas till ett livshotande tillstånd med cirkulatorisk chock.

Patienter utan primär/sekundär binjurebarkssjukdom men som av andra orsaker har kortisonbehandling >3 veckor med minst 5 mg prednisolon dagligen, har ökad risk för att utveckla sekundär binjurebarksvikt (kortisolbrist).

Beakta att kortisonbehandling är en form av immunosupprimerad behandling. I RETTS blir den här patienten lägst Orange.

Immunosupprimerad patient:

I samhället finns det allt fler patienter som av olika skäl har immunosupprimerad behandling. Viktigt är att man redan vid ankomst dokumenterar om det föreligger immunosuppression och vid behov vidtar de åtgärder som finns utarbetade på det sjukhus som patienten befinner sig på.

Står hen på cytostatika, cortison eller andra nyare immunosuppressions läkemedel - se även de ESS och symtom som patienten uppvisar.

- Gråtande barn R68.1
- Hälsoundersökning Z13.9
- Oklar sjukdom Z03.9
- Oroliga föräldrar
- Ospecifika symtom Z03.9
- Otillräcklig viktutveckling R63.4
- Otillräckligt vätskeintag R63.8
- Otillräckligt näringsintag R63.8
- PEG-relaterade problem Z93.1

Förberedande åtgärder

- Kontrollera KapÅ

Röda symtom

- Sepsis/meningitmisstanke

Orange symtom

- Avvikande beteende hos barnet
- KapÅ >2 sekunder
- Otröstligt barn
- Slappt barn (Floppy child)

Gula symtom

- Akut insättande sjukdom <12 timmar
- Avvikande beteende hos föräldrar
- Gråtande men tröstmått
- Ålder <6 månader

Gröna symtom

- Barn med otillräcklig viktutveckling
- PEG (gastrostomi) som lossnat eller riskerar att åka ut
- Önskan om hälsoundersökning
- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning och bedömning inget omedelbart behov av sjukvård

RETTS processåtgärder

➡ PEG (gastrostomi) som har åkt ut; Stoppa in störst möjlig KAD i hålet för att hålla det öppet

- Misstänkt misshandel/övergrepp, se även ESS 142
- Neurologiskt bortfall/symtom, se även ESS 112

RETTS faktaruta

ESS-Vägledning:

Denna ESS skall inte användas slentrianmässigt. Det finns potentiellt allvariga bakomliggande orsaker som psykiatriska, misshandel (se ESS-kort 142), sociala förhållanden, infektion, skador UNS (utan närmare specifikation), accidentella eller avsiktliga intoxikationer.

Sepsis/Meningitmisstanke symtomförklaring, se ESS 147.

Vanvård:

Vid misstanke om att barn far illa är sjukvårdspersonal skyldig att anmäla detta till socialtjänsten och i vissa fall polismyndigheten. Finns det misstanke om psykisk sjukdom hos vårdnadshavare?

Viktutveckling:

Dålig viktutveckling har många olika orsaker. Utan andra samtidiga symptom hos spädbarn är för lågt energiintag "svårt vid bröstet" en vanlig orsak. Andra viktiga differential diagnoser är hjärtproblematik och långdragna infektioner som urinvägsinfektion.

PEG (gastrostomi) som åkt ut bör snarast åtgärdas, då det perkutana ingångshålet snabbt försluts, vilket då kräver åtgärd med barnet i seding. Hålet kan vidmakthållas genom att en vanlig KAD förs in.

- Feber med oklart fokus R50.9

Förberedande åtgärder

- Kontrollera KapÅ

Röda symtom

- Sepsis/meningitmisstanke
- Diabetes eller annan metabol sjukdom

Orange symtom

- Immunosupprimerad patient
- KapÅ >2 sekunder

Gula symtom**Gröna symtom**

- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning och bedömning inget omedelbart behov av sjukvård

RETTS processåtgärder

- Addison, se även ESS 151
- Andningsbesvär, se istället ESS 104
- Öronproblem, se istället ESS 145
- Övre luftvägsinfektion, se istället ESS 144
- Urinvägsproblem, se istället ESS 116

RETTS faktaruta

Sepsis/Meningitmisstanke symtomförklaring, se ESS 147.

Feber är ett vanligt symtom hos barn.

Ofta är orsaken virusinfektioner och kan och skall lämnas utan särskild åtgärd. Dock kan det i enbart feber dölja sig allvarliga orsaker som vid första bedömningen är mer eller mindre dolda. Sepsis (blodförgiftning) är ett mycket allvarligt tillstånd. Hos små barn kan symtombilden vara mycket diffus med ibland enbart minskad matlust och trötthet.

- Diabetes, känd. TILLÄGGSALGORITM, barn skall även triageras utifrån sökorsak E10
- Metabola sjukdomar. TILLÄGGSALGORITM, barn skall även triageras utifrån sökorsak E10

Förberedande åtgärder

- Blodgas - om möjligt
- B-ketoner mmol/L - om möjligt
- P-glukos mmol/L

Röda symtom

- B-ketoner >2,5 mmol/L (DM)
- P-glukos <4,0 mmol/L
- Feber och metabola sjukdomar (se ESS-vägledning)
- Kräkningar samt metabola sjukdomar (se ESS-vägledning)

Orange symtom

- B-ketoner 1,0-2,5 mmol/L
- Metabola sjukdomar (se ESS-vägledning)

Gula symtom

Gröna symtom

- B-ketoner <1,0 mmol/L (DM)

Blåa symtom

- Efter undersökning och bedömning inget omedelbart behov av sjukvård

RETTS processåtgärder

- | | |
|--|--|
|  P-glukos minst 1 gång /timma. Får tas av förälder. |  P-glukos minst 1 gång /timma. Får tas av förälder. |
|  P-glukos minst 1 gång /timma. Får tas av förälder. |  P-glukos minst 1 gång /timma. Får tas av förälder. |

- Hyperglykemi/högt blodsocker, se även ESS 149
- Hypoglykemi/lågt blodsocker, se även ESS 150

RETTS faktaruta

ESS-VÄGLEDNING;

Metabola sjukdomar omfattar;

Betaoxidationsstörningar: MCAD, LCHAD, VLCAD, CPT.

Aminocidurier: MMA, PA, MSUD, Glutarsyruri, IVA.

Ureacykeldefekter: OTC, ASL.

Övrigt: GSD (glykogen storage disease, glycogenos), hyperinsulinemi, fruktos-1,6 bisfosfatasbrist, PDHD (pyruvate dehydrogenase deficiency), GLUT-1-brist.

Denna ESS är en tilläggs ESS för patienter som har diabetes /metabola sjukdomar men söker för andra symtom.

Oavsett vad en patient med diabetes söker för finns risk för störning i kroppens glukoshantering. T.ex genom magsjuka med dåligt energiintag, genom påfrestning pga feber/infektion, genom väntetider eller kirurgiska åkommor som innebär fasta m.m. Det är därför viktig med initial och regelbunden metabol kontroll på akutmottagningen för att upptäcka hypo- eller hyperglykemi.

En rad metabola sjukdomar kan vid sjukdom bli katabola och därmed triggas produktion av skadliga metaboliter och barnen kan fort bli väldigt sjuka.

Undantaget PDHD och GLUT-brist som står på ketogen kost, behöver övriga metabola tillstånd snabbt tillföras glukos intravenöst för att bryta nedbrytningen av kroppens egna fetter och aminosyror. Vid PDHD och GLUT-1 brist styr P-glukos behovet av glukos.

- Infektion öga H05.9
- Ögoninfektion H05.9
- Ögonproblem H57.9

Röda symtom**Orange symtom**

- Plötslig synnedsättning/förändring
- Svullnad samt rodnad runt ögat och feber

Gula symtom

- Svullnad vid mediala ögonvinkeln
- Tårsekretion och smärta

Gröna symtom

- Isolerad skelning
- Ögoninflammation
- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning inget omedelbart behov av akutsjukvård

RETTS processåtgärder

- Skada öga, se istället ESS 137
- Synfältsbortfall, se istället ESS 112

RETTS faktaruta

Barn som söker med akut ögonsymtom skall bedömas av ögonläkare primärt eller sekundärt. Om problemet uppenbart bedöms vara primärvårdskaraktär dokumenteras detta tydligt.

Vid misstanke om misshandel ges ytterligare vägledning i ESS 142.

Ethmoidit är en allvarlig infektion i bihålorna kring näsroten som ofta ger ensidig svullnad i mediala ögonvrån hos barn.

- Cirkulationsstillestånd I46.9

Röda symtom

- Pågående HLR
- ROSC

Orange symtom**Gula symtom****Gröna symtom****Blåa symtom**

- Patienten avliden. Återupplivning ej påbörjad/avslutad utan resultat

RETTS processåtgärder**RETTS faktaruta**

Vid hjärtstopp startas HLR regelmässigt. Om patienten återfår någon form av cirkulation (ROSC) är patienten fortfarande prioritet RÖD. Oavsett orsak till cirkulationsstillestånd eller resultat av återupplivningsförsök, kan denna ESS användas för registrering av patienten

Gäller patienter som påträffas med cirkulationsstillestånd, EJ patienter som under vårdtiden får cirkulationsstillestånd. Detta för att fortfarande kunna mäta mortaliteten i respektive ESS.

- Gipsproblem T98.3

Röda symtom

Orange symtom

- Ingen kapillär återfyllnad nedom skada/gips
- Kall extremitet
- Svår smärta i den gipsade extremiteten
- Symtom/tecken på kompartmentsyndrom

Gula symtom

- Lokal infektion
- Måttlig smärta i den gipsade extremiteten

Gröna symtom

- Trasigt gips
- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning och bedömning inget omedelbart behov av sjukvård

RETTS processåtgärder

RETTS faktaruta

Gipsproblem:

Fråga efter anamnes på skadan, åtgärd + tidsförloppet, hur länge har gipset suttit? Finns det genomförd kirurgi före gipsning? Om, ja så skall komplikation med postoperativ infektion uteslutas. Allmänna infektionstecken, B-laktat, venös blodgas.

Gips som sitter fel kan både orsaka obehag och skador. Om patienten klagar på smärta eller obehag skall det alltid tas på allvar. Tilltagande smärtor får inte nonchaleras utan noggrann undersökning.

Normalt sker inte prioritering utifrån smärtupplevelsen i RETTS med undantaget i denna ESS. Se VAS skala nedan.

Komplikationer kan utvecklas på kort tid. Ibland finns det anledning att avlägsna gipset men då skall läkare kontaktas först och det görs på ordination eller delegering enligt lokal processåtgärd. Komplikationer är i första hand tryckskador och sårbildning, kärlskador eller nervskador.. Extra vaksamhet kan behövas på barn med funktionshinder.

Om tecken på cirkulationsstörning finns, skall gipset avlägsnas omedelbart.

Om patienten endast har svullnad eller hematom kan det ibland vara normaltillstånd efter skadan. Dessutom kan instabila frakturer komma ur läge om gipset avlägsnas varför patienter med reponerade frakturer som princip bör läkarbedömas före avgipsning.

Kompartmentsyndrom:

Ett tillstånd där trycket inuti muskulaturen stiger till den punkt att det hämmar blodflödet, vilket leder till syrebrist (ischemi). Återställs inte blodförsörjning i extremiteten skyndsamt, kan tillståndet inom några timmar leda till permanent och svår muskelskada, nekros och vävnadsdöd. Observera att normala pulsationer inte utesluter kompartmentsyndrom.

Symtom/tecken på kompartmentsyndrom:

- Svår smärta i extremitet även vid passiv rörelse
- Distal känselnedsättning
- Nedsatt muskelkraft, muskelsvaghet intill pares
- Lokal ömhet
- Nedsatt färg och temperatur

Exempel orsaker till kompartmentsyndrom:

- Trånga förband (gips)
- Operativa ingrepp
- Inflammation
- Brännskada eller trauma.

Prioritet vid kompartmentsyndrom:

Kompartmentsyndrom är ett tidskritiskt tillstånd och tidsfaktorn är särskilt avgörande. I RETTS prioriteras den här patienten lägst ORANGE.

Överväg därför att prioritera upp till RÖD utifrån kliniska fynd och omständigheter I DE FALL DÅ TIDEN TILL BEHANDLING

bedöms påverka patientens tillstånd negativt.

Smärta graderas enligt lokalt verktyg för smärtskattning (oftast VAS-skalan). Smärtvärdering skall användas på samma patient och inte jämföras mellan patienter.

Ingen smärta: 0

Lätt smärta: 1-3

Måttlig smärta: 4-7

Svår smärta: 8-10

- Operationskomplikation T98.3

Röda symtom

- Nyopererat öga, med plötslig svår värk och synnedsättning (endoftalmit)
- Pulserande blödning
- Sepsis/meningitmisstanke

Orange symtom

- Immunosupprimerad patient
- Inopererat material
- Måttlig smärta och infektionstecken
- Svår smärta i operationsområdet
- Symtom/tecken på kompartmentsyndrom
- Sårruptur på bålen

Gula symtom

- Feber >38,5 C
- Måttlig smärta utan infektionstecken

Gröna symtom

- Inget av ovanstående

Blåa symtom

- Efter undersökning och bedömning inget omedelbart behov av sjukvård

RETTS processåtgärder

RETTS faktaruta

Operationskomplikationer kan vara lokala komplikationer som vid sårruptur, infektion eller blödning. Det kan även röra sig om mer generella komplikationer som djup ventrombos, urinvägsinfektion, pneumoni, sepsis men de handläggs bäst i kombination med annan algoritm. Om det finns förband eller gips som täcker ett operationsområde bör det alltid avlägsnas vid misstanke om komplikation (se också ESS 171).

Sepsis/Meningitmisstanke symtomförklaring, se ESS 147.

Kompartmentsyndrom:

Ett tillstånd där trycket inuti muskulaturen stiger till den punkt att det hämmar blodflödet, vilket leder till syrebrist (ischemi). Återställs inte blodförsörjning i extremiteten skyndsamt, kan tillståndet inom några timmar leda till permanent och svår muskelskada, nekros och vävnadsdöd. Observera att normala pulsationer inte utesluter kompartmentsyndrom.

Symtom/tecken på kompartmentsyndrom:

- Svår smärta i extremitet även vid passiv rörelse
- Distal känselnedsättning
- Nedsatt muskelkraft, muskelsvaghet intill pares
- Lokal ömhet
- Nedsatt färg och temperatur

Exempel orsaker till kompartmentsyndrom:

- Trånga förband (gips)
- Operativa ingrepp
- Inflammation
- Brännskada eller trauma.

Prioritet vid kompartmentsyndrom:

Kompartmentsyndrom är ett tidskritiskt tillstånd och tidsfaktorn är särskilt avgörande. I RETTS prioriteras den här patienten lägst ORANGE.

Överväg därför att prioritera upp till RÖD utifrån kliniska fynd och omständigheter I DE FALL DÅ TIDEN TILL BEHANDLING bedöms påverka patientens tillstånd negativt.

Smärta graderas enligt lokalt verktyg för smärtskattning (oftast VAS-skalan). Smärtvärdering skall användas på samma patient och inte jämföras mellan patienter.

Ingen smärta: 0

Lätt smärta: 1-3

Måttlig smärta: 4-7

Svår smärta: 8-10

Patienter som nyligen har genomgått en operation på halsen kan snabbt utveckla kompression av luftstrupen med en efterföljande ofri luftväg.

Lokal infektion kan ses som rodnad, svullnad, smärta och ibland med var.

- Depressiv episod R32.9
- Nedstämdhet F92.0

Förberedande åtgärder

- Farlighetsbedömning och suicidriskbedömning
- Alkometer och/eller U-tox vid misstanke om drogpåverkan - om möjligt

Röda symtom

Orange symtom

- Aktuell allvarlig suicidhandling
- Berusad/intoxikerad
- Uttalade suicidala planer eller avsikter i anslutning till söktillfället

Gula symtom

- Nyligen utförd suicidhandling
- Psykomotorisk oro (oroligt beteende, rastlöshet)
- Pågående affektlabilitet
- Påtaglig hämning (emotionellt, motoriskt, kognitivt)
- Social isolering
- Uttalade suicidtankar

Gröna symtom

- Anhedoni (svårigheter att känna glädje, lust, intresse)
- Asteni (trötthet/uttröttbarhet, irritabilitet)
- Dödstankar
- Dödsönskan
- Förändrad aptit (viktuppgång/viktnerdgång)
- Nedsatt koncentration
- Tendens till isolering
- Tidigare suicidförsök

Blåa symtom

RETTS processåtgärder



Sökande skall läkarbedömas.



Om sökande är ensam ring in vårdnadshavare. Sökande skall ej placeras ensam innan vårdnadshavare anlät.



Sökande skall läkarbedömas.



Om sökande är ensam ring in vårdnadshavare. Sökande bör ej placeras ensam innan vårdnadshavare anlät



Om sökande är ensam ring in vårdnadshavare. Sökande bör ej lämnas ensam innan vårdnadshavare anlät



Sökande kan efter sjuksköterskebedömning samt konsultation med jourhavande läkare återgå till hemmet med en planering kring rekommenderad fortsatt vårdkontakt.

Överväg Alkometer, U-tox, AUDIT, DUDIT samt MADRS-S

- Farlighetsbedömning, se även ESS 198
- Suicidriskbedömning, se även ESS 199

RETTS faktaruta

Överväg alltid om det kan finnas bakomliggande somatisk orsak.

Använd somatisk ESS i kombination vid somatiska symtom.

Nedstämdhet är en vanlig orsak till kontakt med BUP. Symtom under större delen av tiden under minst 2 veckor tillsammans med en nedsatt funktionsnivå talar för en kliniskt signifikant depression. Minskad lust och glädje samt minskat intresse är vanligt. Ångest, skuldkänslor, värdelöshetskänslor, koncentrationssvårigheter, ambivalens, irritabilitet, energilöshet och sömnproblem hör också ofta till bilden. Sömnproblem kan förutom sömnbrist och insomningssvårigheter även innebära att patienten behöver mer sömn än vanligt. Både aptitlöshet och en ökad aptit kan ingå i bilden. Tonåringar med depression kan vara sura, lättkränkta, kritikkänsliga, "bråkiga" och/eller ha stora känslösvängningar. Patienter med melankoliska symtom (uttalad hämning, sömnproblem, skuldkänslor, svår ångest, viktnerdgång, likgiltighet, hopplöshet) ska prioriteras p g a att de symtomen ger en högre suicidrisk. Även samsjuklighet med missbruk ökar suicidrisken, liksom tidigare suicidförsök, ev. bipolär sjukdom eller underliggande psykosjukdom, varför detta är viktigt att fastställa. Suicidriskbedömning ska genomföras på alla patienter.

- Hypomani F30.0
- Mani F30.9

Förberedande åtgärder

- Farlighetsbedömning och suicidriskbedömning

Röda symtom**Orange symtom**

- Attackerar föremål
- Blandtillstånd (samtidig hypomani/mani och depression)
- Fysiskt hotfullt beteende
- Snabbt växlande humör
- Verbalt hotfullt beteende

Gula symtom

- Bristande emotionell kontakt
- Bullrigt beteende
- Desorientering
- Gränslöshet
- Riskfyllt beteende
- Psykomotorisk oro (oroligt beteende, rastlöshet)
- Pågående affektlabilitet
- Retlig/lättirriterat beteende
- Snabbt tankeförlopp, kraftigt ökat talflöde (icke avledbart tal)

Gröna symtom

- Lätt distraherbar
- Minskat sömnbehov
- Ökad energi, upprymdhet
- Ökad impulsivitet
- Ökad social interaktion
- Ökat talflöde

Blåa symtom

- Farlighetsbedömning, se även ESS 198
- Förgiftning, se även ESS 140
- Suicidriskbedömning, se även ESS 199

RETTS faktaruta

Överväg alltid om det kan finnas bakomliggande somatisk orsak.

Använd somatisk ESS i kombination vid somatiska symtom.

Vid mani/hypomani är grundstämningen övervägande förhöjd med euforisk eller expansiv sinnesstämning, alternativt påtaglig irritabilitet. Patienten har förhöjd energi- och aktivitetsnivå med ökat självförtroende eller grandiositet. Blandtillstånd, dvs samtidig depressivitet, är dock inte ovanligt.

Patienten kan uppvisa rastlöshet, uppvarvning, irritabilitet, aggressivitet, kraftiga humörsvägningar, ångest, snabbt tankeförlopp, ökat talflöde, distraherbarhet och koncentrationssvårigheter. Vid mani är sjukdomsbilden mer uttalad, ofta saknas sjukdomsinsikt och psykotiska symtom är vanligt, liksom ökad impulsivitet, högre desorganisation, gränslöshet och sänkt omdöme. Utöver periodiciteten i symtombilden är minskat sömnbehov och hypersexualitet två symtom som är syndromspecifika för mani/hypomani.

Samtidigt missbruk/abstinens måste uteslutas.

Blandtillstånd har högre suicidrisk.

RETTS processåtgärder

➡ Om sökande är ensam ring in vårdnadshavare. Sökande skall ej placeras ensam innan vårdnadshavare anlänt.

➡ Sökande skall snarast läkarbedömas.

➡ Ta ställning till behov av att tillkalla väktare/polis.

➡ Om sökande är ensam ring in vårdnadshavare. Sökande bör ej placeras ensam innan vårdnadshavare anlänt.

➡ Sökande skall snarast läkarbedömas.

➡ Om sökande är ensam ring in vårdnadshavare. Sökande bör ej lämnas ensam innan vårdnadshavare anlänt.

➡ Sökande skall läkarbedömas.

Överväg Alkometer, U-tox, AUDIT samt DUDIT

Tillgodose stimulifattig miljö.

Avgränsa omvårdnadssamtalet, anamnes tas med fördel av vårdnadsgivare.

- Ångest F41.9

Förberedande åtgärder

- Farlighetsbedömning och suicidriskbedömning

Röda symtom

Orange symtom

- Dissociation (överklighetskänsla beträffande sin identitet eller omgivning)
- Psykomotorisk oro (oroligt beteende, rastlöshet)
- Pågående affektlabilitet med anamnes på självskadebeteende

Gula symtom

- Pågående affektlabilitet
- Pågående panikattack
- Tvångstankar och/eller tvångshandlingar som avsevärt begränsar vardagliga/basala aktiviteter
- Ångest/oro som avsevärt begränsar vardagliga/basal aktiviteter

Gröna symtom

- Förekomst av oro och/eller ångest
- Förekomst av tvångstankar och/eller tvångshandlingar

Blåa symtom

RETTS processåtgärder

➡ Om sökande är ensam ring in vårdnadshavare. Sökande skall ej placeras ensam innan vårdnadshavare anlänt.

➡ Gör en omtriagering när ångesten har lagt sig, om sökande då fortfarande är orange skall hen läkarbedömas.

➡ Om sökande är ensam ring in vårdnadshavare. Sökande bör ej placeras ensam innan vårdnadshavare anlänt.

➡ Sökande kan efter sjuksköterskebedömning samt konsultation med jourhavande läkare återgå till hemmet med en planering kring rekommenderad fortsatt vårdkontakt.

➡ Om sökande är ensam ring in vårdnadshavare. Sökande bör ej lämnas ensam innan vårdnadshavare anlänt.

➡ Sökande kan efter sjuksköterskebedömning samt konsultation med jourhavande läkare återgå till hemmet med en planering kring rekommenderad fortsatt vårdkontakt.

Överväg Alkometer, U-tox, AUDIT samt DUDIT

- Farlighetsbedömning, se även ESS 198
- Samtidig dyspné, se även ESS 104
- Samtidig bröstsmärta, se även ESS 105
- Suicidriskbedömning, se även ESS 199

RETTS faktaruta

Överväg alltid om det kan finnas bakomliggande somatisk orsak.

Använd somatisk ESS i kombination vid somatiska symtom.

Ångest/oro kan begränsa patientens funktionsnivå, särskilt paniksyndrom, social fobi och tvångssyndrom. Samtliga tillstånd kan leda till sekundära mer ihållande ångestsymtom och sömnstörningar. Inte sällan utvecklar patienten även lätta till måttliga depressiva symtom. Panikattack är en vanlig orsak till akutbesök. Patienten upplever stort obehag då symtomen debuterar till synes utan orsak inom några minuter och går över av sig självt efter en stund. Symtom som upplevs är hjärtklappning, svettning, darning/skakning, hyperventilation, kvävningsskänsla, smärta eller obehag i bröstet/magen, rädsla att tappa kontrollen eller "bli tokig" samt dödsskräck. Bröstsmärtor som liknar hjärtinfarkt är inte ovanligt. Alla ångestsyndrom kan ge panikattacker men långvariga ångesttillstånd utan panikattacker är också en sökorsak.

Social fobi innebär en rädsla för att exponera sig i olika sammanhang och att framträda inför andra. Det är socialt handikappande och patienten anpassar sitt liv efter symtomen vilket medför nedsatt funktionsnivå och tendens till isolation.

Tvångssyndrom innefattar tvångstankar och -handlingar.

Tvångstankar är påträngande, ofrivilliga tankar.

Tvångshandlingar görs medvetet för att minska obehaget av tvångstankarna eller för att förhindra en katastrof. De kan vara synliga utåt eller upplevas som mentala tankerituler. Detta är vanligt i befolkningen men vid tvångssyndrom är de svåra att stå emot, ger ett stort lidande och upptar mycket tid för patienten.

Missbruk/abstinens är en viktig differentialdiagnos och samtidig förekomst är mycket vanligt.

- Sömnstörning G47.9

Förberedande åtgärder

- Farlighetsbedömning och suicidriskbedömning

Röda symtom

Orange symtom

Gula symtom

- Overklighetskänsla
- Psykomotorisk oro (oroligt beteende, rastlöshet)
- Pågående affektlabilitet

Gröna symtom

- Asteni (trötthet/uttröttbarhet, irritabilitet) som begränsar vardagliga/basala aktiviteter
- Koncentrationssvårigheter

Blåa symtom

RETTS processåtgärder



Om sökande är ensam ring in vårdnadshavare. Sökande bör ej placeras ensam innan vårdnadshavare anlant.



Sökande skall läkarbedömas.



Om sökande är ensam ring in vårdnadshavare. Sökande bör ej lämnas ensam innan vårdnadshavare anlant.



Sökande kan efter sjuksköterskebedömning samt konsultation med jourhavande läkare återgå till hemmet med en planering kring rekommenderad fortsatt vårdkontakt.

Överväg Alkometer, U-tox, AUDIT samt DUDIT

- Farlighetsbedömning, se även ESS 198
- Suicidriskbedömning, se även ESS 199

RETTS faktaruta

Överväg alltid om det kan finnas bakomliggande somatisk orsak.

Använd somatisk ESS i kombination vid somatiska symtom.

Sömnstörning är vanlig vid de flesta psykiska och somatiska sjukdomar samt vid belastande/stressfyllda livsbetingelser. Hypersomni innebär onormal trötthet vilket visar sig i förlängd nattsöm, uttalad trötthet dagtid, eller behov av att sova dagtid. Hyposomni innebär förkortad sömntid vilket kan inkludera svårigheter att somna, orolig yttlig sömn med frekventa uppvaknanden samt tidigt uppvaknande. Alkohol- och drogmissbruk kan vara en orsak till sömnstörning. Mardrömmar kan ingå i symtombilden vid posttraumatiskt stressyndrom, varför det är viktigt att fråga om ev. upplevda trauman. Observera att antidepressiva, särskilt SSRI, ofta är en annan orsak. Omfattande anamnes är av stor vikt för att utesluta bakomliggande orsaker. Långvarig sömnstörning kan ge symtom på ångest och nedstämdhet.

- Psykotiska symtom F23.0

Förberedande åtgärder

- Farlighetsbedömning och suicidriskbedömning

Röda symtom

Orange symtom

- Attackerar föremål
- Fysiskt hotfullt beteende
- Snabbt växlande humör
- Verbalt hotfullt beteende

Gula symtom

- Bristande sjukdomsinsikt
- Bullrigt beteende
- Desorganiserat tal/beteende
- Hallucinationer, vanföreställningar eller tankestörningar
- Psykomotorisk oro (oroligt beteende, rastlöshet)
- Pågående affektlabilitet

Gröna symtom

- Långvarigt pågående vanföreställningar, negativa symtom /hallucinationer

Blåa symtom

RETTS processåtgärder

➡ Om sökande är ensam ring in vårdnadshavare. Sökande skall ej placeras ensam innan vårdnadshavare anlärt.

➡ Sökande skall snarast läkarbedömas.

➡ Ta ställning till behov av att tillkalla väktare/polis.

➡ Om sökande är ensam ring in vårdnadshavare. Sökande bör ej placeras ensam innan vårdnadshavare anlärt.

➡ Sökande skall snarast läkarbedömas.

➡ Om sökande är ensam ring in vårdnadshavare. Sökande bör ej lämnas ensam innan vårdnadshavare anlärt.

➡ Sökande skall läkarbedömas.

- Farlighetsbedömning, se även ESS 198
- Förgiftning, se även ESS 140
- Suicidriskbedömning, se även ESS 199

RETTS faktaruta

Överväg alltid om det kan finnas bakomliggande somatisk orsak.

Använd somatisk ESS i kombination vid somatiska symtom.

Störd verklighetsuppfattning är vanligt förekommande vid psykosjukdomar, affektiva tillstånd, autismspektrumtillstånd, utvecklingsstörning och missbruk. Den kan förekomma i form av hallucinos (hörsel-, syn-, lukt-, smak-, taktil) eller vanföreställningar. Social isolering, rädsla, undandragande från studier en längre tid, svårbegripliga känsloutbrott med udda framtoning, ändrad dygnsrytm/sömnlängd, tankestörning, talstörning, samt tilltagande udda och märkliga beteenden kan ingå i symtombilden vid en psykos. Hörselhallucinationer hos barn är ofta imperativa (befallande) och kan ha samtidiga syn- eller känselhallucinationer.

Även negativa symtom som avflackade affekter, motivationsstörning, nedsatt lust, energilöshet, inåtvändhet och torftig emotionell kontakt kan finnas. Hos unga ser man dessutom ofta en kognitiv funktionsnedsättning. Osammanhängande tal, katatoni (påverkan på motoriken; orörlig eller agiterad) kan ibland ses i akuta situationer.

Samsjuklighet med missbruk är vanligt och ger mer allvarliga psykotiska symtom. Droginducerad psykos förekommer ofta hos yngre, misstänk särskilt internetdroger. Var uppmärksam på tecken på cerebral påverkan eller kroppslig sjukdom. Långvarigt alkoholmissbruk kan ge bestående alkoholhallucinos.

Vid nydebuterad sjukdomsbild är anamnesen viktig och bör vara omfattande.

- Missbruk/beroende F10-17

Förberedande åtgärder

- Farlighetsbedömning och suicidriskbedömning

Röda symtom**Orange symtom**

- Attackerar föremål
- Fysiskt hotfullt beteende
- Snabbt växlande humör
- Verbalt hotfullt beteende

Gula symtom

- Abstinenssymtom med somatiska symtom
- Bristande emotionell kontakt
- Bullrigt beteende
- Retligt/lättirriterat beteende
- Psykomotorisk oro (oroligt beteende, rastlöshet)
- Pågående affektlabilitet

Gröna symtom

- Missbruk som begränsar vardagliga/basala aktiviteter
- Önskemål om avgiftning/abstinensbehandling med alkohol /substanspåverkan utan allvarigare symtom

Blåa symtom

- Farlighetsbedömning, se även ESS 198
- Förgiftning, se även ESS 140
- Suicidriskbedömning, se även ESS 199

RETTS faktaruta

Överväg alltid om det kan finnas en bakomliggande somatisk orsak.

Använd somatisk ESS i kombination vid somatiska symtom.

Missbruk är vanligt bland ungdomar som söker BUP akut. De vanligaste substanserna är alkohol, cannabis och opioider, ffa opioidanalgetika, t.ex. Tramadol. Samsjuklighet beträffande substansbruksyndrom och andra psykiatriska tillstånd är vanligt, bland annat hos patienter med affektiv sjukdom, ADHD och ångestsyndrom. Vid samsjuklighet finns ibland ett ökat inläggningsbehov. Det är viktigt att även efterhöra somatisk ohälsa och andra substanser.

Alkoholintoxikerade ungdomar skall först till barnakuten för bedömning. BUP-patienterna är sällan abstinenta av sådan grad att inläggande vård på BUP behövs. Svår abstinens ska leda till ställningstagande till förstärkt abstinensbehandling, krampprofylax och vitaminsubstitution. Abstinensepilepsi är sällsynt bland barn och ungdomar. Finns epilepsi i anamnesen skall krampprofylax initieras.

Cannabisintoxikerade patienter behöver sällan heldygnsvård på BUP, men slutenvård kan bli aktuell vid samsjuklighet, som t.ex. positiva psykostecken eller affektiv sjukdom med förhöjd suicidrisk. Cannabisabstinens (irritabilitet, sömnstörning och ångest) är aldrig livshotande men vid svår grad kan läkemedelsbehandling vara motiverat.

Patienter som inkommer med en opioidintoxikation skall bedömas på barnakuten. Opioidabstinens kan vara utmanande för patienten men är inte livshotande. Vid svår opioidabstinens och samsjuklighet kan heldygnsvård inom BUP bli aktuell.

RETTS processåtgärder

➡ Om sökande är ensam ring in vårdnadshavare. Sökande skall ej placeras ensam innan vårdnadshavare anlänt.

➡ Sökande skall snarast läkarbedömas.

➡ Ta ställning till behov av att tillkalla väktare/polis.

➡ Om sökande är ensam ring in vårdnadshavare. Sökande bör ej placeras ensam innan vårdnadshavare anlänt.

➡ Sökande skall läkarbedömas.

➡ Om sökande är ensam ring in vårdnadshavare. Sökande bör ej lämnas ensam innan vårdnadshavare anlänt.

➡ Sökande kan efter sjuksköterskebedömning samt konsultation med jourhavande läkare återgå till hemmet med en planering kring rekommenderad fortsatt vårdkontakt.

➡ Sökande bör erbjudas läkarbedömning vid önskemål om avgiftning.

Överväg Alkometer, U-tox, AUDIT samt DUDIT

Överväg att uppdatera vitalparametrar. Obs ta ställning till Retts psy processåtgärd 85, intervall kollas mot barn

Genomför omvårdnadssamtal.

Orosanmälan socialtjänst

Överväg remiss till beroendeenhet

- Ätstörning F50

Förberedande åtgärder

- Farlighetsbedömning och suicidriskbedömning
- BMI

Röda symtom

Orange symtom

- Kall perifert/perifera ödem

Gula symtom

- BMI <14
- Försämrade kognitiv funktion p.g.a. svältpåverkan
- Ohållbar hemsituation relaterat till ätstörning
- Prägad av anorektiskt tankeinnehåll och beteende
- Snabbt eskalerande viktras

Gröna symtom

- Behov av att bryta recidiv av ätstörning
- BMI 14-17,5
- Hetsätning med/utan efterföljande självrensning
- Trötthetskänslor

Blåa symtom

RETTS processåtgärder

- | | |
|--|--|
| ➔ Patienten skickas akut till somatiken för bedömning | ➔ Om sökande är ensam ring in vårdnadshavare. Sökande bör ej lämnas själv innan vårdnadshavare anlät |
| ➔ Om sökande är ensam ring in vårdnadshavare. Sökande bör ej lämnas själv innan vårdnadshavare anlät | ➔ Sökande kan efter sjuksköterskebedömning samt konsultation med jourhavande läkare återgå till hemmet med en planering kring rekommenderad fortsatt vårdkontakt |
| ➔ Sökande skall läkarbedömas | |

Mät alltid blodtryck i liggande och stående

- Farlighetsbedömning, se även ESS 198
- Suicidriskbedömning, se även ESS 199

RETTS faktaruta

Överväg alltid om det kan finnas bakomliggande somatisk orsak.

Använd somatisk ESS i kombination vid somatiska symtom.

Anorexia nervosa (AN) och bulimia nervosa (BN) kännetecknas av en fixering vid kroppsform och vikt, vilket ger upphov till växtfobi d.v.s. uttalad rädsla att öka i vikt även om man är underviktig. Detta resulterar i bantning/svält och/eller hetsätning med kompensatoriskt beteende.

Vid AN ska individen ha en avsiktligt låg vikt, som är mindre eller lika med 85% av vad som anses normalt med avseende på ålder och längd ($BMI \leq 17,5$). Till sjukdomen hör även störd kroppsuppfattning, dvs att man t ex upplever sig överviktig även om man är gravt underviktig. Ett viktigt symtom på AN är amenorré men det är inget diagnoskriterie.

$BMI = \text{vikt} / \text{längd}^2$ (kg / M x M) ex: $82 \text{ kg} / (1,82 \times 1,82) = 24,75$
Kvoten = BMI

BN kännetecknas av hetsätning med kontrollförlust, dvs under en begränsad tidsperiod äter man en betydligt större mängd mat än vad som anses normalt. Ett kompensatoriskt beteende finns alltid t ex genom självrensning (kräkning/laxering) eller genom svält och överdriven motionering.

Både AN och BN ger upphov till såväl psykiska som fysiska komplikationer samt har hög komorbiditet i form av depression, tvångssyndrom, missbruk, social fobi, autism samt emotionell instabilitet.

- Krisreaktion F43
- Reaktion på svår stress F43

Förberedande åtgärder

- Farlighetsbedömning och suicidriskbedömning

Röda symtom**Orange symtom**

- Aktuell allvarlig suicidhandling
- Attackerar föremål
- Berusad/intoxikerad
- Dissociativa symtom (överklighetskänsla, känna sig bortkopplad)
- Fysiskt hotfullt beteende
- Snabbt växlande humör
- Suicidala planer eller avsikter
- Verbalt hotfullt beteende

Gula symtom

- Bristande emotionell kontakt
- Bullrigt beteende
- Nyligen utförd suicidhandling
- Psykomotorisk oro (oroligt beteende, rastlöshet)
- Pågående affektlabilitet
- Retligt /lättirriterat beteende
- Suicidtänkar

Gröna symtom

- Dödstänkar
- Dödsönskan
- Isoleringens tendens
- Koncentrationssvårigheter
- Tidigare suicidförsök

Blåa symtom

- Farlighetsbedömning, se även ESS 198
- Suicidriskbedömning, se även ESS 199

RETTS faktaruta

Överväg alltid om det kan finnas bakomliggande somatisk orsak.

Använd somatisk ESS i kombination vid somatiska symtom.

Ett flertal psykiatriska sjukdomstillstånd kan utvecklas som reaktion på akut eller subakut stress (i olika former). Akut stressreaktion, posttraumatiskt stressyndrom, anpassningsstörning samt utmattningsyndrom är vanliga orsaker till kontakt med akutmottagning. Gemensamt för alla tillstånd är att yttre faktorer, en traumatisk händelse i bred mening, upplevs överväldigande och försätter patienten i ett tämligen hjälplöst tillstånd med rädsla, skräck, ångest, oro, nedstämdhet och beteendestörningar. Personen kan reagera med intensiv rädsla, hjälplöshet eller skräck särskilt vid händelser som innebär död och allvarlig skada mot egen eller andras/närståendes fysiska/psykiska integritet. En "normal akut stressreaktion" brukar avta inom 48 timmar. Ibland kan dock symtomen kvarstå längre än så.

RETTS processåtgärder

➡ Om sökande är ensam ring in vårdnadshavare. Sökande skall ej placeras ensam innan vårdnadshavare anlänt.

➡ Patienten skall snarast läkarbedömas.

➡ Tag ställning till om väktare/polis skall kallas in.

➡ Om sökande är ensam ring in vårdnadshavare. Sökande bör ej placeras ensam innan vårdnadshavare anlänt.

➡ Sökande skall läkarbedömas.

➡ Om sökande är ensam ring in vårdnadshavare. Sökande bör ej lämnas ensam innan vårdnadshavare anlänt.

➡ Sökande kan efter sjuksköterskebedömning samt konsultation med jourhavande läkare återgå till hemmet med en planering kring rekommenderad fortsatt vårdkontakt.

Överväg Alkometer, U-tox, AUDIT samt DUDIT

Påverkan av alkohol/droger bör innebära en förhöjning i triagefärg relaterat till impulsivitet.

- Psykisk ohälsa F99.9

Förberedande åtgärder

- Farlighetsbedömning och suicidriskbedömning

Röda symtom

Orange symtom

- Berusad/intoxikerad
- Desorientering/konfusion
- Påtagligt försämrat minne, språkstörning, nedsatt motorisk förmåga

Gula symtom

- Försämrat minne, språkstörning, försämrat motorisk förmåga
- Psykomotorisk oro (oroligt beteende, rastlöshet)
- Pågående affektlabilitet

Gröna symtom

- För omgivningen tydligt avvikande beteende, nedsatt omdöme och insikt

Blåa symtom

RETTS processåtgärder



Sökande skall omedelbart överföras till somatisk vårdinrättning för bedömning och omhändertagande



Om sökande är ensam ring in vårdnadshavare. Sökande bör ej lämnas ensam innan vårdnadshavare anlät.



Sökande skall läkarbedömas.



Om sökande är ensam ring in vårdnadshavare. Sökande bör ej lämnas ensam innan vårdnadshavare anlät.



Sökande kan efter sjuksköterskebedömning samt konsultation med jourhavande läkare återgå till hemmet med en planering kring rekommenderad fortsatt vårdkontakt.

Alkometer och/eller U-tox vid misstanke om drogpåverkan.

Påverkan av alkohol/droger bör innebära en förhöjning i triagefärg relaterat till impulsivitetsökning.

- Farlighetsbedömning, se även ESS 198
- Suicidriskbedömning, se även ESS 199

RETTS faktaruta

Överväg alltid om det kan finnas bakomliggande somatisk orsak.

Använd somatisk ESS i kombination vid somatiska symtom.

Vid besök på akutmottagning finns inte alltid en fastställd psykiatrisk orsak/diagnos. Patienter/anhöriga kan söka för symtom som minnesstörning, språkstörning, störning av motorisk förmåga, desorientering/konfusion, oro, rastlöshet, affektlabilitet, avvikande beteende och nedsatt omdöme/insikt. Om dessa symtom inte passar in i övriga psykiatriska algoritmer finns en risk för somatisk bakomliggande orsak, utan att det visar sig i mätbara parametrar på psykiatrisk akutmottagning. Orsakerna kan t ex vara en infektion i nervsystemet, hjärntumör, blödning /blodpropp i hjärnan, systemisk sjukdom eller epilepsi. Patienten bör därför bedömas på en somatisk akutmottagning.

Vid misstanke om att barn far illa är sjukvårdspersonal skyldig att anmäla detta till socialtjänsten. Vid misstanke om att barnet far illa, se ESS 142 för ytterligare vägledning.

Många intoxicationer kan uppträda under denna kontaktorsak.

ESS-Vägledning:

Det är viktigt att inte slentrianmässigt använda denna sökorsak. Ofta finns det potentiellt allvarliga bakomliggande faktorer.

- Ej akut psykiatrisk problematik

Förberedande åtgärder

- Farlighetsbedömning och suicidriskbedömning

Röda symtom**Orange symtom****Gula symtom****Gröna symtom**

- Ej akut - övrig psykiatrisk problematik

Blåa symtom

- Ex. lindrig psykisk ohälsa som inte uppfyller kriterier inom övriga psykiatriska sökorsaker
- Enbart social problematik
- Opåverkade vitalparametrar
- Opåverkat allmäntillstånd
- Önskemål om recept/läkemedel/intyg
- Önskemål om samtalsstöd som inte uppfyller kriterier för psykiatrisk akutvård

RETTS processåtgärder

Vid hänvisning av patient till primärvård, psykiatrisk öppenvård eller socialtjänst SKALL tillräckligt beslutsunderlag finnas till grund för bedömning. Läkare SKALL konsulteras. Patienten har rätt att träffa jourläkare men skall ges tydliga instruktioner avseende väntetid till läkarbedömning.

- Farlighetsbedömning, se även ESS 198
- Suicidriskbedömning, se även ESS 199

RETTS faktaruta

Patienter som inkommer till en psykiatrisk akutmottagning utgör en heterogen patientgrupp där det kan vara svårt att bedöma det aktuella vårdbehovet. Därför kommer alla sökande att genomgå triagebedömning. Vid hänvisning av patient till primärvård, psykiatrisk öppenvård, annan akutmottagning eller socialtjänst SKALL tillräckligt beslutsunderlag finnas till grund för bedömningen. Läkare SKALL konsulteras. Patienten har rätt att träffa jourläkare men skall ges tydliga instruktioner avseende väntetid till läkarbedömning.

- Organisk katatoni F06.1

Förberedande åtgärder

- Farlighetsbedömning och suicidriskbedömning

Röda symtom

- Dehydrering
- Hypertermi
- Mutism eller stupor

Orange symtom

- Automatisk lydnad
- Ekolali (upprepning av andras ord)
- Ekopraxi (imitation av andras rörelser)
- Konfusion
- Muskelrigiditet
- Stereotypier (enkla upprepade rörelser)
- Vaxliknande böjlighet

Gula symtom**Gröna symtom****Blåa symtom****RETTS processåtgärder**

➡ Sökande skall omedelbart överföras till somatisk vårdinrättning för bedömning och omhändertagande.

➡ Om sökande är ensam ring in vårdnadshavare. Sökande skall ej lämnas ensam innan vårdnadshavare anlät.

➡ Patienten skall snarast läkarbedömas.

Var noggrann med vitalparametrar.

Ett övergripande omvårdnadssamtal kan genomföras med förälder alt. patient inför läkarbedömning.

- Farlighetsbedömning, se även ESS 198
- Suicidriskbedömning, se även ESS 199

RETTS faktaruta

Katatoni är ett ovanligt men allvarligt sjukdomstillstånd som kan uppkomma vid schizofreni, affektiva tillstånd, toxiska tillstånd (SSRI, neuroleptika) och somatisk sjukdom.

De vanligaste symtomen och tecknen är de som beskrivs i röd och orange ruta.

Tillståndet är livshotande och behandling av dehydrering och hypertermi är viktiga tidigt i förloppet.

- Beteendestörning av utagerande slag F91
- Farlighetsbedömning AU122

Förberedande åtgärder

- Suicidriskbedömning

Röda symtom

- Pågående aktivt våldsam / pågående attack mot person eller djur

Orange symtom

- Allvarlig våldshandling senaste 7 dagarna
- Attackerar föremål/person
- Fysiskt hotfullt beteende
- Snabbt växlande humör
- Verbalt hotfullt beteende

Gula symtom

- Avvisande i kontakten
- Bullrigt beteende
- Förvirrat/desorienterat beteende
- Retligt/lättirriterat beteende
- Utförd våldshandling från 7 dagar till 3 månader

Gröna symtom

- Avklingat utagerande beteende
- Tidigare våldsam beteende (äldre än 3 månader)

Blåa symtom

RETTS processåtgärder

- Förgiftning, se även ESS 140
- Suicidriskbedömning, se även ESS 199

RETTS faktaruta

Överväg alltid om det kan finnas bakomliggande somatisk orsak.

Använd somatisk ESS i kombination vid somatiska symtom.

Utagerande beteende är en vanlig sökorsak på BUP. Vanliga bakomliggande tillstånd är bl. a (diagnosticerad/odiagnosticerad) autism, ADHD, intellektuell utvecklingsstörning, akut stress, övrig ångest m.fl. Vid autism kan det ofta vara, för andra, bagatellartade händelser som leder till oförståeligt kraftigt utagerande beteende. Impulsivitet är en annan riskfaktor för utagerande, liksom övrig emotionell instabilitet. Utagerande beteende leder ofta till affektsmitta och ett lågaffektivt bemötande är av största vikt för att dämpa beteendet. Säkerheten för både patient, anhöriga och personal måste också tas i beaktande. Att försöka ta reda på om någon känd bakomliggande orsak och ev. sedan tidigare ordinerade läkemedel finns, kan underlätta bemötandet och behandlingen av beteendet.

Statistiska riskfaktorer

Man

16-25år

Missbruk/beroende av alkohol/droger

Psykostillstånd (schizofreni, vanföreställningssyndrom, manisk episod)

Emotionell instabilitet, antisociala drag

Övriga psykiatriska diagnoser (Aspergers syndrom, utvecklingsstörning, hjärnskada, neurologiska sjukdomar??)

Tidigare beteendestörning före 16 års ålder (uppförandestörning, antisocialt beteende)

Impulsivitet??

Tidigare kriminalitet

Tidigare aggressivitet/våld (hot, ofredande, misshandel, dråp, mord)

Viktimisering* senaste året

*Ett samlingsnamn för olika typer av övergrepp som en person kan utsättas för. Övergreppen kan vara fysiska, psykiska, sociala, sexuella eller ekonomiska,

Aktuella sociala problem

Skolrelaterade (skolfrånvaro, konflikter i skolan)

Bostadslös (tillfälligt eller permanent)

Relationsproblem (separation, förlust)

Ekonomiska

Andra stressorer (upplevd kränkning)

LVU/LVM/HVB/Familjehem/Jourhem??

Aktuell psykiatrisk problematik

Avvikelse från vårdplan hos känd patient (uteblivna besök, bristande compliance till läkemedelsbehandling)

Tankar/röster om att skada någon

Upplevt hot mot den egna personen

Agerar utifrån psykossymtom (vanföreställningar, hallucinos)

Bristande sjukdomsinsikt

Negativ attityd
Bristande emotionell kontakt
Agiterade beteenden (irritabilitet, agitation, rastlöshet, bullrigt el.
gravt avvikande beteende)
Alkohol-/drogpåverkan
Abstinens alkohol-/drogpåverkan
Tidigare känt samband med våldshandlingar
Förvirrat/desorienterat beteende

- Självskadebeteende F91.9
- Suicidriskbedömning AU118

Förberedande åtgärder

- Farlighetsbedömning

Röda symtom

- Pågående/Omedelbar suicidal handling

Orange symtom

- Akut eskalerande självskadebeteende
- Allvarlig suicidhandling senaste 7 dagarna
- Attackerar föremål
- Berusad/intoxikerad
- Fysiskt hotfullt beteende
- Impulsivitet
- Psykomotorisk oro (oroligt beteende, rastlöshet)
- Snabbt växlande humör
- Suicidala avsikter eller planer
- Verbalt hotfullt beteende

Gula symtom

- Blödning (färsk sårskada, se även skadekort)
- Bristande emotionell kontakt
- Bullrigt beteende
- Nyttillkomna/förvärrade suicidtankar
- Retligt/lättirriterat beteende
- Pågående affektlabilitet
- Suicidtankar
- Utförd suicidhandling från 7 dagar till 3 månader

Gröna symtom

- Dödstankar
- Dödsönskan
- Kroniska suicidtankar utan försämring
- Självskadebeteende utan aktuell självskadehandling
- Suicidförsök tidigare än 3 månader

Blåa symtom

- Blödning - självskadebetingad, se även ESS 132
- Farlighetsbedömning se även ESS 198
- Förgiftning se även ESS 140

RETTS faktaruta

Överväg alltid om det kan finnas bakomliggande somatisk orsak. Använd somatisk ESS i kombination vid somatiska symtom.

Vanvård:

Vid misstanke om att barn far illa är sjukvårdspersonal skyldig att anmäla detta till socialtjänsten och i vissa fall polismyndigheten.

Personen utsätter avsiktligt sin kropp för skada exempelvis genom att skära eller bränna sig själv. Orsaken till beteendet är inte alltid tydligt för den som utför handlingen. Självskadebeteenden är mycket sällan försök att ta sitt liv. Den yttersta funktionen som skadandet fyller är att hantera övermäktiga känslor. Känslor som kan beskrivas som fritt flytande ångest som lindras eller blir mer uthärdlig då den ersätts av kroppslig smärta. I bilden ingår ofta impulsivitet. Självskadebeteende är ett vanligt symtom vid tillstånd med emotionell instabilitet, t. ex ADHD, autismspektrumtillstånd, efter trauma samt vid andra ångesttillstånd. Påverkan av alkohol eller bensodiazepiner ökar risken för självskada då dessa droger minskar tröskeln för impulsivitet. Vid triagering är det av stor vikt att patienten tillfrågas om anledningen till självskadebeteendet samt tillvägagångssätt och omfattning. Uppgifter om tidigare självskadebeteende ska alltid efterfrågas.

Impulsiva patienter kan göra allvarliga suicidförsök trots att de inte har medvetna dödsönskningar/suicidtankar. Patienter med antisociala/manipulativa personlighetsdrag kan uttala hot om suicid i syfte att få sina krav uppfylla, i dessa fall är ej suicidstegen tillämplig.

Statistiska riskfaktorer:

Tidigare suicidförsök
Psykisk sjukdom och dess svårighetsgrad/fas/samsjuklighet
Missbruk/beroende
Hög ångestnivå/tankestörning/psykotiskt tänkande oavsett grundsjukdom
Tidigare eller aktuell aggressivitet, impulsivitet
Somatisk sjukdom
Upplevt trauma
Ensamboende utan relationer
Reaktion på akut livshändelse/separation/dödsfall/ kränkning
Suicidredskap finns tillgängligt
Ålder (<19)
Kön (man)

Akut utlösande faktorer:

Akut påverkad/abstinens eller nyligen tagit överdos
Sömnstörning
Svår fysisk smärta
Kränkning/skam (självakttningsproblem)
Förlust/hot om förlust
Utskrivning från psykiatrisk vård
Återgång i skola/hemmasittare

RETTS processåtgärder

➡ Om sökande är ensam ring in vårdnadshavare. Sökande skall ej lämnas ensam innan vårdnadshavare anlänt. Tag ställning till om vårdnadshavare kan lämnas ensam med patienten.

➡ Sökande skall snarast läkarbedömas.

➡ Tag ställning till om väktare/polis behöver tillkallas.

➡ Om sökande är ensam ring in vårdnadshavare. Sökande bör ej lämnas ensam innan vårdnadshavare anlänt.

➡ Sökande skall läkarbedömas.

➡ Om sökande är ensam ring in vårdnadshavare. Sökande bör ej lämnas ensam.

➡ Sökande kan efter sjuksköterskebedömning samt konsultation med jourhavande läkare återgå till hemmet med en planering kring rekommenderad fortsatt vårdkontakt.

Rengöring och omläggning av eventuella ytliga sårskador.

Överväg Alkometer, U-tox, AUDIT samt DUDIT

"Smittorisk" när det nyligen skett suicid i nära omgivning
Inskrivning till psykiatrisk vård kan utlösa suicidhandling

Skyddande faktorer:

Personell resurs t ex god problemlösningssförmåga

Samtalskontakt

Nätverkets resurs, anhöriga, vänner, tillhörighet